

Buku Ajar
**PSIKOLOGI DALAM PRAKTIK
KEBIDANAN**

Agriyaningsih Oktaviana H • Dwi Ardani Rochmaniah • Emi Br Barus
Uliyatul Laili • Rina • Asima Lamtiar Hotnauli Pakpahan
Wahyu Nindi Sayekti • Fitria Jannatul Laili • Eny Siswati
lin Tri Marlinawati



BUKU AJAR

PSIKOLOGI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Penulis:

Bdn. Agriyaningsih Oktaviana H, S.Tr.Keb., M.Keb.

Dwi Ardani Rochmaniah, SST., M.Keb.

Bdn. Emi Br Barus, S.ST., M.Keb.

Uliyatul Laili, SST., Bdn., M.Keb.

Rina, SST., M.Tr.Keb.

Asima Lamtiar Hotnauli Pakpahan, S.Tr.Keb., M.Keb.

Wahyu Nindi Sayekti, S.ST., M.Keb.

Fitria Jannatul Laili, S.Keb., Bd., M.M., M.Keb.

Bdn. Eny Siswati, SST., M.Si.

lin Tri Marlinawati, S.Tr. Keb., MPH., M.Keb.



BUKU AJAR PSIKOLOGI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Penulis: Bdn. Agriyaningsih Oktaviana H, S.Tr.Keb., M.Keb.

Dwi Ardani Rochmaniah, SST., M.Keb.

Bdn. Emi Br Barus, S.ST., M.Keb.

Uliyatul Laili, SST., Bdn., M.Keb.

Rina, SST., M.Tr.Keb.

Asima Lamtiar Hotnauli Pakpahan, S.Tr.Keb., M.Keb.

Wahyu Nindi Sayekti, S.ST., M.Keb.

Fitria Jannatul Laili, S.Keb., Bd., M.M., M.Keb.

Bdn. Eny Siswati, SST., M.Si.

lin Tri Marlinawati, S.Tr. Keb., MPH., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-02-9

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar berjudul Psikologi dalam Praktik Kebidanan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons terhadap pentingnya penguatan pemahaman mahasiswa kebidanan dalam aspek psikologis selama masa reproduksi, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga proses adaptasi menjadi orang tua. Materi dalam buku ini dirancang secara sistematis dan aplikatif untuk mendukung proses pembelajaran dan praktik kebidanan yang humanis, berbasis bukti, serta sensitif terhadap kondisi psikososial ibu dan keluarga.

Buku ini terdiri atas sepuluh bab yang mencakup topik-topik esensial seperti psikologi masa reproduksi, kesehatan mental perinatal, dukungan interprofesional, manajemen trauma, hingga tren dan isu psikologi kontemporer dalam praktik kebidanan. Setiap bab disusun dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan, serta dilengkapi dengan latihan soal, glosarium, dan rangkuman materi untuk memudahkan proses pemahaman dan refleksi mahasiswa. Penekanan pada pendekatan edukatif, empatik, serta kesadaran budaya dalam menghadapi masalah kesehatan mental juga menjadi kekuatan utama buku ini.

Kami berharap buku ajar ini tidak hanya menjadi sumber belajar teoritis, tetapi juga menjadi panduan praktis bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam memberikan asuhan yang menyeluruh dan bermakna bagi ibu dan keluarganya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, termasuk para narasumber, editor, dan tim penyusun. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PSIKOLOGI PADA MASA REPRODUKSI	1
A. Psikologi pada masa reproduksi.....	2
B. Psikologi dalam siklus reproduksi.....	3
C. Psikologi dan komunikasi ibu dan bayi	11
D. Adaptasi menjadi orang tua	11
E. Bonding attachment and bonding aattunement.....	14
F. Latihan.....	16
G. Rangkuman Materi.....	18
H. Glosarium	18
I. Daftar Pustaka	19
BAB 2 DUKUNGAN PADA PENGASUHAN DAN PERAN MENJADI ORANG TUA, KERJASAMA DAN KOMUNIKASI INTERPROFESIONAL DALAM PENANGANAN MASALAH KESEHATAN MENTAL DENGAN MEMPERHATIKAN KESELAMATAN PASIEN	21
A. Dukungan pada Pengasuhan dan Peran Menjadi Orang Tua	23
B. Kerjasama dan Komunikasi Interprofesional dalam Penanganan Masalah Kesehatan Mental	25
C. Latihan Soal	27
D. Rangkuman Materi.....	30
E. Glosarium	30
F. Daftar Pustaka	33
BAB 3 KESEHATAN MENTAL PADA PERINATAL: MASALAH KESEHATAN MATERNAL, KESEHATAN MENTAL PERINATAL	35
A. Masalah Kesehatan Maternal.....	37
B. Kesehatan Mental Perinatal	38
C. Latihan Soal	41
D. Rangkuman Materi.....	43
E. Glosarium	44

F. Daftar Pustaka	46
 BAB 4 KESEHATAN MENTAL PADA PERINATAL: MASALAH KESEHATAN PADA PERINATAL, PENCEGAHAN DAN PENANGANANNYA, MANAJEMEN PADA RISIKO BUNUH DIRI DAN KEKERASAN OLEH PASANGAN 47	
A. Masalah Kesehatan Mental pada Perinatal	49
B. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Mental Perinatal.....	51
C. Manajemen Risiko Bunuh Diri dan Kekerasan oleh Pasangan	53
D. Latihan Soal	56
E. Rangkuman Materi.....	58
F. Gloasrium	59
G. Daftar Pustaka	61
 BAB 5 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TRAUMA: DEFINISI TRAUMA, TRAUMA SELAMA PROSES KEHAMILAN SAMPAI POST PARTUM..... 63	
A. Definisi Trauma	65
B. Trauma selama Proses Kehamilan sampai Postpartum.....	66
C. Pencegahan Trauma dalam Praktik Kebidanan	69
D. Penanganan Trauma dalam Praktik Kebidanan.....	71
E. Latihan Soal	73
F. Rangkuman Materi.....	75
G. Glosarium	76
H. Daftar Pustaka	78
 BAB 6 KESEHATAN MENTAL PADA PERINATAL: DEPRESI DAN KECEMASAN PERINATAL, CLINICAL RESOURCES FOR PREFFESIONAL 81	
A. Depresi Perinatal	83
B. Kecemasan Perinatal.....	84
C. Clinical Resources for Professionals	88
D. Latihan Soal	91
E. Rangkuman Materi.....	93
F. Glosarium	94
G. Daftar Pustaka	96
 BAB 7 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TRAUMA: PENCEGAHAN TRAUMA, PENYEMBUHAN TRAUMA..... 99	

A. Pencegahan Trauma	101
B. Penyembuhan Trauma.....	103
C. Latihan Soal	105
D. Rangkuman Materi.....	108
E. Glosarium	109
F. Daftar Pustaka	110
 BAB 8 TREN DAN ISU PSIKOLOGI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN	113
A. Perubahan Psikososial Ibu dan Keluarga dalam Era Modern	115
B. Tren Gangguan Psikologis Selama Masa Kehamilan dan Pascamelahirkan	116
C. Pengaruh Media Sosial dan Digitalisasi terhadap Kesehatan Mental Ibu ...	118
D. Isu Kepercayaan terhadap Layanan Kesehatan dan Praktik Medis.....	119
E. Tantangan Budaya dan Stigma terhadap Gangguan Psikologis pada Ibu..	121
F. Latihan Soal	123
G. Rangkuman Materi.....	126
H. Glosarium	127
I. Daftar Pustaka	128
 BAB 9 KESEHATAN MENTAL PADA PERINATAL.....	131
A. Definisi Kesehatan Mental pada Perinatal	134
B. Perubahan Normal Emosi Selama Kehamilan, Persalinan, dan Nifas	138
C. Latihan.....	150
D. Kunci Jawaban.....	150
E. Rangkuman Materi.....	152
F. Glosarium	153
G. Daftar Pustaka	153
 BAB 10 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN EMOSI SELAMA KEHAMILAN, PERSALINAN, DAN NIFAS, TANTANGAN KESEHATAN MENTAL DALAM PERIODE KEHAMILAN, PERSALINAN, DAN NIFAS.....	155
A. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Emosi Selama Kehamilan, Persalinan, dan Nifas	157
B. Tantangan Kesehatan Mental dalam Periode Kehamilan, Persalinan, dan Nifas	159
C. Latihan Soal	161

D. Rangkuman Materi.....	164
E. Glosarium	165
F. Daftar Pustaka	167
PROFIL PENULIS.....	169

BAB 1

PSIKOLOGI PADA MASA REPRODUKSI

Tujuan Intruksional:

1. Menjelaskan konsep Psikologi pada masa reproduksi.
2. Menjelaskan gangguan psikologi gangguan psikologi dalam siklus reproduksi dan cara mengatasi
3. Menjelaskan Psikologi daan komunikasi ibu dan bayi
4. Menjelaskan Adaptasi menjadi orang tua
5. Menjelaskan konsep *Bonding attachment* dan *bonding attunement*

Capaian Pembelajaran:

CPL-PRODI yang dibebankan MK

CPL Mampu menerapkan psikologi pada masa reproduksi pada klien dan keluarga secara professional melalui kepemimpinan dalam Kebidanan untuk mencapai kemandirian sesuai etik, legal, peka, budaya dan berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK Bila diberikan pengalaman belajar dikelas, mahasiswa mampu mengintegrasikan (C4) pengetahuan, sikap dan keterampilan praktik dan aktifitas menerapkan gaya kepemimpinan dan penerapan teori serta deteksi gangguan psikologi pada masa reproduksi

Sub -CPMK

Sub-CPMK 1 Menjelaskan konsep Psikologi pada masa reproduksi

Sub-CPMK 2 Menjelaskan gangguan psikologi gangguan psikologi dalam siklus reproduksi dan cara mengatasi

Sub-CPMK 3 Menjelaskan Psikologi daan komunikasi ibu dan bayi

Sub-CPMK 4 Menjelaskan Adaptasi menjadi orang tua

Sub-CPMK 5 Menjelaskan konsep *Bonding attachment* dan *bonding attunement*

A. Psikologi pada masa reproduksi

1. Pengertian

Psikologi berasal dari bahasa Yunani, "*psyche*" yang memiliki arti jiwa dan "*logos*" yang berarti ilmu, sehingga secara harfiah psikologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau ilmu jiwa. Aristoteles mengungkapkan bahwa ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan, dimana jiwa merupakan unsur kehidupan sehingga setiap manusia memiliki jiwa.

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan (UU No.36/2009). Menurut Prawirohardjo (2009), masa reproduksi merupakan masa yang terpenting bagi wanita yang berlangsung selama kurang lebih 33 tahun. Selama masa reproduksi, siklus haid berada pada masa paling teratur, terjadi ovulasi kurang lebih 450 kali dan mengalami perdarahan haid selama 1800 hari. Hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya kehamilan, bahkan di usia 40 tahun keatas, namun fertilitas mulai menurun.

Psikologi pada masa reproduksi merupakan bidang yang membahas tentang aspek psikologi yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi manusia yang mencakup dampak kesehatan fisik dan kesehatan mental.

2. Ruang lingkup kesehatan reproduksi

Dalam menjalankan fungsi dan proses reproduksinya, dapat terlihat dari proses reproduksi yang aman dan sehat selama siklus kehidupannya. Pada siklus reproduksi dimulai dari perkembangan masa konsepsi, anak, remaja, dewasa, klimakterium, hingga menopause.

a. Masa konsepsi

Pada periode ini, kehamilan dengan janin berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan perlakuan yang sama mulai dalam pelayanan *antenatal care (ANC)*, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan juga penanganan bayi baru lahir.

b. Anak

Pada ruang lingkup kesehatan anak, dimulai dari masa bayi baru lahir hingga anak usia sekolah. Pada bayi baru lahir dimulai dengan proses pemberian ASI eksklusif, imunisasi dan manajemen terpadu bayi muda (MTBM). Pada usia balita, hal yang perlu dikembangkan adalah pelayanan pemberian makanan dengan gizi seimbang, imunisasi, manajemen terpadu balita sakit

(MTBS). Pada anak usia sekolah mendapatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama, serta pendidikan pada anak laki-laki dan perempuan.

c. Remaja

Pada periode ini, ruang lingkup pelayanan yang diberikan meliputi informasi kesehatan reproduksi pada laki-laki maupun perempuan, gizi yang seimbang pada remaja, pencegahan kekerasan sosial, pencegahan kekerasan seksual, pencegahan ketergantungan pada NAPZA, pernikahan usia yang matang, peningkatan pendidikan formal, peningkatan pendidikan non formal (keterampilan), peningkatan kepercayaan diri, serta peningkatan pertahanan diri terhadap gangguan dan ancaman.

d. Dewasa

Pada periode ini disebut juga dengan usia subur. Ruang lingkup dalam periode ini meliputi pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, pencegahan Penyakit menular seksual (PMS), pencegahan dan manajemen infertilitas, pemeliharaan kehamilan, persalinan yang aman, pencegahan kecacatan dan kematian pada ibu dan bayi, perawatan BBL, penggunaan kontrasepsi, pengaturan jarak kehamilan, pencegahan aborsi, serta deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks.

e. Klimakterium dan menopause

Pada periode ini ruang lingkup berfokus pada penyakit degeneratif, menopause dan andropause, gangguan metabolisme tubuh, gangguan osteoporosis dan morbiditas, deteksi dini kanker serviks dan kanker prostat.

B. Psikologi dalam siklus reproduksi

1. Remaja

a. Pengertian

Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini individu mengalami berbagai bentuk perubahan, baik perubahan secara fisik maupun perubahan psikologis. Menurut Peraturan Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja didefinisikan sebagai penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.

Pada masa remaja, merupakan tahap peralihan dan perubahan, dimana terjadi peralihan status dan memicu munculnya keraguan yang ada dalam diri remaja. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja meliputi:

- 1) Perubahan fisik, perubahan ini dapat dilihat dari perubahan fisik seks primer dan sekunder baik pada remaja laki-laki maupun perempuan. Berikut ciri-ciri seks primer dan sekunder:
 - a) Ciri-ciri seks primer pada remaja

Pada remaja perempuan mengalami menstruasi yang terjadi karena luruhnya lapisan dinding Rahim yang disebabkan oleh tidak terbuahnya sel ovum oleh sperma.
 - b) Ciri-ciri seks sekunder pada remaja
 - 1) Kulit tampak tebal, pucat berpori-pori besar, kasar, dan kelenjar keringat meningkat
 - 2) Suara lebih penuh dan merdu
 - 3) Pinggul melebar bulat dan membesar, areola mammae menonjol, kelenjar mammae berkembang, payudara membesar dan bulat.
 - 4) Otot membesar, kuat pada akhir masa puber, mulai terbentuk pada bahu, lengan dan tungkai.
- 2) Perubahan sikap, perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan peran serta minat yang muncul karena pengaruh lingkungan sosial pada remaja. Remaja akan menyesuaikan berbagai jenis hubungan, seperti percintaan, persahabatan, dll. Oleh karena itu dapat mempengaruhi sikap, minat, pembicaraan, emosi serta penampilan.
- 3) Perubahan nilai, perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada minat dan pola perilaku yang dialami oleh remaja.

Remaja sering kali dikaitkan dengan tahapan pencarian identitas dan jati diri. Pada masa ini, biasanya banyak sekali hal yang dirasakan oleh remaja seperti perasaan resah, gelisah, dan sering kali tidak merasa puas dalam menerima sesuatu. Oleh karena itu, remaja sering merasakan kekecewaan dan mudah sakit hati apabila realita tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.
- b. Gangguan psikologi pada masa remaja

Gangguan psikologis pada remaja merupakan masalah atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosi pada remaja. Gangguan psikologis yang dapat terjadi pada remaja antara lain:

 - 1) Gangguan kecemasan

Gangguan kecemasan yang dialami oleh remaja dan prakonsepsi antara lain: kecemasan umum, kecemasan sosial dan kecemasan lain yang berlebihan dan tak beralasan.
 - 2) Gangguan makan

Pada usia remaja dan pra konsepsi dapat mengalami gangguan makan, diantaranya anoreksia, bulimia, gangguan ketidakpuasan pada penampilan, serta gangguan citra tubuh.

3) Gangguan identitas gender

Remaja dapat mengalami gangguan identitas dalam gender, seperti halnya keragu-raguan dengan gender serta ketidakpastian tentang identitas gender.

4) Depresi

Depresi yang muncul pada usia remaja dan pra konsepsi, antara lain seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, munculnya pemikiran untuk mengakhiri hidup, serta menurunnya minat pada pola aktivitas.

5) Bipolar

Remaja dengan gangguan mengalami beberapa gangguan perubahan, yaitu perubahan suasana hati yang drastis, euforia dan depresi yang dapat mempengaruhi pola perilaku.

6) Gangguan stress pasca trauma

Gangguan ini terjadi setelah remaja mengalami kejadian berupa pengalaman yang traumatis, meliputi pelecehan baik fisik maupun verbal, maupun kekerasan.

7) Gangguan kesehatan mental

Gangguan kesehatan mental pada remaja dan pra konsepsi diantaranya skizofrenia, OCD, dll

Gangguan mental pada remaja sering dilihat sebagai hal yang wajar, namun jika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan maka dapat mempengaruhi perkembangan emosi, kehidupan sosial, bahkan kesehatan fisik. Beberapa ciri gangguan mental pada remaja dan prakonsepsi antara lain:

- a) Gangguan pola tidur dan pola makan
- b) Penurunan prestasi akademik
- c) Gangguan dalam berfikir
- d) Penurunan berat badan
- e) Perubahan suasana hati yang ekstrim
- f) Menarik diri
- g) Apatis
- h) Perubahan perilaku yang tidak wajar
- i) Tidak dapat mengontrol emosi
- j) Penurunan konsentrasi

k) Perubahan perasaan yang cukup intens, seperti berteriak, menangis dan mual

c. Peran bidan dalam pengelolaan masalah psikologis masa remaja

Masa remaja merupakan masa dimana pematangan organ reproduksi dimulai dan disertai dengan adanya perubahan fisik yang cepat namun kurang selaras dengan perubahan mental atau psikologis. Masalah psikologis pada masa remaja merupakan masalah yang cukup kompleks. Hal tersebut dapat mempengaruhi psikososial pada remaja, munculnya perilaku negatif serta kenakalan remaja, seperti penyimpangan aktifitas seksual, penyalahgunaan gadget dan penyalahgunaan akses pornografi.

Bidan mendapatkan peranan dalam memberikan pelayanan permasalahan psikologis yang dialami remaja, yaitu memberikan penyuluhan dan konseling. Penyuluhan atau konseling dapat dilakukan secara online yang dilakukan oleh seorang konselor. Dalam pemberian konseling pada remaja, kendala yang dihadapi adalah remaja malu dalam mengungkapkan masalah yang dihadapi dan tidak terbuka. Oleh karena itu menurut UU Kebidanan disebutkan bahwa Bidan memiliki peran sebagai penggerak masyarakat dengan melakukan pembinaan dan penjangkaran potensi remaja sebagai konselor sebaya atau konselor sebaya di sekolah. Serta bidan dapat memberikan pelayanan telekonseling pada remaja, untuk menjamin kerahasiaan identitas dan permasalahan yang dihadapi remaja.

Peran bidan selanjutnya dalam mengatasi masalah psikologis pada remaja dan pra konsepsi adalah merujuk. Rujukan dilakukan jika diperlukan pada tenaga ahli di bidang psikologi. Hal tersebut dilakukan agar remaja yang memiliki permasalahan di bidang psikologis dapat segera teratasi, sehingga remaja dapat berkembang menjadi individu yang sehat dan produktif, serta sehat secara fisik, mental dan sosial.

d. Cara mengatasi masalah psikologi pada masa remaja

Penanganan yang dapat dilakukan pada remaja dengan gangguan psikologis dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan strategi. Hal tersebut dilakukan karena remaja tetap membutuhkan pendampingan selama masa perkembangannya. Beberapa hal yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

1) Terapi perilaku

Merupakan terapi dengan tujuan merubah pola perilaku yang tidak sehat atau tidak produktif, seperti membuang kebiasaan buruk, meningkatkan keterampilan sosial, serta meningkatkan kemampuan meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi pada remaja.

2) Terapi perilaku kognitif

Terapi perilaku kognitif yang dimaksudkan adalah berfokus pada perubahan pola pikir negatif agar dapat berubah menjadi positif dan lebih realistis sehingga dapat menekan adanya gejala gangguan psikologis.

3) Konseling atau terapi bicara (komunikasi)

Konseling terapi bicara ini memfasilitasi remaja dalam mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka serta mendapatkan dukungan dan pemahaman oleh terapis.

4) Terapi kreatif

Terapi ini melibatkan kegiatan seni maupun kegiatan kreatif lainnya yang bertujuan untuk membantu mengekspresikan serta mengatasi permasalahan emosional dan psikologis remaja.

5) Pengobatan medis

Pengobatan medis dilakukan oleh tenaga profesional dengan teknik pemberian obat-obatan dengan resep dari dokter berupa antidepresan dan juga antiansietas untuk menekan gejala gangguan psikologis pada remaja.

6) Teknik relaksasi

Teknik relaksasi yang dapat digunakan sama dengan relaksasi pada umumnya, meliputi pernafasan dalam, meditasi, maupun yoga. Relaksasi dapat memberikan manfaat yaitu untuk mengurangi kecemasan serta stress pada masa remaja dan pra konsepsi.

7) Pemeriksaan psikologis

Pada pemeriksaan psikologis remaja, pemeriksaan psikologis bertujuan untuk mengidentifikasi potensial masalah

8) Membuka diri

2. Kehamilan

a. Pengertian

Menurut WHO, kehamilan adalah proses seorang wanita membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya selama Sembilan bulan atau lebih. Kehamilan disebut juga proses faali yang merupakan awal kehidupan bagi generasi berikutnya. Kehamilan membutuhkan waktu 9 bulan kalender atau 40 minggu. Hal tersebut ditentukan dengan menentukan hari pertama haid terakhir (HPHT) atau dengan mengukur suhu basal (susanti, 2008).

b. Gangguan psikologi pada masa Kehamilan

Gangguan psikologi kehamilan muncul karena stress, kecemasan dan kebingungan yang dirasakan oleh ibu hamil yang akan melahirkan. Pada periode ini, ibu hamil harus dipersiapkan secara fisik dan psikologis dalam

proses persiapan dan proses persalinan serta menjadi orang tua dengan cara melakukan kunjungan ANC yang berkualitas. Masalah yang dihadapi oleh ibu hamil berkaitan dengan pemeriksaan ANC berkualitas meliputi skrining kehamilan, genetic, infeksi, maupun kelainan lain.

Pada periode kehamilan, kesehatan mental yang baik sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan bayi, seperti asupan nutrisi yang sesuai, konsumsi alkohol, rokok dan tidak melakukan kunjungan ANC. Menurut Poerwaningsih (2021), banyak kejadian yang mengabaikan dengan hal itu dan masalah tersebut tidak ditangani dengan benar baik gejala depresi maupun sumber stres saat hamil. Beberapa penyebab stress dalam kehamilan:

- 1) Stress yang disebabkan oleh perubahan biologis
- 2) Stress yang disebabkan oleh tekanan sosial
- 3) Krisis identitas

Pada masa kehamilan, akan terjadi krisis maturasi yang dapat menimbulkan stress, yang dapat ditangani. Beberapa masalah psikologis selama kehamilan yang sering terjadi pada ibu hamil meliputi kecemasan persalinan (rasa takut, ketidak pastian persalinan, komplikasi persalinan), terjadinya perubahan tubuh dan citra diri, serta kecemasan karena kurang mendapatkan dukungan sosial selama kehamilan.

Beberapa gangguan psikologis yang dapat terjadi pada masa kehamilan menurut varney (2006), antara lain sebagai berikut:

3. Perubahan emosional

a. Trimester I

Pada trimester awal, terjadi pola penyesuaian dimana ibu mengalami perubahan emosional meliputi perubahan suasana hati (*mood swing*), kecemasan atau kekhawatiran, depresi, penurunan hasrat seksual karena mudah lelah dan mual, serta ibu mulai memikirkan tentang keadaan bayi yang di kandungnya. Sebagian besar ibu hamil mengalami kekecewaan, penolakan, kecemasan, depresi, dan kesedihan. Keadaan ini akan menghilang dengan sendirinya, saat ibu sudah dapat menerima kehamilannya.

b. Trimester II

Trimester II adalah periode kehamilan dimana ibu hamil mengalami kesehatan yang baik, merasa nyaman, bebas dari segala ketidak nyamanan fisiologis kehamilan. Pada trimester ini, terdapat 2 fase, yaitu pre quickening dan pasca quickening. Fase pre quickening merupakan fase ibu belum bisa merasakan gerakan janin, sehingga ibu akan meningkatkan hubungan dengan ibunya dan meningkatkan hubungan interpersonal antara ibu dan

janinnya. Fase pasca quickening adalah fase ketika ibu hamil sudah bisa merasakan gerakan janin, sehingga ibu akan fokus dalam mempersiapkan diri untuk fokus menjadi seorang ibu.

c. Trimester III

Pada trimester III disebut juga masa penantian penuh kewaspadaan dan kecemasan. Ibu hamil merasakan cemas dengan kehidupannya dan bayinya, seperti akankah bayi akan lahir abnormal, kecemasan terkait nyeri persalinan, kehilangan kendali dan hal lain yang tidak diketahui, pengetahuan tentang tanda persalinan atau bayi yang dapat keluar atau tidak, serta cedera pada organ vital kewanitaannya (Purnamayanti, 2021).

1) Stress

Perasaan khawatir dan takut saat kehamilan adalah pemicu reaksi stress yang dialami oleh ibu hamil dan dapat mempengaruhi perkembangan fisiologis dan psikologis bayinya. Stress yang berlebihan dapat berdampak pada terjadinya persalinan premature, Berat bayi lahir rendah (BBLR), hiperaktif dan mudah marah.

2) Insomnia dalam kehamilan

Insomnia dalam kehamilan merupakan gangguan tidur yang disebabkan karena rasa gelisah, kurang tidur atau bahkan tidak bisa tidur sama sekali, lingkungan yang terlalu ramai, penyakit, stress, depresi dan perubahan pola hidup. Gangguan tidur biasanya muncul pada ibu primipara, atau ibu multigravida menjelang persalinan. Tanda dan gejala yang muncul pada ibu hamil seperti kesulitan tidur pada ibu hamil, tidak dapat memejamkan mata dan terbangun di malam hari, sehingga dapat menyebabkan mudah lelah, menurunnya gairah, stress dan mudah emosi.

3) Ansietas (Kecemasan)

Ansietas merupakan kecemasan, khawatir, gelisah, tidak nyaman yang berdampak pada gejala fisik, yang merupakan respon emosional terhadap penilaian individu yang subyektif. Faktor penyebab terjadinya Ansietas biasanya berhubungan dengan beberapa hal, yaitu kesejahteraan ibu dan bayi, riwayat abortus berulang, rasa aman dan nyaman selama masa kehamilan, support keluarga dan tenaga kesehatan, kesiapan ibu menjadi orang tua, perekonomian keluarga. Tanda dan gejala ansietas pada ibu hamil dapat dilihat dengan tanda seperti ibu mengalami sulit tidur, mudah tersinggung, sulit berkomunikasi dan tidak mudah bergaul, palpitasi (denyut jantung menjadi kencang), sering merasakan gemetar dan berkeringat, kejang otot, sering buang air kecil, sering kesemutan, pusing hingga pingsan.

4) Depresi Kehamilan

Depresi merupakan salah satu gangguan kesehatan mental dengan adanya perubahan suasana hati atau kesedihan yang cukup mendalam sehingga saat terjadi tekanan (stress) maka akan terjadi perubahan zat kimiawi di otak (Kusumawati, 2021).

d. Cara mengatasi masalah psikologi pada masa Kehamilan

Pada masa kehamilan, dukungan sosial adalah hal yang paling dibutuhkan dalam menjaga kesehatan mental ibu hamil. Dukungan sosial tersebut didapatkan dari suami, keluarga, teman dan atau kelompok komunitas. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat membantu ibu hamil mengurangi stress dan kecemasan yang dialami ibu selama hamil (prafitri dkk, 2025).

1) Dukungan suami

Peran suami dapat memberikan dukungan secara emosional dan juga secara fisik pada ibu hamil. Dukungan suami mampu membantu ibu mengurangi rasa kesepian dan kuwalahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama kehamilan

2) Dukungan keluarga dan teman

Kehadiran keluarga dan teman dapat memberikan rasa aman dan memberikan dukungan baik secara fisik maupun secara emosional. Keluarga dan teman dapat menemani ibu hamil dalam kegiatan keseharian dan juga membantu aktifitas ibu seperti membantu pekerjaan rumah tangganya.

3) Kelompok komunitas

Kelompok komunitas dibentuk agar ibu hamil dapat berbagi pengalaman dan juga kekhawatiran dan berbagi tips dengan sesama ibu hamil. hal tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan emosional ibu hamil.

4. Post partum

a. Pengertian

Pada masa post partum, ibu akan mengalami adaptasi psikologis, hal tersebut merupakan fisiologis. Menurut Susilawati (2024), perubahan psikologis pada nifas terjadi karena beberapa hal, yaitu:

- 1) Adanya anggota keluarga baru (bayi)
- 2) Peran baru ibu sebagai orang tua bayi
- 3) Tanggung jawab peran sebagai ibu
- 4) Pengalamman selama persalinan

b. Gangguan psikologi pada masa Post partum

Perubahan psikologis terjadi dari masa kehamilan menuju persalinan, perasaan yang dirasakan ibu adalah perasaan senang dan cemas yang bercampur. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan peran baru yaitu menjadi orang tua dan akan segera bertemu dengan bayi yang telah dinanti-nanti kehadirannya. Namun akan muncul rasa cemas terhadap keselamatan bayi yang akan dilahirkannya nanti. Ibu post partum memerlukan coping untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dialami, seperti:

- 1) Perubahan bentuk fisik dan ketidak nyamanan post partum, serta berusaha kembali seperti sebelum hamil
- 2) Perubahan terkait hubungan dengan keluarga

Dalam adaptasi psikologis post partum, terjadi 3 tahapan penyesuaian, yaitu maternal adjustment (penyesuaian ibu), Paternal adjustment (penyesuaian ayah), dan Infant-Parent adjustment (penyesuaian orang tua – bayi).

C. Psikologi dan komunikasi ibu dan bayi

Berisi Materi gangguan psikologi gangguan psikologi dalam siklus reproduksi dan cara mengatasi

D. Adaptasi menjadi orang tua

Selama kehamilan, calon ibu dan ayah membayangkan bayinya, bahkan dari sebelum kehamilan terjadi. Setelah mengetahui adanya kehamilan, respon calon ayah dan ibu beragam, ada yang mengalami kebahagiaan tanpa batas, ada yang mengalami kesedihan, ada yang mengalami keputus asaan dan juga duka cita. Hal tersebut terjadi oleh karena adanya reaksi dan emosi, serta pengalaman membesarkan anak sebelumnya. Persalinan dan kelahiran merupakan kelanjutan pembentukan ikatan yang terjadi mulai saat bayi dalam kandungan sampai setelah bersalin. Hal tersebut sangat berkesan bagi orang tua yang baru pertama kali mengalami persalinan, dimana orang tua dapat menyentuh bayi secara langsung, mendengar tangisan bayi, serta melihat secara langsung gerakan bayi. Hal yang dialami oleh bayi setelah melalui periode persalinan adalah bayi dapat merasakan, mendengar, mencium, melihat lingkungan sekitar (samar), serta kulit yang sensitive terhadap suhu, sentuhan dan gesekan dengan benda yang ada di sekitarnya.

Pada periode post partum, organ pascasistem reproduksi akan kembali ke keadaan semula, seperti sebelum terjadi kehamilan. Pada adaptasi psikologi ibu serta adaptasi psikologi pada ayah, bahwa akan menjalani proses yang penting

dalam asuhan orang tua terhadap bayi (Susilawati, 2024). Adaptasi psikologis pasca persalinan menurut Reva Rubin (1963) memiliki 3 tahapan penyesuaian, antara lain:

1. *Maternal adjustment* (penyesuaian ibu)

Adaptasi yang dialami oleh seorang ibu *post partum* mengalami 3 fase terhadap perannya sebagai ibu. 3 fase penyesuaian (peran ibu) antara lain:

a. Fase *Taking in* (Perilaku dependen)

- 1) Fase ini berlangsung 1-2 hari pertama *post partum*
- 2) Ibu mengharapkan segala kebutuhannya terpenuhi oleh orang lain (fase ketergantungan)
- 3) Fokus ibu adalah pada dirinya sendiri, ibu memerlukan perawatan dan perlindungan
- 4) Ibu menunjukkan kebahagiaan dengan menceritakan pengalaman persalinannya (fase dependen).
- 5) Ibu jadi lebih sensitive dan mudah tersinggung, biasanya cenderung pasif, membutuhkan istirahat cukup, nafsu makan meningkat dan kebutuhan makanan meningkat untuk proses pemulihan pasca persalinan.

b. Fase *taking Hold* (perilaku dependen – independen)

- 1) Fase ini berlangsung pada hari ke 3-10 *post partum*
- 2) Ibu membutuhkan perawatan dan penerimaan orang lain
- 3) Ibu memiliki keinginan yang besar untuk dapat melakukan segala sesuatu secara mandiri
- 4) Fokus ibu adalah merawat bayi, mulai bisa menerima pendidikan kesehatan.

c. Fase *Letting go* (perilaku Interdependen)

- 1) Fase ini berlangsung setelah 10 hari *post partum*
- 2) Ibu mulai dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayi terhadap ibunya
- 3) Ibu mulai dapat merawat bayinya dengan sangat baik
- 4) Penyesuaian dalam hubungan keluarga meningkat dalam hal mengobservasi keadaan bayi
- 5) Penyesuaian terjadi dengan pasangan dikarenakan kehadiran anggota keluarga baru.

2. *Paternal adjustment* (penyesuaian ayah)

Perubahan adaptasi tidak hanya berkaitan dengan peran dan perilaku yang dialami oleh ibu, namun juga terjadi pada ayah. Pada fase ini ayah juga mengalami penyesuaian terhadap kelahiran bayi. Menurut Green & Moris (1976), *absorbs* keasyikan dan kesenangan yang dialami oleh ayah terhadap bayinya disebut *engrossment*, yaitu:

a. Ayah merasa terikat dengan bayinya

- b. Ayah mampu merasakan adanya kontak mata dan juga sentuhan pada bayinya secara langsung
- c. Ayah menunjukkan keterlibatan secara langsung dengan bayinya
- d. Ayah memiliki rasa percaya diri yang lebih besar, merasa lebih dewasa dan merasa lebih tua saat melihat bayi secara langsung
- e. Pada 3 minggu pertama kelahiran bayi, ayah mengalami 3 proses, yaitu:
 - 1) Tahap I, pengalaman membawa bayinya pulang ke rumah
 - 2) Tahap II, Tidak menyangka bahwa telah menjadi ayah baru dan merasa perannya didalam keluarga akan dilupakan dengan hadirnya bayi
 - 3) Tahap III, ayah dapat menentukan keputusan dan memiliki kontrol penuh secara sadar untuk lebih aktif dalam keterlibatan kehidupan bayinya saat ini.

3. *Infant-Parent adjustment* (penyesuaian orang tua – bayi).

Pada fase ini, interaksi orang tua dan bayi berada pada satu tanggaian (*rhytme*), perilaku *repertoar/ repertoires* dan pola tanggung jawab (*responsivity*). Karakteristik *infant – parent adjustment* antara lain sebagai berikut:

a. Rhytme (irama kehidupan)

Pada karakteristik ini, orang tua dan bayi harus bisa saling berinteraksi. Orang tua harus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu bayi dalam mempersiapkan bayi untuk dapat berinteraksi.

b. Perilaku *repertoar/ repertoires*

Pada tahap ini, orang tua melakukan penyesuaian sesuai dengan kontak dan atau jenis perawatan yang didapatkan bayi. *Repertoires* pada bayi dapat dilakukan dengan perilaku memandangi, bersuara/ berbicara pada bayi dan ekspresi wajah pada bayi, meliputi:

1) Memandangi

Pada fase ini, bayi dapat memfokuskan tatapan dan mengikuti wajah orang sejak bayi lahir (kontrol sadar)

2) Bersuara/ berbicara

Pada fase ini, orang tua berusaha berinteraksi dengan gaya bayinya (*infantilizing*), secara lambat, halus, ritmik, dan berusaha supaya bayi dapat mendengar apa yang orang tua ucapkan.

3) Ekspresi wajah

Pada fase ini ekspresi wajah merupakan bahasa tubuh, dimana hal tersebut merupakan bahasa awal bayi. Beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua dalam menerapkan penyesuaian dengan ekspresi wajah antara lain:

- a) Orang tua mengamati dan menandai perilaku bayinya

- b) Ekspresi wajah menjadi media interaksi antara orang tua dan bayi dengan memperlihatkan ekspresi kejutan, kebahagiaan, dan ekspresi lainnya dalam berkomunikasi dengan bayinya
 - c) Bermain "ciluk baa" dengan bayi
 - d) Menirukan ekspresi dan perilaku bayi seperti senyuman, mengerutkan dahi maka orang tua juga melakukan hal yang sama.
- c. Pola tanggung jawab (*responsivity*)
- Pada fase ini terjadi pada saat tertentu dalam suatu stimulasi perilaku "mendapatkan suatu perasaan" / *feedback* dalam perilaku yang mempengaruhi interaksi positif. Respon yang terjadi pada waktu tertentu, merupakan bentuk yang sama dengan perilaku stimulus. Respon tersebut merupakan *feedback* bagi pemberi stimulus, misal orang tua/ orang dewasa yang menirukan perilaku bayi, dan orang dewasa/ orang tua tampak menikmati respon atau situasi tersebut.

E. Bonding attachment and bonding attunement

Bonding merupakan istilah untuk menggambarkan hubungan pertalian antara ibu dan bayi atau orang tua dan anak. Menurut Nelson (1986) bonding adalah dimulainya interaksi emosi sensorik fisik antara orangtua dan bayi segera setelah lahir.

1. Bonding Attachment

a. Pengertian

Bonding adalah interaksi antara orang tua dan bayi sejak awal kehidupan, sedangkan attachment adalah pencurahan kasih sayang diantara individu (benner and brown, 1999). Bonding (ikatan) merupakan suatu ketertarikan satu sama lain (mutual) yang pertama kali antar individu. Proses kasih sayang dapat berlangsung secara terus menerus, dimulai pada saat ibu hamil dan semakin menguat pada awal masa pasca persalinan (Brazenton, 1978).

b. Prinsip-prinsip dan upaya meningkatkan *bonding attachment*

Keberhasilan *bonding attachment* bergantung pada prinsip dan usaha yang dilakukan dan diberikan kepada ibu dan bayi. Menurut Pohan (2022), berikut prinsip dan upaya yang dapat dilakukan agar berhasil dalam melaksanakan *bonding attachment*:

- 1) Dilakukan segera (menit pertama dan jam pertama)
- 2) Sentuhan orang tua pertama kali
- 3) Adanya ikatan yang baik antara orang tua dan bayi
- 4) Kesehatan emosional orang tua yang baik
- 5) Dukungan dalam proses persalinan

- 6) Persiapan persalinan yang optimal
 - 7) Adaptasi
 - 8) Kemampuan komunikasi yang baik dan keterampilan merawat anak
 - 9) Penekanan pada hal-hal positif
 - 10) Dilakukan bidan / perawat maternitas khusus
 - 11) Melibatkan keluarga, dukungan sosial dari pasangan, keluarga dan teman
 - 12) Pemberian informasi berkala tentang bonding attachment
 - 13) Melakukan kontak sedini mungkin antara ibu dan bayi dalam memberikan kehangatan pada bayi, menurunkan rasa sakit ibu, serta meningkatkan kenyamanan.
 - 14) Diberikan kesempatan dan fasilitas yang memadai untuk melakukan kontak langsung lebih lama.
- c. Manfaat pemberian bonding attachment
- Dalam pemberian bonding attachment, dapat terjadi keberhasilan dan ada juga yang mengalami hambatan. Diperlukan motivasi dan dukungan pada ibu untuk dapat melakukan bonding attachment sedini mungkin dengan bayi karena dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan bayi dimasa depan. Manfaat bonding attachment diantaranya:
- 1) bayi akan merasa lebih dicintai, diperhatikan dan dapat menumbuhkan sikap sosial;
 - 2) Bayi akan merasa lebih aman, dan lebih berani aktif melakukan eksplorasi.
- d. Hambatan bonding attachment
- Dalam pemberian bonding attachment, keberhasilan ditentukan seberapa besar upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan ibu dan bayi. Namun masih ada juga orang tua yang tidak berhasil dengan sempurna dalam mendapatkan bonding attachment antara orang tua dan bayi dikarenakan hambatan yang terjadi selama proses bonding attachment. Hambatan yang dapat menjadikan tidak berhasilnya bonding attachment antara lain:
- 1) Kehadiran bayi yang tidak diinginkan
 - 2) Ibu dengan risiko (ibu dengan riwayat penyakit tertentu)
 - 3) Bayi dengan risiko (premature, bayi dengan cacat fisik, bayi sakit yang tidak dilakukan rawat gabung)
 - 4) Kurangnya dukungan dari pasangan, keluarga maupun orang sekitar
- e. Tahapan Bonding attachment
- Dalam melaksanakan bonding attachment, orang tua diharapkan dapat melaksanakan upaya agar dapat menunjang keberhasilan. Berikut tahapan bonding attachment yang dapat dilakukan orang tua, antara lain:

- 1) Perkenalan (*acquaintance*), dengan melakukan sentuhan, kontak mata, bicara/ suara, dan eksplorasi segera setelah mengenal bayinya.
- 2) *Bonding* (keterikatan),
- 3) Rasa sayang, perasaan sayang yang mengikat antar individu sehingga terjadi keterlibatan secara langsung.

2. *Bonding Attunement*

Bonding attunement adalah interaksi antara orang tua dan bayi yang dilakukan secara seimbang dengan melibatkan interaksi emosional, sensorik, dan fisik. *Bonding attunement* penting untuk dilakukan agar anak merasakan keamanan, kenyamanan, mendapatkan dukungan dan merasa diakui.

F. Latihan

Soal Latihan I

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Berikut merupakan ciri-ciri seks primer pada remaja
 - A. Suara lebih penuh dan merdu
 - B. Remaja perempuan mengalami menstruasi**
 - C. Kulit tampak tebal, pucat berpori-pori besar, kasar, dan kelenjar keringat meningkat
 - D. Pinggul melebar bulat dan membesar, areola mammae menonjol, kelenjar mammae berkembang, payudara membesar dan bulat
 - E. Otot membesar, kuat pada akhir masa puber, mulai terbentuk pada bahu, lengan dan tungkai
2. Contoh Gangguan psikologis pada masa kehamilan adalah...
 - A. Ansietas**
 - B. *Maternal adjustment*
 - C. *Paternal adjustment*
 - D. Gangguan identitas gender
 - E. Gangguan stress pasca trauma
3. Perubahan psikologi masa nifas dipengaruhi oleh...
 - A. pengalaman yang traumatis
 - B. Pengalamman selama persalinan**
 - C. sering merasakan gemetar, pusing hingga pingsan
 - D. pemberian obat-obatan khusus dengan resep dari dokter
 - E. keinginan yang besar untuk dapat melakukan segala seatu secara mandiri

4. berikut merupakan prinsip dan upaya meningkatkan bonding attachment, kecuali...
 - A. Sentuhan orang tua pertama kali
 - B. Kehadiran bayi yang tidak diinginkan**
 - C. Dilakukan segera (menit pertama dan jam pertama)
 - D. Kesehatan emosional orang tua yang baik
 - E. Melibatkan keluarga, dukungan sosial dari pasangan, keluarga dan teman
5. Bonding attunement adalah..
 - A. Proses menjalani proses yang penting dalam asuhan orang tua terhadap bayi
 - B. Rasa sayang, perasaan sayang yang mengikat antar individu sehingga terjadi keterlibatan secara langsung
 - C. Interaksi antara orang tua dan bayi yang dilakukan secara seimbang dengan melibatkan interaksi emosional, sensorik, dan fisik**
 - D. Melakukan kontak sedini mungkin antara ibu dan bayi dalam memberikan kehangatan pada bayi, menurunkan rasa sakit ibu, serta meningkatkan kenyamanan
 - E. Perubahan psikologis yang terjadi dari masa kehamilan menuju persalinan, perasaan yang dirasakan ibu adalah perasaan senang dan cemas yang bercampur

SOAL LATIHAN 2

Kerjakan soal latihan dibawah ini dengan cermat!

1. Jelaskan pengertian psikologi masa reproduksi!
2. Sebutkan cara mengatasi masalah psikologi pada remaja!
3. Jelaskan 3 tahapan penyesuaian pada adaptasi psikologi *post partum*!
4. Sebutkan perubahan adaptasi yang dialami oleh ayah menurut green & moris!
5. Jelaskan pengertian *bonding attachment* dan *bonding attunement*!

Kunci Jawaban

1. B
2. A
3. B
4. B
5. C

G. Rangkuman Materi

Rangkuman materi dalam buku ajar adalah penjelasan singkat yang disusun untuk merepresentasikan konsep-konsep kunci atau poin-poin penting dari setiap bab atau bagian dalam buku. Rangkuman ini bertujuan untuk memberikan pembaca gambaran menyeluruh tentang materi yang telah dipelajari tanpa harus membaca ulang seluruh teks. Biasanya, rangkuman disusun dengan cara yang sistematis dan terstruktur, sering kali menggunakan poin-poin utama atau kalimat singkat yang menggambarkan inti dari setiap topik atau subtopik yang dibahas dalam buku.

Rangkuman materi dalam buku ajar juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mempercepat proses pembelajaran, membantu pembaca mengingat kembali informasi penting, dan menyoroti pokok-pokok penting yang harus diperhatikan. Dalam beberapa kasus, rangkuman ini juga disertai dengan contoh-contoh atau ilustrasi yang memperjelas konsep-konsep yang telah dipelajari. Dengan demikian, rangkuman materi dalam buku ajar adalah salah satu komponen penting dalam mendukung pemahaman dan retensi informasi bagi pembaca.

H. Glosarium

Aborsi	: tindakan pengguguran kandungan dengan sengaja dapat dilakukan dalam kondisi darurat medis
Apatis	: gejala atau komplikasi dari beberapa kondisi neurologis dan gangguan kesehatan mental, Kurang bersemangat melakukan sesuatu, Tidak peduli dengan masalah yang dihadapi, Kurang minat dan ekspresi emosi, Kurang aktivitas yang terarah pada tujuan
Areola mammae	: daerah kulit berwarna gelap yang mengelilingi puting susu yang memiliki peran penting dalam proses menyusui dan mengandung kelenjar Montgomery yang melumasi puting.
Dependen	: bergantung atau terikat pada sesuatu atau seseorang
Euforia	: perasaan bahagia, gembira, dan kesejahteraan yang intens
Konsepsi	: proses pembuahan sel telur oleh sperma
Infertilitas	: kondisi ketika pasangan sulit memiliki keturunan
Interdependen	: tidak terikat, bebas, merdeka atau berdiri sendiri
Konselor	: tenaga profesional yang memberikan bantuan psikologis kepada klien
Metabolisme	: proses kimia yang mengubah makanan dan minuman menjadi energi
NAPZA	: zat / bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku ataupun perasaan

- Psikososial : hubungan antara aspek psikologi dan sosial, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi secara *berkelanjutan*
- Reproduksi : proses biologis yang memungkinkan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan
- Skizofrenia : gangguan kesehatan mental kronis yang serius yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak, sering ditandai dengan halusinasi, delusi, dan gangguan berpikir

I. Daftar Pustaka

- Bedaso A, Adams J, Peng W, Sibbritt D. The relationship between social support and mental health problems during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. *Reprod Health*. 2021 Jul 28;18(1):162. doi: 10.1186/s12978-021-01209-5. PMID: 34321040; PMCID: PMC8320195.
- Idaningsih A, dkk. 2021. Psikologi Kebidanan. Cirebon: CV. Rumah Pustaka
- Kristianti YD, dkk. 2024. Buku ajar Asuhan Kebidanan pada remaja dan prakonsepsi. Jakarta: Mahakarya citra utama
- Kusumawati Y, dkk. 2021. Panduan Kesehatan Mental Ibu Hamil. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Lumongga L. Namora. 2016. Psikologi Kespro. Wanita dan Perkembangan Reproduksi : Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya. Depok: Kencana
- Mertasari L, dkk. 2023. Asuhan Masa Nifas dan Menyusui. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers,
- Nur Haerani dkk. 2020. Dinamika Perkembangan remaja: Problematika dan solusi. Gramedia
- Poerwaningsih Sri. 2022. Penerapan Standar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Fisiologis I (Jilid I). NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia
- Prafitri LD, dkk. 2025. Psikoterapi Kehamilan. Pekalongan: penerbit NEM
- Prawirohardjo S. 2009. Ilmu Kebidanan. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Purnamayanti NMD, dkk. 2022. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan S1 Kebidanan Jilid II. Jakarta: Mahakarya Citra Utama.
- Repi AA, dkk. 2018. Aku Remaja yang positif. Jakarta: Gramedia
- Sit, Masganti. 2017. Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. Depok: Kencana
- Susanti, Ni Nengah. 2008. Psikologi Kehamilan. Jakarta: EGC

- Susilawati, dkk. 2024. Buku Ajar Keperawatan Komunitas. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Tangkas, dkk. 2021. Bidan, Konseling Dan Hak Kesehatan Reproduksi Remaja Di Masa Pandemi Covid-19.
- Yanti EM, dkk. 2023. Buku Psikologi Kehamilan, Persalinan dan Nifas. Pekalongan: Penerbit NEM.

BAB 2

DUKUNGAN PADA PENGASUHAN DAN PERAN MENJADI ORANG TUA, KERJASAMA DAN KOMUNIKASI INTERPROFESIONAL DALAM PENANGANAN MASALAH KESEHATAN MENTAL DENGAN MEMPERHATIKAN KESELAMATAN PASIEN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

- Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu:
- Mengaplikasikan prinsip psikologi dalam memberikan dukungan pengasuhan pada orang tua baru.
- Menjalankan komunikasi dan kerjasama interprofesional secara efektif dalam menangani masalah kesehatan mental dengan memperhatikan keselamatan pasien.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Memberikan dukungan pengasuhan dan mendampingi orang tua dalam transisi peran secara empatik dan berbasis bukti.
- Mengaplikasikan strategi komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan tim interprofesional dalam penanganan kesehatan mental.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan pentingnya dukungan pada pengasuhan dan peran menjadi orang tua selama periode perinatal.
- Mengidentifikasi berbagai bentuk dukungan yang efektif dalam membantu orang tua mengatasi tantangan psikologis dan emosional.
- Menguraikan peran bidan dalam memberikan dukungan psikologis kepada orang tua.

- mempraktikkan strategi komunikasi efektif antarprofesi untuk penanganan kesehatan mental yang berorientasi pada keselamatan pasien.
- mengidentifikasi prinsip keselamatan pasien dalam kerjasama antarprofesi.

Pendahuluan

Masa perinatal merupakan periode penting yang penuh dengan tantangan psikologis dan emosional. Dalam masa ini, orang tua, khususnya ibu, memerlukan dukungan ekstra dalam menghadapi peran baru mereka sebagai orang tua. Dukungan yang efektif dan kerjasama antarprofesi kesehatan yang baik sangat dibutuhkan untuk memastikan kesehatan mental ibu, kesejahteraan bayi, serta keselamatan pasien secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kebidanan untuk memahami bagaimana memberikan dukungan yang tepat serta menjalankan komunikasi interprofesional yang efektif demi penanganan masalah kesehatan mental secara optimal.

A. Dukungan pada Pengasuhan dan Peran Menjadi Orang Tua

Transisi menjadi orang tua merupakan tahap perkembangan yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Perubahan ini tidak hanya menghadirkan kebahagiaan, tetapi juga beragam tantangan psikologis. Proses adaptasi terhadap peran baru sebagai orang tua melibatkan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, pola pikir, hubungan interpersonal, serta tanggung jawab tambahan yang sering kali memicu tekanan emosional seperti kecemasan, depresi, dan stres.

Proses adaptasi ini berbeda-beda bagi setiap individu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman masa lalu, dinamika hubungan pasangan, dan tingkat dukungan yang tersedia dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemberian dukungan yang komprehensif sangat diperlukan untuk membantu orang tua menghadapi perubahan ini secara efektif dan sehat. Dukungan tersebut dapat berupa edukasi pengasuhan, konseling psikologis, dan dukungan sosial dalam komunitas.

Dukungan yang diperlukan mencakup:

1. Edukasi Pengasuhan

Edukasi pengasuhan memiliki tujuan utama untuk membantu orang tua memahami perubahan emosional dan psikologis yang dialami dalam masa transisi ke peran orang tua. Edukasi ini mencakup:

a. Pengenalan Tahapan Perkembangan Anak

Memberikan pemahaman tentang tahapan perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak sesuai usia agar orang tua memiliki harapan realistis dan mampu mengelola perilaku anak dengan tepat.

b. Manajemen Emosi Orang Tua

Mengajarkan strategi pengelolaan emosi yang efektif agar orang tua mampu mengatasi stres dan tekanan yang muncul selama masa adaptasi. Ini meliputi teknik relaksasi, mindfulness, dan pengaturan pola istirahat.

c. Teknik Pengasuhan Positif (Positive Parenting)

Memberikan pengetahuan tentang pendekatan positif dalam mendidik anak seperti komunikasi yang empati, disiplin positif, dan strategi pengelolaan perilaku anak secara konstruktif.

d. Persiapan Kesehatan Mental

Mengedukasi mengenai tanda-tanda gangguan kesehatan mental seperti kecemasan berlebihan dan depresi pasca melahirkan agar orang tua bisa mengenali dan segera mencari bantuan profesional apabila diperlukan.

Edukasi ini biasanya dilakukan melalui kelas persiapan melahirkan, workshop, pelatihan online, atau materi informatif yang disediakan di fasilitas kesehatan atau komunitas pengasuhan.

2. Konseling dan Terapi Individu/Pasangan

Konseling dan terapi psikologis individu maupun pasangan menjadi sarana penting dalam memberikan dukungan emosional serta solusi strategis terhadap berbagai tantangan dalam proses pengasuhan dan adaptasi peran sebagai orang tua baru. Dukungan ini mencakup:

a. Konseling Individu

Menyediakan ruang aman bagi setiap orang tua untuk mengekspresikan kecemasan, ketakutan, atau tekanan psikologis yang dirasakan secara pribadi. Melalui konseling individu, orang tua dapat mempelajari teknik mengatasi stres, membangun kepercayaan diri, dan mengelola kesehatan mentalnya dengan lebih baik.

b. Konseling Pasangan:

Bertujuan untuk memperkuat komunikasi, kerja sama, serta menyelesaikan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan gaya pengasuhan, tanggung jawab rumah tangga, dan perubahan hubungan interpersonal setelah memiliki anak. Konseling ini mendukung pasangan untuk saling memahami, mengapresiasi, dan bekerja sama secara efektif dalam peran sebagai orang tua.

c. Terapi Khusus (misalnya Cognitive Behavioral Therapy atau CBT):

Terapi ini efektif untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang umum pada orang tua baru, seperti depresi pasca melahirkan atau kecemasan berlebihan. CBT membantu orang tua mengidentifikasi pola pikir negatif, mengubahnya menjadi lebih positif, serta membangun perilaku adaptif dalam mengatasi tekanan pengasuhan.

Layanan konseling ini dapat diakses melalui fasilitas kesehatan, layanan psikologi klinis, maupun platform daring dengan psikolog atau terapis profesional.

3. Dukungan Sosial dan Kelompok

Dukungan sosial, terutama yang didapatkan dari sesama orang tua baru, merupakan faktor penting yang membantu orang tua menghadapi berbagai tantangan yang timbul selama masa transisi. Dukungan ini meliputi:

a. Kelompok Dukungan (Support Groups)

Kelompok ini merupakan wadah di mana orang tua baru dapat saling berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi terkait pengasuhan. Kelompok ini

memberikan rasa solidaritas, validasi pengalaman, dan membantu mengurangi rasa kesepian atau isolasi.

b. Interaksi Sosial Reguler:

Menjalin interaksi secara teratur dengan keluarga besar, teman, atau komunitas sekitar yang memberikan dukungan emosional, bantuan praktis, dan nasihat dalam pengasuhan.

c. Program Peer Mentoring:

Program di mana orang tua baru dipasangkan dengan orang tua yang lebih berpengalaman (mentor) untuk mendampingi secara personal. Mentor memberikan bimbingan, berbagi strategi pengasuhan yang efektif, dan memberikan dukungan moral dalam menghadapi tantangan sehari-hari.

d. Media Sosial dan Komunitas Online:

Penggunaan komunitas digital dan platform online sebagai ruang untuk berbagi informasi, pengalaman, dan mendapatkan dukungan emosional secara cepat dan praktis, terutama pada masa-masa sulit ketika akses ke kelompok offline terbatas.

Dengan berpartisipasi aktif dalam kelompok sosial tersebut, orang tua merasa lebih percaya diri, lebih mampu mengelola tekanan, serta merasa bahwa tantangan yang mereka alami adalah hal yang wajar dan dapat diatasi dengan baik melalui solidaritas kelompok.

B. Kerjasama dan Komunikasi Interprofesional dalam Penanganan Masalah Kesehatan Mental

Masalah kesehatan mental merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan pendekatan kolaboratif dari berbagai profesional kesehatan dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi interprofesional ini sangat penting agar pasien mendapatkan layanan kesehatan yang terintegrasi, konsisten, dan berorientasi pada hasil yang optimal. Efektivitas penanganan kesehatan mental sering kali bergantung pada kemampuan tim interprofesional untuk bekerja secara harmonis dengan komunikasi yang jelas, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan pasien maupun antar anggota tim itu sendiri. Prinsip-prinsip dalam kerjasama dan komunikasi interprofesional dijelaskan sebagai berikut:

1. Definisi Peran Jelas

Dalam konteks penanganan masalah kesehatan mental, setiap anggota tim interprofesional harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran, tanggung jawab, serta batasan kontribusinya masing-masing. Definisi peran yang jelas akan

membantu mencegah terjadinya tumpang tindih tugas, konflik interpersonal, dan kebingungan dalam penanganan pasien.

a. Identifikasi dan Penegasan Peran

Setiap anggota tim seperti dokter, perawat, psikolog, bidan, pekerja sosial, konselor, apoteker, dan terapis harus secara eksplisit memahami dan mengkomunikasikan peran dan fungsi spesifik mereka dalam proses perawatan kesehatan mental.

b. Penyusunan Rencana Kerja Bersama

Tim secara bersama-sama menyusun rencana kerja atau care plan yang mencerminkan peran masing-masing anggota, sehingga setiap individu memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam penanganan pasien secara jelas dan terstruktur.

c. Evaluasi Peran secara Berkala

Penting untuk secara rutin mengevaluasi efektivitas kerja sama, serta melakukan penyesuaian peran apabila dibutuhkan berdasarkan kebutuhan pasien dan dinamika tim. Hal ini membantu memastikan tim bekerja dengan optimal dan saling mendukung satu sama lain.

2. Komunikasi Empatik dan Responsif

Komunikasi empatik dan responsif merupakan aspek vital dalam kolaborasi interprofesional, terutama dalam konteks masalah kesehatan mental yang sensitif dan kompleks. Hal ini mencakup kemampuan mendengar secara aktif, memahami perspektif anggota tim lain, serta merespons secara tepat, cepat, dan efektif terhadap kebutuhan pasien maupun tim.

a. Komunikasi Terbuka

Menyediakan ruang komunikasi terbuka di mana anggota tim bebas menyampaikan ide, kekhawatiran, maupun pertanyaan tanpa merasa takut dihakimi atau disalahkan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang saling percaya dan menghormati.

b. Penggunaan Bahasa yang Empatik

Dalam setiap interaksi dengan pasien maupun anggota tim, bahasa yang digunakan harus empatik, yaitu mampu menunjukkan pemahaman, simpati, dan penghargaan terhadap perasaan orang lain. Empati dalam komunikasi membantu membangun hubungan kerja yang kuat dan mempercepat resolusi konflik.

c. Responsif terhadap Kebutuhan

Setiap anggota tim harus mampu dengan cepat mengidentifikasi dan merespons perubahan dalam kondisi pasien atau dinamika tim. Misalnya, jika pasien menunjukkan tanda-tanda peningkatan risiko bunuh diri, anggota tim

harus segera berkomunikasi secara jelas kepada tim lainnya untuk merumuskan intervensi darurat.

d. Penggunaan Teknologi Komunikasi

Penggunaan teknologi komunikasi seperti rekam medis elektronik (RME), grup diskusi daring, atau aplikasi komunikasi kesehatan dapat memperlancar pertukaran informasi secara real-time antar anggota tim, serta membantu menghindari kesalahan informasi dan miskomunikasi.

3. Keselamatan Pasien sebagai Prioritas Utama

Keselamatan pasien adalah prinsip yang menjadi dasar dari seluruh tindakan intervensi yang dilakukan oleh tim interprofesional dalam menangani masalah kesehatan mental. Prioritas ini memastikan bahwa semua tindakan yang diambil bertujuan untuk melindungi pasien dari bahaya atau risiko lebih lanjut.

a. Pengelolaan Risiko Secara Terstruktur

Tim interprofesional perlu mengidentifikasi secara rutin potensi risiko atau ancaman keselamatan pasien, seperti risiko bunuh diri, perilaku agresif, atau gangguan psikosis akut. Langkah-langkah pencegahan risiko tersebut harus terintegrasi dalam care plan yang jelas.

b. Pelatihan Keselamatan Pasien

Seluruh anggota tim harus menerima pelatihan reguler mengenai praktik keselamatan pasien, termasuk protokol tanggap darurat, prosedur pelaporan insiden keselamatan, dan manajemen krisis kesehatan mental agar siap menghadapi situasi yang memerlukan intervensi cepat dan efektif.

c. Evaluasi dan Dokumentasi Tindakan

Setiap intervensi yang dilakukan harus terdokumentasi dengan baik. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bahwa semua tindakan intervensi berjalan sesuai prosedur dan efektif dalam menjaga keselamatan pasien.

d. Tindak Lanjut (Follow-Up) Jelas dan Aman

Setelah intervensi awal, sangat penting untuk memastikan ada tindak lanjut yang jelas dan aman bagi pasien. Anggota tim interprofesional harus memastikan pasien menerima dukungan lanjutan, baik dalam bentuk pertemuan rutin, pemantauan kondisi secara berkala, atau rujukan ke layanan spesialis apabila diperlukan.

C. Latihan Soal

Kasus 1

Nyonya S (27 tahun), melahirkan anak pertama dua minggu yang lalu. Ia datang ke klinik kebidanan mengeluhkan perasaan cemas berlebihan, mudah menangis, dan

merasa sangat khawatir tidak bisa merawat bayinya dengan baik. Ia mengaku sulit tidur dan merasa stres karena kurang dukungan dari suami yang sibuk bekerja di luar kota. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan oleh bidan dalam kasus ini adalah:

- A. Memberikan edukasi tentang teknik relaksasi dan manajemen emosi.
- B. Merujuk ke layanan terapi individu Cognitive Behavioral Therapy (CBT).
- C. Menyarankan Nyonya S mengikuti kelompok dukungan sosial.
- D. Memberikan edukasi tentang tahapan perkembangan anak.
- E. Menyarankan pasangan untuk mengikuti konseling pasangan.

Kunci Jawaban: B

Rasional: Kondisi Nyonya S menunjukkan gejala kecemasan dan depresi postpartum, sehingga terapi individu khusus seperti CBT sangat efektif untuk membantu mengatasi gangguan kesehatan mentalnya secara langsung.

Kasus 2

Seorang ibu baru, Ny. A (25 tahun), melahirkan 1 bulan lalu, tampak kelelahan, emosional, dan mudah tersinggung. Ia mengatakan bahwa pasangannya kurang mengerti tentang perubahan emosional yang dialaminya. Ny. A dan suami sepakat untuk mencari solusi agar lebih saling memahami dan mendukung. Saran paling tepat dalam situasi ini adalah:

- A. Menyarankan Ny. A mengikuti terapi individu.
- B. Mengikuti kelas edukasi tentang perkembangan anak.
- C. Menyarankan pasangan mengikuti konseling pasangan.
- D. Menyarankan Ny. A untuk beristirahat total selama beberapa hari.
- E. Menyarankan Ny. A bergabung dalam komunitas online untuk ibu baru.

Kunci Jawaban: C

Rasional: Konseling pasangan paling tepat untuk meningkatkan komunikasi dan pemahaman bersama terkait peran baru serta perubahan emosional yang dialami pasangan setelah memiliki anak.

Kasus 3

Ny. M (30 tahun), melahirkan bayi kedua 3 minggu lalu. Ia merasa kesepian karena baru pindah ke kota baru dan tidak memiliki keluarga atau teman dekat. Ia mulai merasa putus asa dan kehilangan semangat. Tindakan dukungan yang paling tepat dalam kondisi Ny. M ini adalah:

- A. Memberikan edukasi tentang teknik relaksasi mandiri.

- B. Merujuk Ny. M ke kelompok dukungan sosial (support group).
- C. Merujuk ke layanan psikolog klinis untuk terapi individu.
- D. Memberikan informasi tentang perkembangan bayi normal.
- E. Menyarankan Ny. M lebih sering melakukan olahraga ringan.

Kunci Jawaban: B

Rasional: Dalam kondisi isolasi sosial dan kesepian, kelompok dukungan sosial akan memberikan rasa solidaritas, mengurangi isolasi, serta membantu Ny. M merasa lebih terkoneksi dan didukung secara emosional.

Kasus 4

Seorang bidan di puskesmas menghadapi kasus Ny. R (28 tahun), yang melahirkan sebulan lalu, kini mengalami perubahan emosi drastis seperti mudah menangis, merasa tidak berguna, dan berpikir negatif terus-menerus. Bidan mencatat kondisi tersebut dalam rekam medis elektronik dan berkomunikasi segera dengan psikolog serta perawat yang ada dalam tim interprofesional. Prinsip komunikasi interprofesional yang diterapkan bidan dalam kasus ini adalah:

- A. Evaluasi peran secara berkala
- B. Identifikasi peran secara jelas
- C. Komunikasi empatik dan responsif
- D. Penggunaan teknologi komunikasi
- E. Tindak lanjut yang aman dan jelas

Kunci Jawaban: D

Rasional: Penggunaan rekam medis elektronik sebagai teknologi komunikasi membantu memastikan informasi kondisi pasien cepat sampai ke tim, mengurangi miskomunikasi, dan mempercepat intervensi yang diperlukan.

Kasus 5

Seorang pasien, Ny. K (32 tahun), setelah melahirkan mengalami gejala depresi yang semakin parah dengan adanya pikiran ingin melukai diri sendiri. Tim kesehatan mental segera melakukan intervensi dengan mengembangkan rencana kerja yang mencakup pemantauan ketat dan merujuk ke psikiater. Prinsip utama keselamatan pasien yang diterapkan dalam tindakan ini adalah:

- A. Komunikasi terbuka antar anggota tim
- B. Evaluasi peran anggota tim
- C. Pengelolaan risiko secara terstruktur
- D. Pelatihan keselamatan pasien tim

E. Tindak lanjut secara berkala

Kunci Jawaban: C

Rasional: Gejala pikiran ingin melukai diri sendiri adalah kondisi serius yang membutuhkan intervensi segera dan terstruktur, dengan mengelola risiko dan memastikan keselamatan pasien sebagai prioritas tertinggi.

D. Rangkuman Materi

Transisi menjadi orang tua merupakan fase penting dalam kehidupan seseorang yang melibatkan perubahan besar, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Tantangan seperti kecemasan, stres, dan depresi sering dialami oleh orang tua baru akibat tuntutan adaptasi terhadap peran yang baru ini. Oleh sebab itu, dukungan yang komprehensif sangat diperlukan, baik dalam bentuk edukasi pengasuhan yang mencakup pemahaman tahapan perkembangan anak, manajemen emosi, pengasuhan positif, hingga persiapan kesehatan mental, maupun melalui konseling individu dan pasangan serta terapi khusus seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Selain itu, dukungan sosial melalui kelompok, komunitas, dan mentoring juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa isolasi yang dialami oleh orang tua baru.

Di sisi lain, penanganan masalah kesehatan mental secara efektif membutuhkan kolaborasi interprofesional yang baik, ditandai dengan adanya definisi peran yang jelas, komunikasi empatik dan responsif, serta menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Penggunaan teknologi komunikasi, evaluasi peran tim secara berkala, serta manajemen risiko secara terstruktur sangat penting untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan mental yang aman, efektif, terintegrasi, dan optimal. Dengan demikian, dukungan yang terencana dan komunikasi interprofesional yang efektif merupakan kunci utama dalam menjamin keberhasilan adaptasi peran orang tua serta pengelolaan masalah kesehatan mental secara menyeluruh dan berkelanjutan.

E. Glosarium

Adaptasi Peran

Proses penyesuaian diri individu terhadap peran baru sebagai orang tua, yang melibatkan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, pola pikir, dan hubungan interpersonal.

Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Terapi psikologis yang membantu individu mengidentifikasi, memahami, dan mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif serta membangun perilaku adaptif.

Depresi Postpartum

Gangguan emosional yang muncul setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih mendalam, cemas berlebihan, putus asa, dan kesulitan dalam menjalankan peran sebagai ibu.

Dukungan Sosial

Bantuan emosional, praktis, atau nasihat yang didapatkan dari keluarga, teman, atau komunitas untuk membantu individu menghadapi tantangan sehari-hari.

Edukasi Pengasuhan

Proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam memahami perkembangan anak, mengelola emosi pribadi, serta menerapkan pola asuh yang positif.

Empati

Kemampuan memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain, serta menunjukkan rasa simpati dan pengertian dalam komunikasi interpersonal.

Interaksi Sosial Reguler

Hubungan atau komunikasi rutin yang dilakukan individu dengan keluarga, teman, atau komunitas yang memberikan dukungan emosional dan bantuan praktis secara konsisten.

Kelompok Dukungan (Support Group)

Kelompok yang terdiri dari individu dengan pengalaman serupa, bertujuan untuk berbagi tantangan, solusi, dan saling memberikan dukungan moral serta validasi emosional.

Komunikasi Empatik dan Responsif

Cara berkomunikasi yang terbuka, empati, cepat tanggap, serta efektif dalam memahami dan merespons kebutuhan pasien maupun sesama anggota tim profesional.

Konseling Individu

Layanan psikologis yang diberikan kepada seseorang untuk membantu mengatasi masalah psikologis, stres, kecemasan, atau depresi dengan menyediakan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan.

Konseling Pasangan

Layanan psikologis yang ditujukan untuk memperbaiki komunikasi, kerja sama, dan menyelesaikan konflik antara pasangan dalam menjalani peran sebagai orang tua.

Manajemen Emosi

Strategi atau teknik untuk mengatur dan mengendalikan emosi secara efektif, seperti teknik relaksasi, mindfulness, dan pengaturan pola istirahat.

Peer Mentoring

Program bimbingan di mana individu yang kurang berpengalaman didampingi secara personal oleh mentor yang lebih berpengalaman dalam menghadapi tantangan pengasuhan.

Pengasuhan Positif (Positive Parenting)

Pendekatan pengasuhan anak yang berfokus pada komunikasi yang empatik, disiplin yang positif, dan pengelolaan perilaku anak secara konstruktif.

Pengelolaan Risiko

Tindakan terstruktur untuk mengidentifikasi, mencegah, atau mengurangi potensi bahaya terhadap pasien, seperti risiko bunuh diri atau gangguan psikosis akut.

Persiapan Kesehatan Mental

Proses edukasi mengenai tanda-tanda gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pasca melahirkan, agar individu dapat segera mencari bantuan profesional jika diperlukan.

Rencana Kerja Bersama (Care Plan)

Rencana tertulis yang disusun oleh tim interprofesional, menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam penanganan pasien secara jelas dan terstruktur.

Teknologi Komunikasi

Media elektronik seperti rekam medis elektronik (RME), aplikasi kesehatan, atau platform diskusi daring yang digunakan untuk mempermudah pertukaran informasi secara cepat dan akurat antar profesional.

Transisi Menjadi Orang Tua

Tahapan perkembangan hidup yang signifikan, di mana seseorang beradaptasi dengan perubahan peran, tanggung jawab tambahan, dan dinamika hubungan interpersonal sebagai akibat kelahiran anak.

Keselamatan Pasien

Prinsip utama dalam intervensi kesehatan yang memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan bertujuan melindungi pasien dari risiko atau bahaya lebih lanjut, melalui pengelolaan risiko dan tindak lanjut yang jelas.

F. Daftar Pustaka

- Barimani, M., Vikström, A., Rosander, M., Forslund Frykedal, K., & Berlin, A. (2017). Facilitating and inhibiting factors in transition to parenthood—ways in which health professionals can support parents. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 31(3), 537-546. <https://doi.org/10.1111/scs.12367>
- Dennis, C. L., & Dowswell, T. (2013). Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2, CD001134. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001134.pub3>
- Feinberg, M. E., Jones, D. E., Hostetler, M. L., Roettger, M. E., Paul, I. M., & Ehrenthal, D. B. (2016). Couple-focused prevention at the transition to parenthood, a randomized trial: Effects on co-parenting, parenting, family violence, and parent and child adjustment. *Prevention Science*, 17(6), 751–764. <https://doi.org/10.1007/s11121-016-0674-z>
- Galbally, M., Watson, S. J., Boyce, P., & Lewis, A. J. (2020). The role of trauma and partner support in perinatal depression and parenting stress: An Australian pregnancy cohort study. *International Journal of Social Psychiatry*, 66(3), 225-234. <https://doi.org/10.1177/0020764019900776>
- Goodman, J. H. (2019). Perinatal depression and anxiety: Identifying risk and providing support. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 64(6), 706-712. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13064>
- Kingston, D., Tough, S., & Whitfield, H. (2012). Prenatal and postpartum maternal psychological distress and infant development: A systematic review. *Child Psychiatry & Human Development*, 43(5), 683-714. <https://doi.org/10.1007/s10578-012-0291-4>
- McDaniel, S. H., Doherty, W. J., & Hepworth, J. (2014). *Medical family therapy and integrated care* (2nd ed.). American Psychological Association.
- Rollans, M., Schmied, V., Kemp, L., & Meade, T. (2013). Negotiating policy in practice: Child and family health nurses' approach to the process of postnatal psychosocial assessment. *BMC Health Services Research*, 13(1), 133. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-133>
- Sanders, M. R., & Mazzucchelli, T. G. (2018). *The Power of Positive Parenting: Transforming the Lives of Children, Parents, and Communities Using the Triple P System*. Oxford University Press.
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. WHO Press.
- Zwarenstein, M., Goldman, J., & Reeves, S. (2009). Interprofessional collaboration: effects of practice-based interventions on professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3, CD000072. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub2>

BAB 3

KESEHATAN MENTAL PADA PERINATAL: MASALAH KESEHATAN MATERNAL, KESEHATAN MENTAL PERINATAL

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Mahasiswa mampu menerapkan konsep psikologi dalam praktik kebidanan dengan memperhatikan aspek kesehatan mental pada periode perinatal secara komprehensif dan berorientasi pada kesejahteraan ibu dan anak.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan asuhan kebidanan yang relevan terhadap masalah kesehatan mental maternal selama periode perinatal.

Sub-CPMK (Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan berbagai jenis masalah kesehatan mental yang umum dialami ibu selama masa perinatal.
- Mengidentifikasi tanda dan gejala gangguan mental pada ibu selama masa kehamilan dan pasca persalinan.
- Memberikan edukasi dan intervensi kebidanan awal yang tepat terhadap ibu dengan masalah kesehatan mental perinatal.
- Mengintegrasikan pendekatan interprofesional dalam penanganan kesehatan mental perinatal.

Pendahuluan

Periode perinatal merupakan masa transisi kritis dalam kehidupan seorang perempuan yang meliputi masa kehamilan hingga satu tahun pasca persalinan. Pada masa ini, perubahan fisik, hormonal, emosional, dan sosial secara signifikan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Kesehatan mental perinatal menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan khususnya bidan karena kondisi psikologis ibu sangat mempengaruhi hasil kehamilan, persalinan, serta tumbuh kembang bayi dan keluarga secara keseluruhan.

Uraian Materi

A. Masalah Kesehatan Maternal

Masalah kesehatan maternal merupakan topik penting dalam dunia kebidanan karena mencakup berbagai kondisi fisik dan psikologis yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan seorang wanita selama periode kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Dalam hal kesehatan fisik, beberapa kondisi yang umum terjadi pada ibu hamil di antaranya anemia, hipertensi, diabetes gestasional, serta preeklamsia. Kondisi-kondisi tersebut sering kali memerlukan pemantauan ketat dan intervensi medis yang tepat karena dapat menyebabkan komplikasi serius baik bagi ibu maupun bayi yang dikandungnya.

Anemia selama kehamilan merupakan kondisi kekurangan sel darah merah yang biasanya disebabkan oleh defisiensi zat besi. Kondisi ini dapat mengakibatkan kelelahan kronis, lemah, pusing, bahkan meningkatkan risiko persalinan prematur dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Oleh karena itu, bidan dan tenaga kesehatan lainnya perlu aktif melakukan edukasi nutrisi yang tepat serta pemberian suplemen zat besi sejak awal kehamilan.

Hipertensi dalam kehamilan, termasuk preeklamsia, juga menjadi perhatian khusus. Kondisi ini ditandai oleh tekanan darah tinggi disertai tanda-tanda gangguan fungsi organ seperti ginjal, hati, dan sistem saraf. Preeklamsia yang tidak terdeteksi dan tertangani dengan baik bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, yaitu eklamsia, yang dapat mengancam jiwa ibu maupun janin. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin tekanan darah serta tanda-tanda klinis lainnya menjadi sangat penting selama masa antenatal.

Selain itu, diabetes gestasional juga sering ditemui pada ibu hamil, yakni kondisi di mana ibu mengalami peningkatan kadar gula darah yang hanya terjadi selama masa kehamilan. Diabetes gestasional dapat menyebabkan komplikasi pada bayi seperti makrosomia (berat badan bayi berlebihan), serta meningkatkan risiko ibu untuk mengalami diabetes tipe 2 setelah kehamilan selesai. Pengelolaan diabetes gestasional memerlukan intervensi berupa pengaturan diet, olahraga teratur, dan pemantauan ketat kadar gula darah.

Meski demikian, tidak hanya masalah fisik saja yang harus diperhatikan, aspek psikologis juga memiliki dampak yang signifikan tetapi sering kali kurang mendapat perhatian optimal. Faktanya, gangguan psikologis pada ibu hamil dan masa nifas cukup banyak terjadi, mulai dari stres ringan hingga gangguan jiwa yang lebih serius seperti kecemasan berat, depresi, gangguan bipolar, dan bahkan psikosis

postpartum. Faktor pencetus utama kondisi psikologis ini biasanya meliputi perubahan hormonal drastis selama kehamilan dan pasca melahirkan, kelelahan fisik akibat adaptasi tubuh terhadap kehamilan dan persalinan, serta proses adaptasi terhadap peran baru sebagai seorang ibu.

Stres dan kecemasan selama kehamilan dan masa nifas tidak bisa dianggap ringan karena dapat mempengaruhi kesejahteraan ibu dan perkembangan janin atau bayi secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, kecemasan yang berkepanjangan atau depresi maternal dapat menyebabkan gangguan tidur, pola makan yang tidak teratur, serta penurunan kualitas perawatan terhadap bayi setelah lahir. Dalam kasus ekstrem, gangguan psikologis berat seperti depresi atau psikosis postpartum bahkan dapat meningkatkan risiko cedera pada diri ibu atau bayi.

Untuk itu, tenaga kesehatan, khususnya bidan, memainkan peran krusial dalam mendeteksi dini dan menangani masalah kesehatan mental selama periode maternal. Bidan harus mampu melakukan skrining psikologis secara rutin, memberikan dukungan emosional, serta merujuk ibu ke profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater bila diperlukan. Selain itu, edukasi kepada keluarga tentang pentingnya dukungan emosional terhadap ibu juga menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan masalah psikologis maternal.

Dengan demikian, pendekatan holistik yang meliputi pengelolaan aspek fisik dan psikologis secara komprehensif sangat diperlukan dalam pelayanan kebidanan guna memastikan kesehatan optimal ibu dan bayi selama periode maternal.

B. Kesehatan Mental Perinatal

Kesehatan mental perinatal merupakan bagian penting dari perawatan kebidanan, yang merujuk pada kondisi psikologis yang dialami seorang perempuan sejak masa kehamilan hingga sekitar satu tahun setelah persalinan. Masa perinatal adalah periode transisi yang kompleks, melibatkan perubahan fisik, hormonal, emosional, serta sosial yang signifikan. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap kondisi psikologis perempuan dalam periode ini sangat diperlukan, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan ibu dan bayi secara keseluruhan.

Dalam konteks kesehatan mental perinatal, terdapat beberapa gangguan yang sering kali dijumpai, yaitu depresi perinatal, kecemasan perinatal, dan psikosis postpartum. Setiap kondisi ini memiliki ciri khas dan dampak yang berbeda, namun semuanya penting untuk dikenali secara dini dan ditangani secara profesional oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan.

Kesehatan mental perinatal mencakup kondisi psikologis perempuan sejak kehamilan hingga satu tahun pasca persalinan. Gangguan yang umum terjadi antara lain:

1. Depresi Perinatal

Depresi perinatal mencakup dua fase yaitu depresi prenatal (yang terjadi selama masa kehamilan) dan depresi postpartum (yang terjadi setelah ibu melahirkan). Gangguan ini sering kali tidak mudah dikenali, karena gejalanya sering dianggap sebagai perubahan suasana hati biasa atau kelelahan akibat proses kehamilan dan persalinan.

Gejala depresi perinatal meliputi:

- a. Rasa sedih mendalam: Seorang ibu mengalami suasana hati yang terus-menerus sedih, murung, bahkan merasa putus asa yang berlangsung setidaknya dua minggu atau lebih lama.
- b. Kehilangan minat: Ibu kehilangan ketertarikan terhadap aktivitas yang sebelumnya ia nikmati, termasuk merawat diri sendiri atau bayinya.
- c. Perasaan bersalah: Ibu merasa dirinya tidak cukup baik, tidak mampu mengurus anak dengan baik, atau merasa menjadi beban bagi orang lain.
- d. Perubahan pola tidur: Gejala ini bisa berupa kesulitan tidur (insomnia) atau tidur berlebihan (hipersomnia), yang memperburuk kondisi emosional ibu.
- e. Kesulitan berkonsentrasi: Ibu mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan sederhana, sulit fokus pada aktivitas sehari-hari, bahkan terkadang lupa pada hal-hal penting.

Dampak dari depresi perinatal sangat luas, karena mempengaruhi kualitas hubungan antara ibu dan bayi. Ibu yang mengalami depresi cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan emosional bayinya, sehingga ikatan (bonding) ibu-bayi dapat terganggu. Kondisi ini, jika tidak segera diatasi, berisiko menyebabkan gangguan perkembangan kognitif dan emosional pada anak, seperti keterlambatan bicara, gangguan perilaku, dan gangguan interaksi sosial di kemudian hari.

2. Kecemasan Perinatal

Kecemasan perinatal adalah gangguan yang umum terjadi pada perempuan selama periode perinatal, yang ditandai dengan rasa khawatir berlebihan dan terus-menerus mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan kondisi bayi yang dilahirkan. Kecemasan ini sering kali muncul dalam bentuk kekhawatiran yang tidak proporsional terhadap risiko atau bahaya yang sesungguhnya.

Bentuk spesifik dari kecemasan perinatal meliputi:

- a. Gangguan panik: Ibu mengalami serangan panik mendadak yang melibatkan gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak napas, gemetar, atau bahkan rasa takut kehilangan kendali atau mati.
- b. Fobia spesifik: Ketakutan ekstrem terhadap aspek tertentu dalam kehamilan atau persalinan, misalnya takut berlebihan akan rasa sakit saat melahirkan atau ketakutan akan komplikasi medis.
- c. Gangguan obsesif-kompulsif (OCD): Muncul pikiran-pikiran yang obsesif (berulang dan mengganggu) mengenai bahaya terhadap bayi atau diri sendiri, disertai perilaku kompulsif untuk mengurangi kecemasan tersebut, seperti mencuci tangan berlebihan atau mengecek kondisi bayi secara berulang-ulang.

Kecemasan perinatal yang tinggi memiliki dampak serius terhadap kesehatan ibu dan bayi. Ibu yang cemas secara kronis memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama persalinan, seperti kelahiran prematur, bayi dengan berat lahir rendah, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, kecemasan yang berlangsung terus-menerus juga dapat mengganggu kemampuan ibu dalam merawat bayinya dengan tenang dan percaya diri, sehingga berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

3. Psikosis Postpartum

Psikosis postpartum merupakan gangguan kesehatan mental perinatal yang paling serius, meskipun kejadiannya relatif jarang dibandingkan depresi atau kecemasan. Kondisi ini biasanya muncul secara tiba-tiba dalam beberapa hari hingga minggu pertama setelah melahirkan dan dapat berkembang sangat cepat dalam waktu singkat.

Gejala utama psikosis postpartum meliputi:

- a. Halusinasi: Ibu mengalami gangguan persepsi realitas, melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada, misalnya mendengar suara-suara yang memberikan perintah tertentu.
 - b. Delusi: Keyakinan kuat yang keliru atau tidak rasional yang tidak bisa diubah dengan bukti-bukti nyata, seperti keyakinan bahwa bayinya telah diganti atau bahwa ia memiliki kekuatan supranatural tertentu.
 - c. Perubahan suasana hati ekstrem: Ibu menunjukkan perubahan mood yang sangat drastis dan tidak stabil, bisa berubah dari kondisi euforia (perasaan sangat bahagia) menjadi depresi mendalam dalam waktu singkat.
 - d. Perilaku tidak biasa: Ibu dapat menunjukkan perilaku yang sangat tidak lazim atau bahkan berbahaya, misalnya mencoba melukai diri sendiri atau bayinya.
- Psikosis postpartum membutuhkan perhatian medis segera karena risikonya yang tinggi terhadap keselamatan ibu dan bayi. Tanpa penanganan cepat dan

tepat, kondisi ini dapat berakibat fatal. Intervensi umumnya meliputi hospitalisasi (rawat inap) di fasilitas kesehatan jiwa untuk observasi ketat dan terapi intensif, biasanya dengan kombinasi obat-obatan antipsikotik dan terapi psikologis.

C. Latihan Soal

Soal Kasus 1 (Anemia dalam Kehamilan):

Seorang perempuan berusia 28 tahun, G2P1A0 usia kehamilan 30 minggu datang ke bidan mengeluhkan pusing, cepat lelah, dan sering merasa lemas. Pemeriksaan fisik menunjukkan konjungtiva pucat dan denyut nadi meningkat. Bidan menduga ibu mengalami anemia defisiensi zat besi.

Apa tindakan utama yang paling tepat dilakukan bidan dalam kasus ini?

- A. Menyarankan bed rest total
- B. Memberikan suplementasi zat besi dan edukasi nutrisi
- C. Merujuk ibu segera ke rumah sakit
- D. Melakukan transfusi darah segera
- E. Memberikan obat antihipertensi

Kunci jawaban: B

Rasional:

Berdasarkan gejala klinis anemia (kelelahan, pucat, lemas), langkah pertama dan utama adalah pemberian suplementasi zat besi serta edukasi gizi guna memperbaiki kadar Hb ibu dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Anemia ringan hingga sedang tidak membutuhkan transfusi darah segera.

Soal Kasus 2 (Preeklamsia):

Seorang ibu usia 32 tahun, primigravida, datang dengan keluhan nyeri kepala berat sejak dua hari terakhir. Tekanan darah saat pemeriksaan 160/110 mmHg, edema wajah, dan hasil tes urin menunjukkan proteinuria +3. Bidan mencurigai ibu mengalami preeklamsia berat.

Apa tindakan prioritas yang harus segera dilakukan oleh bidan dalam kondisi tersebut?

- A. Melakukan observasi ketat tanpa intervensi
- B. Memberikan obat antihipertensi dosis tinggi secara mandiri
- C. Merujuk segera ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap
- D. Menyarankan istirahat total di rumah
- E. Memberikan suplementasi kalsium

Kunci jawaban: C

Rasional:

Preeklamsia berat merupakan kondisi gawat darurat kebidanan yang memerlukan intervensi medis segera untuk mencegah komplikasi serius seperti eklamsia. Oleh karena itu, prioritas tindakan adalah merujuk segera ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Soal Kasus 3 (Diabetes Gestasional):

Seorang ibu usia 30 tahun, hamil 26 minggu, hasil pemeriksaan kadar gula darah sewaktu (GDS) menunjukkan hasil 215 mg/dL. Ibu sebelumnya tidak memiliki riwayat diabetes. Bidan menduga ibu mengalami diabetes gestasional.

Apa tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan?

- A. Menyarankan diet khusus dan olahraga ringan secara teratur
- B. Melakukan pemeriksaan ultrasonografi segera
- C. Memberikan insulin segera tanpa konsultasi dokter
- D. Merujuk segera ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut
- E. Memberikan glukosa oral untuk stabilisasi gula darah

Kunci jawaban: D**Rasional:**

Diabetes gestasional dengan kadar gula darah yang tinggi (>200 mg/dL) memerlukan evaluasi dan pengelolaan intensif di fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk menghindari komplikasi pada ibu dan janin, sehingga rujukan segera merupakan tindakan yang paling tepat.

Soal Kasus 4 (Depresi Postpartum):

Seorang ibu berusia 26 tahun, postpartum hari ke-14, datang ke klinik bidan dengan keluhan sulit tidur, menangis terus-menerus, merasa tidak mampu merawat bayinya, dan kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari sejak satu minggu terakhir. Suami juga melaporkan ibu tampak sedih mendalam dan murung sepanjang hari.

Tindakan awal yang harus dilakukan bidan dalam kondisi ini adalah?

- A. Mengabaikan keluhan dan mengatakan hal tersebut wajar pasca melahirkan
- B. Memberikan obat antidepresan tanpa konsultasi dokter
- C. Melakukan skrining depresi postpartum dan memberikan dukungan emosional
- D. Merujuk segera ke psikiater tanpa tindakan pendahuluan
- E. Menyarankan aktivitas fisik berat agar ibu cepat sembuh

Kunci jawaban: C

Rasional:

Langkah awal dalam menangani depresi postpartum adalah melakukan skrining menggunakan alat ukur yang tepat dan memberikan dukungan emosional terlebih dahulu sebelum merujuk ke profesional kesehatan mental jika kondisi ibu tidak membaik atau makin berat.

Soal Kasus 5 (Psikosis Postpartum):

Seorang perempuan berusia 24 tahun, postpartum hari ke-7, tiba-tiba menunjukkan perilaku tidak wajar, seperti berbicara sendiri, berteriak-teriak bahwa bayinya diganti oleh makhluk lain, dan mengatakan mendengar suara yang menyuruhnya melukai bayinya. Kondisi ini terjadi secara mendadak sejak satu hari terakhir.

Tindakan apa yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus ini?

- A. Memberikan konseling psikologis rutin
- B. Meminta keluarga mengawasi di rumah tanpa intervensi medis
- C. Merujuk segera ke fasilitas kesehatan jiwa untuk rawat inap
- D. Memberikan obat penenang secara mandiri
- E. Mengobservasi kondisi ibu tanpa tindakan intervensi lebih lanjut

Kunci jawaban: C**Rasional:**

Psikosis postpartum adalah kondisi serius yang mengancam keselamatan ibu dan bayi. Oleh sebab itu, ibu harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan jiwa untuk mendapatkan perawatan intensif, observasi ketat, dan intervensi medis secara profesional guna menghindari risiko cedera atau kematian.

D. Rangkuman Materi

Masalah kesehatan maternal mencakup berbagai kondisi fisik maupun psikologis yang signifikan dalam kehidupan seorang perempuan selama masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Kondisi fisik seperti anemia, hipertensi termasuk preeklamsia, serta diabetes gestasional memerlukan deteksi dini dan intervensi tepat karena dapat menimbulkan komplikasi serius bagi ibu dan bayi. Selain aspek fisik, aspek psikologis juga sangat penting namun sering kali kurang mendapatkan perhatian optimal. Kondisi seperti depresi perinatal, kecemasan perinatal, hingga psikosis postpartum dapat berdampak negatif secara luas, memengaruhi kualitas hidup ibu, ikatan ibu-bayi, hingga tumbuh kembang anak secara jangka panjang.

Kesehatan mental perinatal, yang mencakup kondisi psikologis sejak masa kehamilan hingga satu tahun pasca persalinan, memerlukan perhatian khusus karena perubahan hormon, fisik, dan sosial yang signifikan selama periode ini. Depresi perinatal dengan gejala utama seperti rasa sedih yang mendalam dan kehilangan minat, kecemasan perinatal yang ditandai rasa khawatir berlebihan hingga gangguan panik dan obsesif-kompulsif, serta psikosis postpartum yang ditandai halusinasi dan perilaku tidak wajar, merupakan kondisi serius yang membutuhkan deteksi dini serta intervensi yang cepat dan profesional untuk mencegah risiko fatal.

Untuk itu, tenaga kesehatan khususnya bidan memegang peran penting dalam mendeteksi dini, memberikan edukasi, melakukan skrining rutin, serta merujuk ibu kepada profesional kesehatan mental jika dibutuhkan. Pendekatan pelayanan kebidanan secara holistik yang mencakup aspek fisik dan psikologis secara menyeluruh merupakan kunci utama dalam memastikan kesehatan optimal ibu dan bayi selama periode maternal.

E. Glosarium

Anemia dalam kehamilan

Kondisi kesehatan ibu hamil yang ditandai dengan jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin (Hb) rendah, sering disebabkan oleh kekurangan zat besi, yang menyebabkan gejala seperti kelelahan, pucat, dan pusing.

Defisiensi zat besi

Kekurangan zat besi dalam tubuh yang menyebabkan berkurangnya produksi hemoglobin, sehingga memicu anemia.

Konjungtiva pucat

Membran tipis bagian dalam kelopak mata yang terlihat pucat akibat kurangnya kadar hemoglobin dalam darah.

Preeklamsia berat

Gangguan hipertensi dalam kehamilan dengan tekanan darah tinggi ($\geq 160/110$ mmHg) disertai proteinuria (protein dalam urin), edema wajah, nyeri kepala berat, dan risiko komplikasi serius seperti eklamsia.

Proteinuria

Kondisi di mana urin mengandung protein yang tinggi, merupakan tanda gangguan fungsi ginjal, sering ditemukan pada preeklamsia.

Eklamsia

Komplikasi serius preeklamsia yang ditandai dengan kejang atau koma, mengancam jiwa ibu dan janin.

Diabetes gestasional

Kondisi tingginya kadar gula darah yang terjadi khusus selama masa kehamilan dan dapat menyebabkan komplikasi seperti bayi besar (makrosomia) dan risiko diabetes tipe 2 di kemudian hari.

Glukosa darah sewaktu (GDS)

Pemeriksaan kadar gula darah tanpa puasa yang digunakan untuk mendeteksi diabetes gestasional.

Depresi postpartum

Gangguan suasana hati serius yang terjadi setelah melahirkan, ditandai dengan rasa sedih mendalam, menangis tanpa sebab jelas, sulit tidur, merasa tidak mampu merawat bayi, hingga kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari.

Skrining depresi postpartum

Pemeriksaan sistematis menggunakan kuesioner atau alat bantu untuk mengidentifikasi risiko atau adanya depresi postpartum pada ibu baru melahirkan.

Psikosis postpartum

Gangguan mental langka tetapi serius yang muncul tiba-tiba pasca persalinan, ditandai dengan gejala halusinasi, delusi, perubahan suasana hati ekstrem, dan perilaku tidak wajar atau membahayakan.

Halusinasi

Gangguan persepsi di mana seseorang mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada secara nyata.

Delusi

Keyakinan kuat yang keliru atau tidak rasional dan tidak dapat diubah dengan bukti nyata.

Rujukan segera

Proses pengiriman pasien dari fasilitas kesehatan yang terbatas kemampuannya ke fasilitas kesehatan lain yang lebih lengkap dan mampu memberikan pelayanan kesehatan intensif sesuai kebutuhan pasien.

Hospitalisasi

Rawat inap di fasilitas kesehatan yang bertujuan untuk observasi ketat, evaluasi klinis, serta intervensi medis dan psikologis secara intensif.

F. Daftar Pustaka

- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5-TR (5th ed., text revision). American Psychiatric Publishing.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). Williams Obstetrics (26th ed.). McGraw Hill Education.
- Dennis, C. L., Brown, H. K., & Wanigaratne, S. (2018). Maternal mental health during pregnancy and the postpartum period: An overview of key issues and preventive strategies. *World Psychiatry*, 17(3), 348-362. <https://doi.org/10.1002/wps.20549>
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2021). Maternal Child Nursing Care (7th ed.). Elsevier Health Sciences.
- O'Hara, M. W., & Wisner, K. L. (2014). Perinatal mental illness: Definition, description and aetiology. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 28(1), 3-12. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2013.09.002>
- Prawirohardjo, S. (2020). Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo (Edisi revisi terbaru). Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2020). Maternity and Pediatric Nursing (4th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- World Health Organization. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2022). WHO guidelines on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. Geneva: WHO Press.

BAB 4

KESEHATAN MENTAL PADA PERINATAL: MASALAH KESEHATAN PADA PERINATAL, PENCEGAHAN DAN PENANGANANNYA, MANAJEMEN PADA RISIOKO BUNUH DIRI DAN KEKERASAN OLEH PASANGAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip psikologi dalam mengenali, mencegah, dan mengelola masalah kesehatan mental perinatal, serta mampu merancang intervensi kebidanan yang aman dan efektif untuk mencegah risiko bunuh diri dan kekerasan dalam hubungan pasangan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, serta merancang strategi pencegahan dan penanganan terhadap masalah kesehatan mental perinatal, termasuk manajemen risiko bunuh diri dan kekerasan oleh pasangan dalam konteks praktik kebidanan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mengidentifikasi berbagai masalah kesehatan mental pada masa perinatal.
- Menjelaskan strategi pencegahan dan intervensi efektif terhadap gangguan kesehatan mental perinatal.
- Mengelola risiko bunuh diri dan kekerasan pasangan melalui pendekatan kolaboratif dan multidisipliner.

Pendahuluan

Masa perinatal, yang mencakup kehamilan hingga satu tahun pasca persalinan, merupakan periode yang rentan bagi perempuan karena berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Pada masa ini, perempuan berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, psikosis postpartum, hingga risiko bunuh diri dan kekerasan oleh pasangan. Pentingnya deteksi dini, pencegahan, serta intervensi yang tepat sangat diperlukan dalam memberikan asuhan kebidanan holistik dan efektif.

A. Masalah Kesehatan Mental pada Perinatal

Masalah kesehatan mental pada masa perinatal merupakan kondisi yang sangat penting diperhatikan, mengingat periode ini adalah masa sensitif yang mempengaruhi tidak hanya kesehatan ibu tetapi juga perkembangan jangka panjang anak dan keharmonisan keluarga. Perinatal adalah masa yang mencakup kehamilan hingga setahun pertama setelah kelahiran bayi, yang merupakan periode transisi besar dalam kehidupan seorang perempuan. Perubahan fisik, hormonal, emosional, dan sosial selama masa ini sering kali memicu munculnya berbagai gangguan psikologis yang signifikan.

Salah satu gangguan yang paling umum terjadi adalah depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan. Depresi ini bukan sekadar perasaan sedih biasa, tetapi kondisi yang ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat dan semangat, serta perasaan tidak berdaya yang berlangsung terus menerus. Ibu yang mengalami depresi postpartum mungkin mengalami kesulitan untuk merawat diri sendiri maupun bayinya. Selain itu, muncul pula gejala-gejala seperti gangguan tidur dan nafsu makan, merasa lelah secara ekstrem, menangis tanpa alasan jelas, bahkan dalam beberapa kasus, ibu memiliki pikiran negatif tentang dirinya sendiri atau bayinya. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi ikatan emosional (bonding) antara ibu dan bayi, yang mana bonding ini sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak.

Selain depresi postpartum, masalah kesehatan mental lain yang sering muncul adalah gangguan kecemasan perinatal. Gangguan ini biasanya ditandai dengan rasa khawatir yang berlebihan tentang kesehatan bayi, proses kelahiran, atau kemampuan diri sebagai seorang ibu. Kondisi ini dapat menyebabkan ibu terus-menerus merasa tegang, sulit tidur, atau memiliki gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak napas, dan sering merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Gangguan kecemasan dapat mempengaruhi kualitas hidup ibu secara signifikan, membuatnya tidak bisa menikmati proses menjadi orang tua baru dengan sepenuh hati.

Gangguan panik juga dapat terjadi pada periode perinatal, meskipun jarang dibahas secara khusus. Kondisi ini ditandai dengan serangan panik yang tiba-tiba muncul, di mana ibu merasakan ketakutan atau rasa takut yang luar biasa, disertai gejala fisik seperti jantung berdebar-debar, gemetar, sesak napas, dan pusing. Serangan panik dapat sangat menakutkan bagi ibu karena sering muncul tiba-tiba

dan sulit diprediksi, mengganggu fungsi sehari-hari ibu serta kemampuan merawat bayinya secara efektif.

Pada kasus yang lebih berat, seorang ibu dapat mengalami psikosis postpartum, suatu kondisi serius yang memerlukan penanganan medis segera. Psikosis postpartum ditandai dengan gejala yang lebih ekstrem dibandingkan gangguan mental lainnya, seperti halusinasi, delusi, kebingungan, hingga perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun bayinya. Kondisi ini, meskipun jarang terjadi, perlu diidentifikasi secara dini dan segera mendapatkan intervensi agar tidak menimbulkan konsekuensi yang fatal.

Masalah kesehatan mental perinatal ini memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada kondisi ibu sendiri tetapi juga terhadap bayi dan keluarga secara keseluruhan. Bayi yang lahir dari ibu yang mengalami gangguan psikologis perinatal memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah dalam pertumbuhan fisik seperti berat badan lahir rendah, gangguan pola tidur, serta kesulitan menyusui. Lebih lanjut lagi, bayi juga berisiko mengalami gangguan dalam perkembangan kognitif dan emosionalnya seperti keterlambatan bicara, kesulitan dalam pengelolaan emosi, serta masalah perilaku pada masa kanak-kanak hingga remaja.

Di samping itu, hubungan interpersonal dalam keluarga pun turut terkena dampaknya. Kondisi mental ibu yang terganggu dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan pasangan, menimbulkan rasa frustrasi, ketidakmengertian, hingga konflik yang berlarut-larut. Pasangan mungkin juga merasa bingung tentang bagaimana cara membantu ibu yang sedang mengalami gangguan mental tersebut. Akibatnya, dukungan sosial yang sangat dibutuhkan ibu pada masa perinatal sering kali menjadi tidak efektif atau bahkan semakin melemah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan perhatian khusus sejak dini melalui identifikasi risiko secara proaktif oleh tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter kandungan. Selain itu, edukasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya dukungan psikologis dan sosial bagi ibu selama masa perinatal juga harus ditingkatkan. Upaya ini termasuk pemberian layanan konseling dan terapi, dukungan kelompok sebaya, serta manajemen stres yang tepat bagi ibu dan pasangan. Dengan demikian, ibu, bayi, dan seluruh keluarga dapat terhindar dari dampak negatif jangka panjang akibat gangguan kesehatan mental pada masa perinatal.

B. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Mental Perinatal

Masalah kesehatan mental pada masa perinatal memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup ibu, tumbuh kembang bayi, serta dinamika keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan dan penanganan yang tepat menjadi sangat penting agar masalah tersebut dapat diminimalkan, dicegah sejak dini, atau ditangani secara optimal apabila sudah muncul.

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer adalah upaya aktif yang dilakukan sebelum munculnya gangguan kesehatan mental, dengan tujuan mengurangi risiko atau mencegah secara keseluruhan timbulnya gangguan. Pendekatan ini berfokus pada edukasi, dukungan sosial, dan konseling sejak sebelum kehamilan terjadi.

a. Edukasi

Edukasi menjadi dasar utama dalam pencegahan primer gangguan mental perinatal. Calon ibu, pasangan, dan keluarga perlu memahami perubahan fisik, emosional, psikologis, serta sosial yang dapat terjadi selama masa perinatal. Edukasi dapat disampaikan melalui berbagai metode, seperti seminar, sesi konseling, brosur, media sosial, hingga pelatihan kelas antenatal. Informasi yang diberikan meliputi tanda dan gejala gangguan mental yang harus diwaspadai, keterampilan coping terhadap stres, teknik relaksasi, pentingnya keterlibatan pasangan dalam merawat bayi, serta cara meminta bantuan jika diperlukan. Edukasi yang efektif meningkatkan kesiapan mental ibu dalam menghadapi tantangan selama masa perinatal.

b. Dukungan Sosial

Dukungan sosial adalah aspek krusial dalam menjaga kesehatan mental ibu pada masa perinatal. Dukungan ini bisa berasal dari berbagai pihak, termasuk pasangan, keluarga inti maupun besar, sahabat, dan komunitas sosial tempat ibu tinggal. Bentuk dukungan sosial meliputi pendampingan emosional seperti mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, serta memahami perasaan ibu secara empatik. Dukungan sosial juga mencakup bantuan praktis, seperti membantu mengurus bayi, menyediakan kebutuhan sehari-hari, serta menciptakan suasana nyaman di rumah. Kehadiran dukungan sosial yang kuat terbukti mampu menurunkan risiko ibu mengalami gangguan depresi maupun kecemasan pada masa perinatal.

c. Konseling Pranikah dan Prakonsepsi

Konseling pranikah dan prakonsepsi dilakukan sebelum terjadinya kehamilan untuk menyiapkan pasangan dalam berbagai aspek kehidupan

rumah tangga, termasuk mental dan emosional. Konseling ini membantu pasangan mengeksplorasi kesiapan diri menjadi orang tua, mengelola konflik dalam hubungan, mengembangkan komunikasi efektif, serta meningkatkan keterampilan dalam menghadapi stres yang mungkin muncul. Pasangan juga dapat mengidentifikasi faktor risiko yang bisa memicu gangguan mental, sehingga dapat merencanakan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Konseling pranikah yang efektif menciptakan fondasi hubungan yang kuat, sehat secara psikologis, serta mempersiapkan pasangan menghadapi tantangan perinatal secara lebih positif.

2. Penanganan Masalah Kesehatan Mental Perinatal

Jika gangguan kesehatan mental sudah terjadi, intervensi yang cepat, efektif, dan menyeluruh sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang lebih luas. Penanganan melibatkan pendekatan terpadu yang mencakup deteksi dini, terapi psikologis, kolaborasi multidisipliner, serta farmakoterapi bila diperlukan.

a. Skrining Rutin Selama Kehamilan dan Pasca Persalinan

Skrining merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penanganan kesehatan mental perinatal. Skrining ini biasanya dilakukan secara berkala selama masa kehamilan dan dilanjutkan hingga minimal satu tahun setelah persalinan. Tujuannya adalah mendeteksi dini ibu yang berisiko atau sudah menunjukkan gejala-gejala gangguan mental seperti depresi postpartum atau gangguan kecemasan. Alat-alat skrining seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) atau Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) sering digunakan untuk membantu profesional kesehatan dalam menentukan tingkat keparahan gejala. Dengan skrining rutin, gangguan dapat diidentifikasi secara cepat sehingga intervensi dapat segera dilakukan sebelum kondisi semakin parah.

b. Konseling Psikologis, Terapi Kelompok, atau Terapi Individual

Setelah dilakukan skrining, langkah berikutnya adalah intervensi melalui konseling psikologis atau terapi. Konseling psikologis dilakukan untuk membantu ibu mengeksplorasi penyebab dan perasaan terkait gangguan mental yang dialami, serta mengembangkan strategi pengelolaan emosi dan stres yang efektif. Konseling ini bisa berupa terapi individual, di mana ibu bertemu secara privat dengan psikolog atau konselor, ataupun dalam bentuk terapi kelompok di mana ibu bertemu dengan ibu lain yang mengalami kondisi serupa. Terapi kelompok memberikan manfaat tambahan berupa

dukungan emosional dari sesama ibu, sehingga ibu merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya. Terapi-terapi ini mampu mengurangi tingkat kecemasan, depresi, serta meningkatkan kemampuan coping dan kualitas hidup ibu.

c. Kolaborasi Multidisipliner dengan Psikolog, Psikiater, dan Pekerja Sosial

Penanganan gangguan mental perinatal yang efektif seringkali memerlukan pendekatan multidisipliner, yang melibatkan berbagai tenaga profesional. Psikolog bertanggung jawab dalam terapi psikologis dan penguatan emosional ibu, psikiater berperan dalam evaluasi klinis serta pengobatan farmakologis jika diperlukan, sementara pekerja sosial memberikan dukungan pada aspek sosial seperti memastikan ibu mendapatkan dukungan komunitas, layanan sosial yang diperlukan, serta pengaturan intervensi di lingkungan keluarga. Kolaborasi ini menciptakan pendekatan komprehensif yang memastikan semua kebutuhan ibu secara psikologis, medis, dan sosial terpenuhi secara optimal.

d. Farmakoterapi jika Diperlukan dengan Pertimbangan Keselamatan Ibu dan Bayi

Dalam kondisi tertentu, terapi psikologis saja mungkin tidak cukup, sehingga diperlukan intervensi farmakologis. Farmakoterapi atau pengobatan menggunakan obat-obatan biasanya digunakan untuk gangguan mental yang berat seperti depresi mayor, kecemasan berat, gangguan panik, atau psikosis postpartum. Keputusan untuk memberikan obat ini harus mempertimbangkan secara hati-hati mengenai keselamatan ibu dan bayi, baik selama kehamilan maupun masa menyusui. Oleh karena itu, penggunaan obat harus didasarkan pada evaluasi mendalam oleh psikiater yang berkolaborasi dengan dokter kandungan untuk memilih jenis obat yang paling aman serta memastikan pemantauan efek samping secara rutin.

C. Manajemen Risiko Bunuh Diri dan Kekerasan oleh Pasangan

Manajemen risiko bunuh diri dan kekerasan pasangan dalam masa perinatal merupakan isu krusial yang harus ditangani secara serius oleh tenaga kesehatan. Masa perinatal, yang mencakup kehamilan hingga satu tahun pertama setelah kelahiran bayi, merupakan periode sensitif yang berisiko tinggi terhadap munculnya berbagai gangguan psikologis dan emosional yang serius. Salah satu konsekuensi berat dari gangguan psikologis ini adalah timbulnya ide bunuh diri dan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh pasangan.

1. Manajemen Risiko Bunuh Diri pada Masa Perinatal

Risiko bunuh diri dalam periode perinatal seringkali berhubungan erat dengan kondisi gangguan depresi berat, terutama depresi postpartum yang tidak tertangani secara memadai. Perasaan putus asa, sedih berlebihan, tidak berdaya, serta pikiran negatif yang terus-menerus tentang diri sendiri dan bayinya dapat memperkuat risiko terjadinya ide atau perilaku bunuh diri pada ibu.

Dalam menghadapi situasi ini, manajemen yang efektif harus dilakukan secara cepat, dengan pendekatan empati yang tinggi dan non-judgemental (tanpa penghakiman). Langkah awal penting adalah membangun komunikasi terbuka dengan ibu yang mengalami risiko bunuh diri, di mana ibu merasa didengarkan, dimengerti, dan didukung secara emosional tanpa merasa dihakimi. Dalam pendekatan ini, bidan atau tenaga kesehatan lainnya harus mampu mengenali secara dini tanda-tanda peringatan seperti pernyataan yang menunjukkan keputusasaan, rencana bunuh diri, perilaku menarik diri, atau menyampaikan perasaan tidak ingin hidup lagi.

Setelah mengenali tanda tersebut, langkah berikutnya adalah segera melibatkan jejaring dukungan yang profesional, seperti psikolog, psikiater, konselor kesehatan mental, atau pekerja sosial, serta memastikan keluarga dan orang-orang terdekat turut aktif dalam memberikan dukungan emosional dan sosial. Intervensi profesional ini bertujuan untuk memberikan terapi psikologis mendalam serta farmakoterapi jika diperlukan. Dukungan keluarga akan memastikan ibu merasa aman, didukung, serta memiliki tempat untuk berbagi secara terbuka tentang perasaannya.

Penting juga untuk memastikan keselamatan ibu dengan melakukan monitoring atau pengawasan ketat oleh keluarga atau tenaga kesehatan sampai kondisi psikologis ibu dianggap stabil. Menyusun rencana keselamatan atau safety plan bersama ibu dan keluarga menjadi elemen penting, mencakup identifikasi pemicu emosional, tindakan apa yang harus dilakukan ketika merasa tertekan, serta kontak darurat yang dapat segera dihubungi ketika kondisi ibu mengalami krisis.

2. Manajemen Risiko Kekerasan oleh Pasangan pada Masa Perinatal

Kekerasan oleh pasangan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang juga sering meningkat pada masa perinatal. Kondisi ini sering terjadi akibat perubahan dinamika hubungan, tekanan finansial, stres, dan perubahan emosional yang terjadi selama masa kehamilan dan setelah

persalinan. Akibatnya, ibu berada dalam situasi sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis.

Untuk mengelola risiko ini secara efektif, beberapa langkah strategis yang harus diimplementasikan antara lain adalah:

a. Melakukan Skrining Rutin terhadap Risiko Kekerasan

Skrining rutin terhadap risiko kekerasan menjadi langkah pertama yang penting dalam manajemen risiko ini. Skrining biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam yang sensitif dan rahasia dengan ibu, menggunakan pertanyaan khusus yang dapat mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun finansial oleh pasangan. Penting bagi tenaga kesehatan untuk melaksanakan skrining ini dengan penuh kepekaan dan kerahasiaan agar ibu merasa aman untuk berbicara jujur.

b. Memberikan Edukasi kepada Pasangan tentang Komunikasi Sehat dan Pengelolaan Stres

Pemberian edukasi kepada pasangan tentang bagaimana membangun komunikasi yang sehat serta cara mengelola stres secara efektif menjadi salah satu upaya penting dalam mencegah kekerasan terjadi. Program edukasi ini berisi pelatihan keterampilan komunikasi positif, pengelolaan konflik, serta teknik relaksasi atau manajemen emosi untuk membantu pasangan menghadapi tantangan yang muncul selama periode perinatal dengan lebih konstruktif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dalam hubungan serta meningkatkan kualitas interaksi antara pasangan.

c. Menyediakan Jalur Aman untuk Pelaporan dan Intervensi Darurat

Akses terhadap jalur pelaporan yang aman sangat penting untuk memastikan ibu merasa terlindungi secara fisik dan psikologis. Layanan ini mencakup penyediaan kontak darurat yang dapat diakses 24 jam, rumah aman (safe house) yang dapat digunakan sebagai tempat berlindung darurat, serta akses cepat terhadap bantuan medis atau psikologis bila dibutuhkan. Sistem pelaporan harus jelas, rahasia, dan mudah diakses oleh ibu yang mengalami kekerasan agar mereka tidak takut atau ragu untuk mencari bantuan.

d. Bekerjasama dengan Layanan Kesehatan Mental dan Perlindungan Hukum

Kolaborasi multidisipliner yang melibatkan layanan kesehatan mental seperti psikolog dan konselor, serta perlindungan hukum seperti kepolisian, lembaga perlindungan perempuan dan anak, atau pekerja sosial menjadi sangat penting dalam kasus kekerasan oleh pasangan. Tim ini bekerja secara terpadu untuk memberikan bantuan holistik kepada ibu yang mengalami kekerasan, meliputi dukungan emosional, konseling psikologis, serta

perlindungan hukum seperti pendampingan hukum dan proses mediasi jika memungkinkan atau diperlukan. Dengan kolaborasi ini, ibu dapat merasa lebih terlindungi, kuat secara emosional, dan yakin bahwa situasi sulit yang dihadapinya tidak harus dialami seorang diri.

D. Latihan Soal

Soal Kasus 1: Depresi Postpartum

Seorang ibu berusia 29 tahun datang ke tempat praktik mandiri bidan (TPMB) dengan bayi berusia 4 minggu. Ia terlihat lelah, sulit tidur, sering menangis tanpa alasan jelas, dan tidak bersemangat dalam mengasuh bayinya. Ia mengaku merasa tidak mampu menjadi ibu yang baik dan kadang berpikir bahwa bayinya lebih baik tanpa dirinya.

Apa tindakan awal yang paling tepat dilakukan bidan?

- A. Menyarankan ibu segera dirawat di rumah sakit
- B. Melakukan konseling psikologis awal dengan pendekatan empati
- C. Mengarahkan ibu untuk mengikuti kelas parenting
- D. Memberikan obat penenang
- E. Menginstruksikan pasangan untuk mengawasi ibu setiap waktu

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Tindakan awal yang tepat adalah memberikan konseling psikologis dengan pendekatan empati guna menilai kondisi mental ibu secara menyeluruh, meredakan perasaan negatif, dan menentukan intervensi lanjutan yang tepat.

Soal Kasus 2: Gangguan Kecemasan Perinatal

Seorang perempuan hamil primigravida usia kehamilan 36 minggu datang ke Puskesmas mengeluhkan sering merasa cemas berlebihan, sulit tidur, dan jantung berdebar. Ia selalu khawatir tentang proses persalinan dan keselamatan bayinya, sehingga memengaruhi kesehariannya secara nyata.

Intervensi apa yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus ini?

- A. Memberikan obat anti-kecemasan dosis rendah
- B. Merujuk langsung ke psikiater untuk penanganan intensif
- C. Mengajak ibu untuk mengikuti terapi relaksasi dan konseling
- D. Menyarankan agar ibu segera melahirkan dengan operasi caesar
- E. Menginstruksikan ibu untuk beristirahat total di rumah

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Terapi relaksasi dan konseling adalah pilihan utama dalam kasus kecemasan ringan hingga sedang, yang terbukti efektif meredakan kecemasan dan memperbaiki kualitas hidup ibu tanpa efek samping farmakologis.

Soal Kasus 3: Serangan Panik Perinatal

Seorang ibu usia 31 tahun, postpartum hari ke-20, tiba-tiba merasa sangat ketakutan, sesak napas, jantung berdebar, dan pusing hebat saat sedang menyusui bayinya. Ia mengalami kejadian ini sudah dua kali dalam seminggu terakhir tanpa pemicu yang jelas.

Apa penanganan awal yang paling tepat dilakukan oleh bidan?

- A. Merujuk ibu segera ke IGD
- B. Menenangkan ibu, memberikan teknik pernapasan, dan mendampingi hingga gejala reda
- C. Memberikan antidepresan
- D. Menyarankan ibu untuk tidak menyusui sementara
- E. Mengisolasi ibu agar bayi aman

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Pendampingan, teknik pernapasan, dan reassurance dapat meredakan serangan panik secara akut dan memberi rasa aman kepada ibu sebelum menentukan langkah intervensi lanjutan yang lebih terstruktur.

Soal Kasus 4: Psikosis Postpartum

Seorang ibu berusia 26 tahun datang ke klinik dengan bayinya yang berusia 2 minggu, disertai suaminya yang terlihat khawatir. Suami menyatakan bahwa istrinya dalam seminggu terakhir tampak kebingungan, mendengar suara-suara yang tidak nyata, serta meyakini bahwa bayinya telah ditukar dengan bayi lain.

Tindakan utama apa yang harus segera dilakukan oleh bidan dalam situasi ini?

- A. Memberikan konseling singkat lalu pulang
- B. Menginstruksikan suami untuk lebih dekat menjaga istrinya
- C. Merujuk segera ibu ke layanan psikiatri atau rumah sakit jiwa
- D. Memberikan edukasi tentang pola tidur ibu postpartum
- E. Menyarankan istirahat total di rumah

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Psikosis postpartum adalah keadaan darurat medis yang harus segera mendapatkan penanganan dari tenaga profesional kesehatan mental seperti psikiater di rumah sakit atau fasilitas kesehatan jiwa.

Soal Kasus 5: Kekerasan oleh Pasangan pada Masa Perinatal

Seorang ibu hamil usia kehamilan 28 minggu datang ke Puskesmas untuk pemeriksaan antenatal. Ia tampak takut, terdapat memar di lengan atas, serta enggan berbicara secara terbuka. Setelah pendekatan empati, ia mengakui bahwa suaminya sering melakukan kekerasan fisik dan emosional sejak ia hamil.

Langkah pertama apa yang harus segera dilakukan bidan dalam situasi ini?

- A. Meminta ibu untuk segera melapor ke polisi
- B. Merujuk ibu ke layanan perlindungan perempuan dan anak
- C. Menyarankan ibu untuk meninggalkan rumah
- D. Mengonfrontasi pasangan ibu secara langsung
- E. Mengabaikan dulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Ibu harus segera dirujuk ke layanan perlindungan perempuan dan anak agar mendapatkan perlindungan hukum, bantuan emosional, dan memastikan keselamatannya secara fisik dan psikologis.

E. Rangkuman Materi

Masalah kesehatan mental pada masa perinatal merupakan kondisi serius yang memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan ibu, bayi, dan dinamika keluarga secara keseluruhan. Gangguan yang umum terjadi selama periode ini meliputi depresi postpartum, gangguan kecemasan perinatal, serangan panik, hingga kondisi ekstrem seperti psikosis postpartum. Kondisi-kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan ibu dalam merawat dirinya dan bayinya, serta berdampak negatif terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan emosi, dan perilaku bayi hingga masa mendatang.

Oleh karena itu, pencegahan sejak dini dan penanganan yang efektif sangat penting dilakukan. Upaya pencegahan primer mencakup edukasi yang tepat kepada ibu, pasangan, dan keluarga tentang perubahan psikologis selama periode perinatal, pemberian dukungan sosial yang kuat, serta konseling pranikah maupun prakonsepsi untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor risiko gangguan mental sejak dini. Penanganan yang optimal melibatkan skrining rutin secara berkala, konseling psikologis baik secara individual maupun kelompok, serta kolaborasi multidisipliner dengan profesional seperti psikolog, psikiater, dan pekerja sosial. Penggunaan farmakoterapi juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan ibu dan bayi secara hati-hati.

Selain itu, risiko bunuh diri dan kekerasan oleh pasangan yang meningkat selama masa perinatal juga memerlukan pendekatan manajemen risiko yang serius dan terstruktur. Pendekatan ini mencakup deteksi dini melalui skrining rutin, edukasi pasangan terkait komunikasi sehat dan pengelolaan stres, penyediaan jalur aman untuk pelaporan serta intervensi darurat, dan kolaborasi lintas disiplin dengan tenaga kesehatan mental dan perlindungan hukum. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan dapat terlindungi dari dampak negatif gangguan kesehatan mental pada masa perinatal, sehingga tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang bayi dan kesejahteraan keluarga.

F. Gloasrium

Depresi Postpartum

Gangguan mental serius yang dialami ibu setelah melahirkan, ditandai oleh perasaan sedih mendalam, kehilangan minat terhadap aktivitas, rasa tidak berdaya, gangguan tidur dan nafsu makan, serta dapat memengaruhi hubungan emosional ibu dan bayi.

Gangguan Kecemasan Perinatal

Kondisi psikologis pada masa kehamilan dan pasca melahirkan yang ditandai oleh kecemasan berlebihan, rasa khawatir terus-menerus terhadap kesehatan bayi, proses kelahiran, dan kemampuan ibu dalam menjalankan perannya, disertai gejala fisik seperti sesak napas dan jantung berdebar.

Gangguan Panik Perinatal

Gangguan kecemasan yang ditandai dengan serangan panik tiba-tiba, perasaan takut atau ketakutan hebat, disertai gejala fisik seperti gemetar, pusing, sesak napas, dan jantung berdebar yang muncul tanpa peringatan jelas selama masa perinatal.

Psikosis Postpartum

Kondisi psikologis ekstrem yang muncul pada periode setelah persalinan, melibatkan gejala seperti delusi (keyakinan yang tidak berdasar), halusinasi (mendengar atau melihat hal yang tidak nyata), kebingungan, serta potensi perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun bayi.

Perinatal

Masa kritis dalam kehidupan perempuan yang mencakup periode kehamilan hingga satu tahun pertama setelah melahirkan, ditandai perubahan fisik, emosional, hormonal, dan sosial yang signifikan, sehingga meningkatkan risiko gangguan psikologis.

Bonding (Ikatan Emosional)

Hubungan emosional yang terjalin antara ibu dengan bayinya, sangat penting untuk perkembangan emosional dan fisik bayi, yang dapat terganggu akibat gangguan kesehatan mental ibu.

Skrining Rutin Perinatal

Pemeriksaan secara berkala menggunakan instrumen khusus untuk mendeteksi gejala awal gangguan mental pada ibu selama kehamilan hingga satu tahun setelah persalinan, bertujuan mengidentifikasi risiko secara dini untuk intervensi lebih cepat.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

Alat skrining khusus yang digunakan untuk mendeteksi adanya depresi postpartum pada ibu secara cepat dan efektif.

Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7)

Alat skrining standar yang digunakan untuk menilai tingkat kecemasan umum yang dialami ibu selama masa perinatal.

Pencegahan Primer

Upaya proaktif yang dilakukan sebelum terjadinya gangguan mental dengan memberikan edukasi, dukungan sosial, dan konseling kepada calon ibu dan pasangan, bertujuan menurunkan risiko terjadinya masalah kesehatan mental perinatal.

Konseling Pranikah dan Prakonsepsi

Pendampingan psikologis yang dilakukan sebelum menikah atau sebelum terjadinya kehamilan untuk mempersiapkan mental, emosional, dan hubungan interpersonal pasangan dalam menghadapi perubahan pada masa perinatal.

Terapi Kelompok

Bentuk terapi psikologis di mana sekelompok ibu dengan masalah yang serupa saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, dan membantu mengatasi masalah mental melalui dukungan sosial sesama ibu.

Kolaborasi Multidisipliner

Pendekatan terintegrasi yang melibatkan beberapa tenaga profesional (psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga kesehatan lain) untuk memberikan penanganan holistik yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan medis dalam mengatasi gangguan mental perinatal.

Farmakoterapi

Pengobatan gangguan mental menggunakan obat-obatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan ibu dan bayi secara seksama, melalui evaluasi mendalam oleh psikiater bekerja sama dengan dokter kandungan.

Manajemen Risiko Bunuh Diri

Pendekatan yang sistematis dan empatik dalam mengidentifikasi, menangani, serta memonitor ibu yang memiliki risiko bunuh diri akibat gangguan mental perinatal,

termasuk menyediakan rencana keselamatan (safety plan) dan intervensi profesional secara tepat waktu.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perilaku kekerasan fisik, emosional, seksual, atau finansial yang dilakukan pasangan terhadap ibu, yang meningkat risikonya pada periode perinatal akibat stres, tekanan emosional, maupun perubahan hubungan interpersonal.

Skrining Risiko Kekerasan

Proses wawancara yang dilakukan secara rutin dan sensitif oleh tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi secara dini tanda-tanda kekerasan yang dialami ibu, memastikan keamanan serta memberikan bantuan perlindungan secara cepat.

Safe House (Rumah Aman)

Tempat perlindungan sementara yang aman bagi ibu dan bayi yang mengalami kekerasan, dilengkapi dengan dukungan emosional, medis, psikologis, serta perlindungan hukum dari ancaman kekerasan lebih lanjut.

Intervensi Darurat

Langkah penanganan yang cepat dan tepat dalam situasi darurat kesehatan mental atau kekerasan domestik, termasuk menyediakan kontak darurat, layanan medis, psikologis, serta bantuan hukum yang mudah diakses ibu.

Edukasi Pasangan

Proses memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pasangan tentang komunikasi sehat, pengelolaan konflik, serta teknik manajemen stres, yang bertujuan mengurangi risiko kekerasan pasangan selama periode perinatal.

G. Daftar Pustaka

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). American Psychiatric Association Publishing.
- Beck, C. T., & Watson Driscoll, J. (2019). *Postpartum mood and anxiety disorders: A clinician's guide* (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Dennis, C. L., & Dowswell, T. (2019). Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2019(2), CD001134. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001134.pub4>
- Howard, L. M., & Khalifeh, H. (2020). Perinatal mental health: A review of progress and challenges. *World Psychiatry*, 19(3), 313-327. <https://doi.org/10.1002/wps.20769>
- Howard, L. M., Khalifeh, H., & Trevillion, K. (2019). Domestic violence and mental health. In L. M. Howard & G. Feder (Eds.), *Perinatal mental health: A clinical guide* (pp. 137-150). Cambridge University Press.

- Leach, L. S., Poyser, C., & Fairweather-Schmidt, K. (2017). Maternal perinatal anxiety: A review of prevalence and correlates. *Clinical Psychologist*, 21(1), 4-19. <https://doi.org/10.1111/cp.12058>
- Muzik, M., & Borovska, S. (Eds.). (2021). *Motherhood in the face of trauma: Pathways towards healing and growth*. Springer.
- O'Hara, M. W., & Wisner, K. L. (2014). Perinatal mental illness: Definition, description, and aetiology. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 28(1), 3-12. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2013.09.002>
- Sit, D., Luther, J., Buysse, D., Dills, J. L., Eng, H., Okun, M., & Wisner, K. L. (2015). Suicidal ideation in depressed postpartum women: Associations with childhood trauma, sleep disturbance, and anxiety. *Journal of Psychiatric Research*, 66-67, 95-104. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2015.04.021>
- World Health Organization. (2022). WHO guide for integration of perinatal mental health into maternal and child health services. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240048836>

BAB 5

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TRAUMA: DEFINISI TRAUMA, TRAUMA SELAMA PROSES KEHAMILAN SAMPAI POST PARTUM

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu memahami konsep trauma psikologis pada ibu hamil dan nifas serta menerapkan strategi pencegahan dan penanganan trauma secara efektif dalam praktik kebidanan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan definisi dan konsep dasar trauma psikologis dalam konteks kebidanan.
- Mengidentifikasi jenis-jenis trauma yang dapat terjadi selama proses kehamilan, persalinan, dan postpartum.
- Menguraikan dampak trauma psikologis terhadap ibu, bayi, dan keluarga.
- Menjelaskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan trauma dalam praktik kebidanan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan secara rinci definisi trauma psikologis dan karakteristiknya dalam konteks kebidanan.
- Mengidentifikasi faktor risiko terjadinya trauma selama masa kehamilan hingga postpartum.
- Menjelaskan dampak jangka pendek dan panjang dari trauma pada ibu dan keluarga.
- Merancang strategi pencegahan trauma yang efektif, termasuk edukasi, konseling, dan dukungan sosial.
- Melakukan intervensi awal dalam menangani trauma psikologis yang dialami ibu selama kehamilan hingga masa postpartum.

Pendahuluan

Trauma psikologis merupakan kondisi emosional yang timbul sebagai respons terhadap peristiwa yang sangat menekan, menakutkan, atau membahayakan, yang dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental individu. Dalam konteks kebidanan, trauma tidak hanya mencakup aspek fisik akibat komplikasi persalinan, tetapi juga aspek emosional dan psikologis yang bisa muncul sejak masa kehamilan hingga periode postpartum. Kehamilan dan persalinan, meskipun merupakan pengalaman yang positif bagi banyak perempuan, juga bisa menjadi sumber trauma apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, tenaga kesehatan khususnya bidan perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai definisi trauma, faktor risiko, dampak, serta strategi pencegahan dan penanganannya.

Uraian Materi

A. Definisi Trauma

Trauma psikologis merupakan respons emosional mendalam yang muncul akibat seseorang mengalami atau menyaksikan suatu kejadian yang dirasakan sebagai ancaman serius terhadap keselamatan fisik maupun emosional. Secara umum, trauma muncul ketika seseorang menghadapi peristiwa yang secara signifikan melampaui kapasitasnya untuk mengatasi stres atau tekanan yang muncul pada situasi tersebut. Peristiwa ini biasanya sangat mengejutkan, tak terduga, dan disertai rasa tidak berdaya yang begitu intens, sehingga meninggalkan dampak emosional yang mendalam dalam kehidupan individu tersebut.

Respons emosional yang dialami oleh seseorang setelah terjadinya peristiwa traumatis sering kali bervariasi, tetapi sebagian besar penderita akan merasakan ketakutan yang luar biasa, rasa cemas yang terus-menerus, dan perasaan tidak berdaya yang sulit untuk dikendalikan. Tidak jarang, seseorang yang mengalami trauma akan menghadapi gangguan tidur yang serius, seperti sulit tidur, insomnia, atau bahkan terbangun dengan panik di tengah malam akibat mimpi buruk yang mengingatkan kembali pada kejadian traumatis tersebut.

Selain gangguan tidur dan mimpi buruk, penderita trauma psikologis juga sering mengalami gejala-gejala seperti meningkatnya tingkat kewaspadaan yang ekstrem, yang disebut sebagai hiper-vigilansi. Mereka mungkin menjadi sangat sensitif terhadap lingkungan sekitar, merasa selalu dalam bahaya, dan mudah terkejut atau ketakutan dengan suara atau gerakan mendadak yang sebenarnya tidak berbahaya. Respons semacam ini biasanya terjadi akibat otak terus-menerus berada dalam keadaan siaga tinggi, mengantisipasi terjadinya kembali ancaman atau bahaya.

Gejala lainnya yang umum terjadi adalah munculnya ingatan atau kilas balik (flashbacks) yang berulang, di mana individu tiba-tiba merasakan dirinya kembali berada dalam situasi traumatis, seolah-olah peristiwa tersebut tengah berlangsung saat ini. Kilas balik ini bisa muncul secara spontan tanpa pemicu yang jelas, atau bisa pula dipicu oleh situasi tertentu yang mirip atau mengingatkan individu terhadap trauma yang dialaminya. Kondisi ini sering kali menimbulkan rasa cemas dan panik yang intens, serta bisa menyebabkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam beberapa kasus yang lebih parah, trauma psikologis juga bisa berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih serius, seperti gangguan stres pascatrauma (Post Traumatic Stress Disorder - PTSD), gangguan kecemasan,

atau bahkan depresi berat. Gejala depresi dalam konteks trauma sering kali ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, isolasi sosial, hingga perasaan putus asa dan pikiran negatif yang terus-menerus.

Penting untuk dicatat bahwa reaksi seseorang terhadap trauma bisa sangat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk keparahan peristiwa traumatis, kondisi psikologis sebelumnya, dukungan sosial, serta kemampuan coping yang dimiliki individu tersebut. Oleh karena itu, penanganan trauma psikologis memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan terapi psikologis, dukungan sosial yang kuat, dan kadang-kadang intervensi medis untuk membantu individu pulih secara efektif dan kembali menjalani kehidupan dengan normal.

B. Trauma selama Proses Kehamilan sampai Postpartum

Trauma psikologis merupakan respons emosional serius yang dapat timbul dalam berbagai tahap kehidupan seorang perempuan, khususnya selama periode kehamilan, persalinan, hingga masa setelah melahirkan (postpartum). Dalam praktik kebidanan, trauma ini sering kali kurang dikenali dan mendapat perhatian yang cukup, padahal efeknya bisa sangat signifikan, tidak hanya bagi kesehatan ibu, tetapi juga bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Setiap fase kehamilan hingga postpartum memiliki tantangan tersendiri yang berpotensi memicu trauma psikologis. Faktor-faktor ini sangat kompleks dan saling berkaitan, serta bisa muncul secara tiba-tiba atau berkembang secara bertahap sepanjang waktu.

1. Trauma selama Kehamilan

Tahap kehamilan merupakan periode yang seharusnya penuh harapan dan kebahagiaan bagi seorang ibu, namun kenyataannya tidak selalu demikian. Beberapa perempuan justru mengalami trauma psikologis pada masa ini karena berbagai faktor pemicu, di antaranya adalah:

a. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Trauma yang disebabkan oleh kekerasan fisik, emosional, maupun seksual dari pasangan atau anggota keluarga lainnya memberikan dampak emosional yang mendalam. Kondisi ini menyebabkan ibu merasa tidak aman, ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, hingga stres kronis yang berkepanjangan. Dampak dari trauma ini tidak hanya berpengaruh terhadap

kondisi mental ibu tetapi juga dapat menyebabkan gangguan fisik, seperti gangguan tidur, gangguan makan, hingga komplikasi pada kehamilan.

b. Komplikasi medis selama kehamilan

Komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan, diabetes gestasional, atau ancaman kelahiran prematur dapat menciptakan rasa takut dan cemas berlebihan pada ibu hamil. Kondisi medis yang tidak stabil dapat menyebabkan stres kronis karena ibu terus-menerus khawatir tentang keselamatan dirinya maupun bayinya. Stres kronis ini dapat mengganggu pertumbuhan janin dan meningkatkan risiko kelahiran prematur atau berat lahir rendah.

c. Kekhawatiran terhadap kesehatan bayi

Ibu hamil seringkali mengalami kecemasan terhadap kondisi bayinya, seperti khawatir akan adanya cacat bawaan, pertumbuhan janin yang tidak optimal, atau masalah kesehatan lainnya. Kecemasan berlebihan ini, jika terus berlangsung dalam waktu lama, dapat berkembang menjadi trauma psikologis yang memengaruhi kesejahteraan emosional ibu.

d. Ketakutan menghadapi persalinan

Beberapa ibu memiliki ketakutan ekstrem terhadap proses persalinan, yang dikenal sebagai tokophobia. Mereka mungkin takut terhadap rasa sakit, risiko komplikasi, atau bahkan ketakutan tidak mampu melahirkan secara normal. Ketakutan ini bisa menyebabkan kecemasan berlebih, stres, hingga gangguan tidur yang berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan janin.

2. Trauma selama Persalinan

Persalinan adalah fase kritis yang sarat dengan tantangan fisik dan emosional. Beberapa ibu mengalami trauma psikologis selama persalinan karena faktor-faktor berikut:

a. Persalinan sulit atau berkepanjangan

Proses persalinan yang sangat menyakitkan, lama, atau tidak lancar dapat menyebabkan ibu merasa sangat tidak berdaya, takut, dan stres. Ketika ibu kehilangan rasa kontrol terhadap tubuhnya sendiri atau merasa terjebak dalam situasi yang menakutkan, pengalaman ini bisa menjadi traumatis.

b. Tindakan medis yang tidak sesuai ekspektasi atau tanpa persetujuan jelas dari ibu

Prosedur seperti induksi persalinan, episiotomi, atau operasi sesar yang dilakukan tanpa persetujuan eksplisit atau dengan informasi yang minim dapat menyebabkan ibu merasa kehilangan kendali atas situasi yang

dialaminya. Rasa tidak berdaya ini meningkatkan risiko trauma psikologis dan mengurangi rasa percaya terhadap tenaga kesehatan.

c. Komplikasi persalinan

Komplikasi medis serius selama persalinan seperti perdarahan hebat, bahaya gawat janin, hingga kondisi yang mengancam nyawa ibu, juga bisa menyebabkan trauma emosional yang serius. Dampaknya bisa berlanjut jauh setelah persalinan berakhir, bahkan berkembang menjadi gangguan stres pascatrauma postpartum (Postpartum PTSD). Dalam kondisi ini, ibu sering mengalami kilas balik yang intens, mimpi buruk, kecemasan berlebih, dan ketakutan untuk menjalani kehamilan berikutnya.

3. Trauma Postpartum

Trauma tidak hanya berhenti pada proses persalinan, melainkan dapat berlanjut dan bahkan berkembang pada periode postpartum. Beberapa faktor yang memicu trauma psikologis pada masa ini meliputi:

a. Pengalaman negatif saat persalinan yang belum terselesaikan

Pengalaman persalinan yang buruk atau menyakitkan dapat meninggalkan trauma berkepanjangan, terutama jika tidak ada dukungan psikologis atau emosional yang memadai untuk mengatasi pengalaman tersebut.

b. Kurangnya dukungan sosial

Dukungan yang kurang dari pasangan, keluarga, atau lingkungan sosial yang buruk membuat ibu merasa terisolasi dan terbebani. Merasa sendirian dalam menghadapi tanggung jawab baru dapat memicu kecemasan, depresi, hingga trauma psikologis serius.

c. Kesulitan adaptasi peran sebagai ibu

Menjadi seorang ibu merupakan transisi besar dalam hidup. Jika ibu menghadapi kesulitan dalam mengelola peran baru ini, seperti merasa tidak mampu merawat bayi dengan baik atau tidak memahami kebutuhan bayi, maka akan timbul rasa bersalah, malu, hingga stres berkepanjangan yang menjadi trauma emosional.

d. Komplikasi postpartum seperti kesulitan menyusui atau gangguan kesehatan bayi

Kesulitan dalam menyusui, bayi yang sering sakit, atau komplikasi medis pada ibu maupun bayi setelah persalinan juga dapat menjadi sumber trauma. Situasi ini menciptakan rasa frustrasi, rasa gagal, bahkan keputusasaan yang mendalam.

C. Pencegahan Trauma dalam Praktik Kebidanan

Trauma psikologis dalam kebidanan merupakan isu serius yang dapat menyebabkan dampak emosional jangka panjang pada ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi pencegahan trauma harus menjadi bagian integral dari praktik kebidanan sejak masa kehamilan hingga postpartum. Pencegahan trauma tidak hanya bertujuan mengurangi risiko gangguan kesehatan mental, tetapi juga memastikan pengalaman kehamilan, persalinan, dan postpartum yang positif dan bermakna bagi ibu dan keluarganya.

Strategi pencegahan trauma dalam kebidanan meliputi:

1. Edukasi kehamilan dan persiapan persalinan yang realistis.

Strategi pencegahan trauma yang pertama adalah pemberian edukasi yang komprehensif tentang proses kehamilan dan persalinan secara realistis kepada ibu hamil. Edukasi ini bertujuan agar ibu memiliki pemahaman yang akurat dan tidak mengembangkan harapan yang tidak realistis atau terlalu ideal. Informasi yang realistis membantu ibu memahami bahwa setiap persalinan memiliki potensi risiko tertentu, serta berbagai kemungkinan skenario yang bisa terjadi selama proses tersebut.

Edukasi mencakup penjelasan mengenai tahapan kehamilan, teknik-teknik manajemen nyeri selama persalinan, serta pemahaman tentang intervensi medis yang mungkin diperlukan. Hal ini membantu mengurangi ketakutan atau kecemasan berlebihan pada ibu. Ketika ibu memiliki ekspektasi realistis, maka kemungkinan trauma akibat harapan yang tidak terpenuhi bisa diminimalisasi.

2. Penyediaan dukungan psikologis yang memadai sejak kehamilan.

Dukungan psikologis yang memadai sejak masa kehamilan sangat penting untuk mencegah munculnya trauma psikologis. Dukungan ini mencakup bimbingan emosional dari bidan atau tenaga kesehatan lainnya, serta konseling psikologis jika diperlukan. Dukungan psikologis juga termasuk upaya membantu ibu dalam mengenali dan mengatasi faktor-faktor stres yang mungkin timbul selama kehamilan, seperti masalah keluarga, kekerasan rumah tangga, atau kecemasan tentang kesehatan bayi.

Adanya tenaga profesional yang selalu siap mendengarkan keluhan dan kekhawatiran ibu, serta memberikan empati, mampu secara signifikan mengurangi risiko trauma psikologis. Selain itu, melibatkan keluarga atau pasangan dalam pemberian dukungan emosional akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan mendukung selama proses kehamilan hingga postpartum.

3. Pelatihan keterampilan relaksasi dan pengelolaan stres.

Strategi berikutnya adalah pelatihan keterampilan relaksasi dan pengelolaan stres yang efektif sejak masa kehamilan. Keterampilan ini mencakup teknik pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, mindfulness, meditasi, yoga prenatal, hingga visualisasi positif. Keterampilan ini membantu ibu untuk secara aktif mengurangi stres dan kecemasan yang muncul selama kehamilan dan persalinan.

Pelatihan relaksasi juga bermanfaat dalam membantu ibu menghadapi rasa sakit dan tekanan selama proses persalinan. Ibu yang mampu mengelola stres dengan baik akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi, rasa kontrol yang lebih baik terhadap tubuhnya, serta pengalaman persalinan yang lebih positif dan minim trauma psikologis.

4. Peningkatan keterampilan komunikasi efektif tenaga kesehatan.

Komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan (bidan, dokter, perawat) dan ibu sangat penting dalam mencegah trauma. Tenaga kesehatan perlu dilatih secara khusus dalam hal keterampilan komunikasi interpersonal yang penuh empati, jelas, informatif, serta mampu memahami kebutuhan emosional ibu. Komunikasi efektif mencakup mendengarkan secara aktif, menjelaskan prosedur medis dengan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan informasi secara jujur dan transparan.

Ketika komunikasi terjalin dengan baik, ibu akan merasa dihormati, diperhatikan, dan dilibatkan dalam setiap proses. Sebaliknya, komunikasi yang buruk, seperti sikap tidak peduli, terburu-buru, atau minim empati dari tenaga kesehatan bisa menjadi pemicu trauma yang serius bagi ibu.

5. Mendorong partisipasi aktif ibu dalam proses pengambilan keputusan medis.

Strategi terakhir yang sangat penting adalah melibatkan ibu secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan medis. Partisipasi ini berarti memberikan ruang bagi ibu untuk mengajukan pertanyaan, mengekspresikan kekhawatiran, serta ikut menentukan pilihan terkait proses persalinan, intervensi medis, maupun perawatan postpartum yang akan dijalani. Pendekatan ini dikenal sebagai *shared decision-making*, di mana tenaga kesehatan dan ibu secara kolaboratif mengambil keputusan berdasarkan informasi lengkap serta preferensi pribadi ibu.

Keterlibatan aktif ibu meningkatkan rasa kontrol, kepercayaan diri, serta kepuasan terhadap pengalaman kehamilan dan persalinannya. Dengan demikian, risiko trauma yang disebabkan oleh rasa tidak berdaya atau kehilangan kontrol secara signifikan dapat dikurangi.

D. Penanganan Trauma dalam Praktik Kebidanan

Trauma psikologis yang dialami ibu selama proses kehamilan, persalinan, hingga masa postpartum memerlukan penanganan yang tepat dan efektif agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), gangguan kecemasan, atau depresi postpartum. Penanganan yang tepat waktu, komprehensif, dan berbasis bukti sangat krusial dalam mendukung pemulihan psikologis dan kesejahteraan ibu, bayi, serta keluarganya secara keseluruhan.

Penanganan trauma meliputi:

1. Intervensi psikologis dini dengan konseling trauma.

Intervensi psikologis sejak dini merupakan langkah penting untuk mencegah trauma menjadi kronis dan semakin berat. Konseling trauma dilakukan segera setelah ibu menunjukkan tanda-tanda awal trauma, seperti cemas berlebih, kesedihan yang mendalam, mimpi buruk, atau perasaan tidak berdaya akibat pengalaman kehamilan atau persalinan yang negatif.

Dalam konseling trauma, tenaga kesehatan, khususnya bidan atau psikolog, membantu ibu mengeksplorasi secara aman perasaan, pikiran, dan emosi yang terkait dengan peristiwa traumatis. Konseling ini juga bertujuan untuk membantu ibu memahami bahwa reaksi emosional yang dialami adalah normal sebagai respons terhadap situasi yang berat dan luar biasa tersebut. Intervensi dini ini secara signifikan membantu ibu memproses dan memahami traumanya sehingga tidak berkembang menjadi gangguan emosional yang lebih serius.

2. Terapi kognitif perilaku (Cognitive Behavioral Therapy - CBT).

Terapi kognitif perilaku atau Cognitive Behavioral Therapy (CBT) adalah pendekatan psikoterapi berbasis bukti yang terbukti efektif dalam menangani berbagai bentuk trauma, termasuk trauma dalam konteks kebidanan. CBT berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Dalam konteks kebidanan, terapi ini membantu ibu untuk mengidentifikasi dan menantang pikiran-pikiran negatif yang muncul akibat trauma, serta menggantinya dengan cara berpikir yang lebih positif dan realistis.

CBT melibatkan teknik-teknik seperti restrukturisasi kognitif (mengubah pola pikir negatif), latihan relaksasi, manajemen stres, dan latihan eksposur bertahap (menghadapi kembali situasi atau ingatan traumatis secara aman). Melalui terapi ini, ibu akan secara bertahap mengurangi respons kecemasan terhadap ingatan traumatis dan mengembalikan kontrol emosional terhadap pengalaman yang telah dialaminya.

3. Dukungan kelompok atau support group.

Support group atau kelompok dukungan memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan trauma psikologis di bidang kebidanan. Kelompok dukungan merupakan wadah di mana ibu-ibu yang memiliki pengalaman serupa dapat berbagi cerita, pengalaman, perasaan, dan saling memberi dukungan emosional.

Dalam support group, ibu tidak hanya merasa bahwa dirinya tidak sendirian, tetapi juga mendapat kesempatan belajar dari pengalaman ibu lainnya dalam mengelola trauma. Kelompok ini sering dipandu oleh tenaga profesional, seperti psikolog atau bidan terlatih, yang membantu menjaga suasana aman, nyaman, dan saling mendukung. Partisipasi dalam support group terbukti membantu ibu mengurangi rasa isolasi, stigma, serta meningkatkan pemulihan psikologis dan memperkuat ketahanan emosionalnya.

4. Pemberdayaan keluarga sebagai sistem pendukung utama ibu.

Keluarga merupakan sistem pendukung yang utama dan paling dekat dengan ibu dalam proses pemulihan dari trauma psikologis. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga melalui edukasi, konseling keluarga, dan dukungan emosional sangat penting dalam upaya penanganan trauma.

Anggota keluarga, terutama pasangan, dilibatkan secara aktif untuk memahami kondisi trauma yang dialami ibu serta bagaimana cara memberikan dukungan emosional yang tepat, seperti memberi ruang untuk berbicara, mendengarkan tanpa menghakimi, dan membantu mengatasi beban harian ibu secara konkret (misalnya merawat bayi, membantu pekerjaan rumah tangga). Dukungan keluarga yang memadai tidak hanya mempercepat pemulihan trauma ibu tetapi juga mempererat hubungan emosional di dalam keluarga dan menciptakan lingkungan rumah yang lebih sehat dan harmonis.

5. Rujukan tepat waktu ke tenaga profesional kesehatan mental bila dibutuhkan.

Strategi terakhir yang juga sangat penting dalam penanganan trauma adalah rujukan yang tepat waktu kepada tenaga profesional kesehatan mental, seperti psikolog klinis, psikiater, atau konselor profesional, jika kondisi trauma semakin memburuk atau tidak membaik setelah upaya awal dilakukan oleh tenaga kebidanan.

Proses rujukan harus dilakukan secara bijaksana dan segera ketika ibu menunjukkan gejala yang lebih serius seperti depresi berat, gejala PTSD yang parah (misalnya kilas balik atau mimpi buruk yang terus-menerus), atau munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri maupun bayi. Rujukan tepat waktu ke ahli kesehatan mental profesional memungkinkan ibu untuk mendapatkan

penanganan yang lebih intensif, seperti terapi khusus atau pemberian obat-obatan jika diperlukan.

E. Latihan Soal

Soal Kasus 1

Seorang ibu hamil usia 26 tahun, G1P0A0 usia kehamilan 32 minggu datang ke bidan mengeluh cemas berlebihan, sulit tidur, dan sering menangis tiba-tiba. Ibu mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dari suaminya selama kehamilan ini. Apa tindakan awal yang paling tepat dilakukan oleh bidan?

- A. Memberikan suplemen tambahan
- B. Mengabaikan keluhan ibu karena merupakan hal biasa
- C. Melakukan konseling trauma dan memberi dukungan psikologis awal
- D. Segera merujuk ibu ke rumah sakit
- E. Memberikan obat tidur agar ibu istirahat cukup

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Langkah awal terbaik adalah memberikan konseling trauma serta dukungan psikologis yang tepat untuk membantu ibu mengatasi kecemasan dan stres akibat trauma kekerasan, sebelum melakukan tindakan rujukan lebih lanjut bila diperlukan.

Soal Kasus 2

Ibu usia 30 tahun baru saja melahirkan secara operasi sesar darurat akibat kondisi gawat janin. Setelah persalinan, ibu tampak gelisah, sering menangis, dan berulang kali mengatakan merasa takut saat mengingat proses persalinan. Apa diagnosis awal yang paling mungkin dialami ibu?

- A. Depresi postpartum berat
- B. Post Traumatic Stress Disorder postpartum
- C. Baby blues syndrome
- D. Gangguan bipolar
- E. Psikosis postpartum

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Gejala ketakutan ekstrem, kilas balik terhadap peristiwa persalinan traumatis, serta gangguan emosional yang intens sangat khas menggambarkan PTSD postpartum.

Soal Kasus 3

Seorang ibu postpartum hari ke-10 mengeluhkan kesulitan menyusui, merasa tidak mampu merawat bayinya dengan baik, dan merasa sendiri tanpa dukungan keluarga. Ibu sering menangis dan menunjukkan tanda-tanda isolasi sosial. Tindakan prioritas bidan yang paling tepat adalah?

- A. Merujuk segera ke psikiater
- B. Menyarankan ibu menghentikan menyusui agar lebih tenang
- C. Mengabaikan keluhan ibu karena dianggap wajar
- D. Mengajak keluarga berdiskusi dan memberikan edukasi dukungan
- E. Memberikan obat anti-depresan secara mandiri

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Langkah paling tepat adalah melibatkan keluarga untuk memberikan dukungan sosial dan emosional yang sangat dibutuhkan oleh ibu. Pendekatan ini efektif mengurangi perasaan isolasi dan membantu mengatasi trauma postpartum.

Soal Kasus 4

Seorang perempuan hamil usia 28 minggu dengan riwayat preeklamsia sebelumnya datang dengan keluhan sulit tidur, khawatir berlebihan tentang keselamatan bayinya, dan ketakutan menghadapi persalinan. Apa tindakan terbaik bidan untuk mencegah trauma lebih lanjut?

- A. Menyarankan ibu untuk segera rawat inap
- B. Memberikan pelatihan keterampilan relaksasi dan pengelolaan stres
- C. Memberikan suplementasi zat besi
- D. Merujuk segera ke psikolog klinis
- E. Menyarankan persalinan sesar terencana segera

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Pelatihan keterampilan relaksasi seperti teknik pernapasan, meditasi, dan mindfulness efektif membantu ibu mengelola stres dan kecemasan, sehingga trauma psikologis dapat dicegah sejak dini.

Soal Kasus 5

Seorang ibu postpartum 6 minggu mengalami mimpi buruk berulang, sulit tidur, dan sering mengalami kilas balik tentang persalinan yang traumatis akibat

episiotomi tanpa persetujuan jelas. Setelah dilakukan konseling awal, kondisi ibu tidak menunjukkan perbaikan signifikan. Apa tindakan terbaik selanjutnya?

- A. Melanjutkan konseling trauma secara mandiri oleh bidan
- B. Merujuk ibu ke dokter spesialis kandungan
- C. Menyarankan agar ibu istirahat total di rumah
- D. Merujuk segera ke psikolog atau psikiater profesional
- E. Memberikan suplemen tambahan untuk mengatasi kelelahan

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Ketika kondisi ibu tidak membaik setelah konseling awal, penting untuk segera merujuknya ke tenaga kesehatan mental profesional (psikolog atau psikiater) untuk mendapatkan terapi khusus seperti CBT yang intensif dan tepat sasaran.

F. Rangkuman Materi

Trauma psikologis merupakan respons emosional mendalam terhadap suatu peristiwa yang dirasakan sebagai ancaman serius terhadap keselamatan fisik maupun emosional seseorang. Trauma ini ditandai dengan berbagai gejala seperti ketakutan ekstrem, kecemasan berlebihan, perasaan tidak berdaya, gangguan tidur, hiper-vigilansi, dan kilas balik yang intens. Kondisi trauma dapat berkembang menjadi gangguan psikologis yang lebih serius, seperti PTSD, gangguan kecemasan, hingga depresi berat, sehingga memerlukan pendekatan penanganan komprehensif yang melibatkan terapi psikologis, dukungan sosial, serta intervensi medis jika diperlukan.

Dalam konteks kebidanan, trauma psikologis merupakan kondisi serius yang dapat terjadi selama masa kehamilan, persalinan, hingga postpartum. Beragam pemicu trauma pada masa kehamilan meliputi kekerasan dalam rumah tangga, komplikasi medis, kecemasan berlebihan tentang kesehatan bayi, serta ketakutan terhadap proses persalinan. Saat persalinan, trauma bisa muncul akibat proses persalinan yang sulit atau berkepanjangan, tindakan medis yang tidak sesuai ekspektasi ibu, dan komplikasi yang mengancam jiwa. Trauma postpartum dapat timbul dari pengalaman negatif selama persalinan yang tidak terselesaikan, kurangnya dukungan sosial, kesulitan adaptasi terhadap peran baru sebagai ibu, serta komplikasi seperti kesulitan menyusui dan gangguan kesehatan bayi. Trauma ini berdampak signifikan terhadap kesehatan mental ibu, hubungan ibu-bayi, serta dinamika keluarga secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pencegahan trauma dalam praktik kebidanan perlu diterapkan sejak awal kehamilan melalui edukasi realistis tentang kehamilan dan persalinan, dukungan psikologis yang memadai, pelatihan keterampilan relaksasi dan pengelolaan stres, peningkatan komunikasi efektif tenaga kesehatan, serta melibatkan ibu secara aktif dalam proses pengambilan keputusan medis.

Sementara itu, penanganan trauma yang efektif mencakup intervensi psikologis dini dengan konseling trauma, terapi kognitif perilaku (CBT), kelompok dukungan (support group), pemberdayaan keluarga sebagai pendukung utama, serta rujukan tepat waktu kepada tenaga profesional kesehatan mental jika kondisi ibu memerlukan intervensi lebih intensif. Dengan menerapkan pendekatan yang integratif, holistik, dan berbasis bukti ini, diharapkan dapat meminimalisasi dampak trauma psikologis, meningkatkan pemulihan emosional ibu, serta menciptakan pengalaman kehamilan, persalinan, dan postpartum yang lebih positif dan sehat secara psikologis bagi ibu dan keluarganya.

G. Glosarium

Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Pendekatan psikoterapi berbasis bukti yang bertujuan membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif, dengan tujuan mengurangi kecemasan dan memperbaiki respon emosional terhadap pengalaman traumatis.

Depresi Postpartum

Gangguan depresi yang terjadi pada ibu setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat, isolasi sosial, hingga pikiran negatif yang berlarut-larut setelah persalinan.

Flashbacks (Kilas Balik)

Pengalaman tiba-tiba di mana seseorang merasa seolah-olah kembali berada dalam situasi traumatis di masa lalu, menyebabkan rasa panik, cemas, atau ketakutan yang intens.

Gangguan Tidur

Kondisi di mana individu mengalami kesulitan tidur (insomnia), sering terbangun di malam hari, atau mengalami mimpi buruk yang menyebabkan kelelahan kronis.

Gangguan Stres Pascatrauma (Post Traumatic Stress Disorder - PTSD)

Gangguan psikologis berat yang muncul setelah individu mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis, ditandai dengan kilas balik, kecemasan berlebih, mimpi buruk, serta hiper-vigilansi.

Hiper-vigilansi

Keadaan kewaspadaan yang berlebihan, di mana seseorang terus-menerus merasa dalam bahaya, sangat sensitif terhadap lingkungan, serta mudah terkejut terhadap rangsangan yang sebenarnya tidak berbahaya.

Intervensi Psikologis Dini

Pendekatan berupa konseling atau terapi awal untuk menangani trauma sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, biasanya dilakukan segera setelah gejala trauma muncul.

Kecemasan Berlebihan (Ansietas)

Perasaan khawatir dan takut yang berlangsung terus-menerus tanpa alasan jelas atau berlebihan terhadap situasi tertentu, sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, emosional, atau seksual yang dapat menyebabkan trauma psikologis serius bagi korban.

Konseling Trauma

Proses konsultasi dengan tenaga profesional untuk membantu individu mengelola, memahami, dan memproses perasaan, pikiran, serta emosi terkait pengalaman traumatis secara aman dan efektif.

Pelatihan Relaksasi

Teknik-teknik seperti meditasi, mindfulness, yoga prenatal, visualisasi positif, pernapasan dalam, dan relaksasi otot progresif yang bertujuan mengurangi stres, cemas, serta membantu ibu mengelola rasa sakit selama persalinan.

Pemberdayaan Keluarga

Proses edukasi dan konseling keluarga agar mampu memberikan dukungan emosional, psikologis, dan praktis yang optimal kepada ibu yang mengalami trauma, terutama setelah persalinan.

Persalinan Traumatis

Pengalaman persalinan yang menimbulkan dampak emosional negatif seperti perasaan takut ekstrem, rasa tidak berdaya, kehilangan kendali atas situasi, atau perlakuan medis yang tidak diinginkan.

Shared Decision-Making

Pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan medis antara ibu dan tenaga kesehatan berdasarkan informasi yang jelas dan transparan, mempertimbangkan preferensi pribadi ibu sehingga meningkatkan rasa kontrol dan kepuasan pasien.

Support Group (Kelompok Dukungan)

Kelompok kecil yang terdiri dari individu dengan pengalaman serupa, bertujuan untuk saling berbagi cerita, memberi dukungan emosional, dan membantu anggotanya mengurangi isolasi serta meningkatkan ketahanan emosional.

Tokophobia

Ketakutan ekstrem terhadap proses persalinan yang dialami oleh sebagian ibu hamil, yang dapat menyebabkan kecemasan berlebih, stres berat, bahkan trauma psikologis.

Trauma Psikologis

Respons emosional mendalam terhadap kejadian yang dirasakan mengancam keselamatan fisik atau emosional seseorang, meninggalkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan kualitas hidup.

Trauma Postpartum

Trauma psikologis yang dialami setelah proses persalinan, dipicu oleh pengalaman negatif selama persalinan, kurangnya dukungan sosial, kesulitan adaptasi peran sebagai ibu, atau komplikasi postpartum seperti kesulitan menyusui.

Trauma selama Kehamilan

Respons emosional serius yang timbul akibat berbagai faktor pemicu selama masa kehamilan seperti kekerasan rumah tangga, komplikasi medis, kecemasan berlebihan terhadap kesehatan bayi, atau ketakutan menghadapi persalinan.

H. Daftar Pustaka

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Ayers, S., Bond, R., Bertullies, S., & Wijma, K. (2016). The aetiology of post-traumatic stress following childbirth: A meta-analysis and theoretical framework. *Psychological Medicine*, 46(6), 1121-1134. <https://doi.org/10.1017/S0033291715002706>
- Beck, C. T., Driscoll, J. W., & Watson, S. (2013). *Traumatic childbirth*. Routledge.
- Dekel, S., Stuebe, C., & Dishy, G. (2017). Childbirth induced posttraumatic stress syndrome: A systematic review of prevalence and risk factors. *Frontiers in Psychology*, 8, 560. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00560>
- Ford, J. D., & Courtois, C. A. (2020). *Treating complex traumatic stress disorders in adults: Scientific foundations and therapeutic models* (2nd ed.). Guilford Press.
- Garthus-Niegel, S., von Soest, T., Vollrath, M. E., & Eberhard-Gran, M. (2013). The impact of subjective birth experiences on post-traumatic stress symptoms: A

longitudinal study. *Archives of Women's Mental Health*, 16(1), 1-10.
<https://doi.org/10.1007/s00737-012-0301-3>

Howard, L. M., Molyneaux, E., Dennis, C.-L., Rochat, T., Stein, A., & Milgrom, J. (2014). Non-psychotic mental disorders in the perinatal period. *The Lancet*, 384(9956), 1775-1788. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)61276-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61276-9)

Leahy, R. L., Holland, S. J., & McGinn, L. K. (2012). *Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders* (2nd ed.). Guilford Press.

Simkin, P., & Klaus, P. (2014). *When survivors give birth: Understanding and healing the effects of early sexual abuse on childbearing women*. Classic Day Publishing.

Simpson, M., & Catling, C. (2016). Understanding psychological traumatic birth experiences: A literature review. *Women and Birth*, 29(3), 203-207. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2015.10.009>

van der Kolk, B. A. (2015). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Penguin Books.

Yildiz, P. D., Ayers, S., & Phillips, L. (2017). The prevalence of posttraumatic stress disorder in pregnancy and after birth: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 208, 634-645. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.10.009>

BAB 6

KESEHATAN MENTAL PADA PERINATAL: DEPRESI DAN KECEMASAN PERINATAL, CLINICAL RESOURCES FOR PREFFESIONAL

CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Mahasiswa mampu memahami dan mengelola gangguan kesehatan mental perinatal berupa depresi dan kecemasan, serta mampu menggunakan sumber daya klinis secara efektif untuk mendukung praktik kebidanan yang aman dan berbasis bukti.

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, serta menangani kasus depresi dan kecemasan perinatal, serta mampu menggunakan sumber daya klinis yang relevan untuk memberikan perawatan optimal kepada ibu perinatal.

Sub-CPMK (Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep, penyebab, dan faktor risiko depresi dan kecemasan perinatal.
- Mengidentifikasi gejala klinis depresi dan kecemasan perinatal melalui asesmen yang komprehensif.
- Merancang dan menerapkan strategi penanganan awal yang tepat untuk depresi dan kecemasan perinatal.
- Menggunakan berbagai clinical resources untuk mendukung penatalaksanaan kasus kesehatan mental perinatal secara efektif.

Pendahuluan

Masa perinatal merupakan periode yang signifikan dalam kehidupan seorang perempuan, mencakup waktu selama kehamilan hingga satu tahun setelah kelahiran bayi. Periode ini membawa perubahan besar secara fisik, psikologis, emosional, dan sosial, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan perinatal. Depresi dan kecemasan pada masa ini dapat memiliki dampak jangka panjang, baik bagi ibu, bayi, maupun keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi bidan dan tenaga kesehatan lain untuk memahami secara mendalam tentang gangguan ini, deteksi dini, dan penanganannya secara efektif serta berbasis bukti.

Pembahasan Materi

Uraian Materi

A. Depresi Perinatal

Depresi perinatal merupakan suatu kondisi gangguan suasana hati yang terjadi pada masa perinatal, yaitu periode yang mencakup masa kehamilan hingga satu tahun setelah kelahiran bayi. Kondisi ini tidak hanya sebatas perasaan sedih yang lazim dialami oleh ibu, tetapi merupakan sebuah kondisi klinis yang ditandai oleh gejala emosional yang sangat mendalam dan berlangsung lama, sehingga dapat mengganggu fungsi keseharian ibu dalam merawat diri sendiri dan bayinya.

Depresi perinatal dibagi menjadi dua kategori besar, yakni depresi antenatal yang muncul selama masa kehamilan, dan depresi postpartum yang terjadi setelah melahirkan. Kedua kondisi ini memiliki gejala yang serupa namun dapat berbeda intensitas dan dampaknya pada masing-masing individu. Secara umum, gejala utama dari depresi perinatal adalah perasaan sedih yang mendalam dan persisten, di mana ibu merasakan hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari yang biasanya menyenangkan, seperti merawat diri, interaksi sosial, dan aktivitas yang berhubungan dengan bayinya.

Selain gejala emosional tersebut, depresi perinatal juga ditandai dengan perubahan fisik seperti gangguan tidur yang signifikan, baik sulit tidur maupun tidur berlebihan, serta gangguan pada nafsu makan yang bisa berupa kehilangan nafsu makan atau justru makan secara berlebihan. Gejala-gejala ini sering disertai rasa lelah yang sangat ekstrem, yang tidak hilang meskipun ibu telah beristirahat cukup. Selain itu, ibu juga sering mengalami kesulitan konsentrasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau bahkan dalam menjalankan tugas-tugas sederhana, yang bisa mengganggu fungsi sosial, rumah tangga, maupun pekerjaan.

Salah satu gejala paling serius dari depresi perinatal adalah munculnya perasaan bersalah dan tidak berharga yang intens, yang membuat ibu merasa tidak layak atau tidak mampu dalam menjalani peran sebagai seorang ibu. Pada beberapa kasus yang lebih parah, kondisi ini dapat berkembang hingga munculnya pikiran tentang kematian atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengenali gejala-gejala ini sejak dini guna mencegah perkembangan kondisi yang lebih serius.

Faktor risiko munculnya depresi perinatal sangat beragam dan kompleks. Salah satu faktor risiko yang paling kuat adalah riwayat gangguan mental sebelumnya, terutama riwayat depresi atau kecemasan yang pernah dialami ibu sebelum kehamilan. Faktor lainnya adalah kurangnya dukungan sosial, baik dari

pasangan, keluarga, atau lingkungan sosial terdekat. Kondisi ini semakin berat apabila terdapat masalah hubungan dengan pasangan, seperti konflik berkepanjangan atau minimnya keterlibatan pasangan dalam proses kehamilan dan perawatan bayi. Stres keuangan juga merupakan faktor yang berpengaruh besar, karena tekanan ekonomi yang berat sering kali menyebabkan ibu mengalami kecemasan yang berlebihan, yang kemudian berkembang menjadi depresi.

Selain faktor-faktor psikososial tersebut, komplikasi medis selama kehamilan atau persalinan juga dapat menjadi pemicu timbulnya depresi perinatal. Komplikasi seperti preeklamsia, kelahiran prematur, atau proses persalinan yang sulit, dapat menyebabkan ibu mengalami trauma fisik maupun psikologis yang kemudian meningkatkan risiko terjadinya depresi.

Mengingat dampak serius dari depresi perinatal terhadap kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan, maka deteksi dini merupakan langkah penting dalam penanganan kondisi ini. Deteksi dini dilakukan melalui skrining secara rutin dengan menggunakan instrumen yang telah terbukti efektif, salah satunya adalah Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Instrumen ini berupa kuesioner singkat yang menilai tingkat keparahan gejala depresi yang dialami oleh ibu. Dengan menggunakan EPDS secara rutin, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi ibu yang berisiko tinggi mengalami depresi perinatal secara dini, sehingga intervensi seperti konseling psikologis, psikoterapi, atau pengobatan farmakologis dapat segera diberikan secara tepat waktu dan efektif.

Intervensi dini tersebut sangat krusial dalam mencegah komplikasi jangka panjang, seperti gangguan bonding antara ibu dan bayi, hambatan perkembangan psikososial anak, dan terganggunya keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai depresi perinatal serta implementasi praktik skrining dan intervensi yang konsisten merupakan komponen penting dalam upaya menjaga kesehatan mental ibu dan keluarga pada periode perinatal.

B. Kecemasan Perinatal

Kecemasan perinatal merupakan suatu gangguan psikologis berupa rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan berlangsung secara terus-menerus pada masa perinatal, yaitu sejak awal masa kehamilan hingga periode setelah kelahiran bayi (postpartum). Depresi perinatal merupakan suatu kondisi gangguan suasana hati yang terjadi pada masa perinatal, yaitu periode yang mencakup masa kehamilan hingga satu tahun setelah kelahiran bayi. Kondisi ini tidak hanya sebatas perasaan sedih yang lazim dialami oleh ibu, tetapi merupakan sebuah kondisi klinis

yang ditandai oleh gejala emosional yang sangat mendalam dan berlangsung lama, sehingga dapat mengganggu fungsi keseharian ibu dalam merawat diri sendiri dan bayinya.

Depresi perinatal dibagi menjadi dua kategori besar, yakni depresi antenatal yang muncul selama masa kehamilan, dan depresi postpartum yang terjadi setelah melahirkan. Kedua kondisi ini memiliki gejala yang serupa namun dapat berbeda intensitas dan dampaknya pada masing-masing individu. Secara umum, gejala utama dari depresi perinatal adalah perasaan sedih yang mendalam dan persisten, di mana ibu merasakan hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari yang biasanya menyenangkan, seperti merawat diri, interaksi sosial, dan aktivitas yang berhubungan dengan bayinya.

Selain gejala emosional tersebut, depresi perinatal juga ditandai dengan perubahan fisik seperti gangguan tidur yang signifikan, baik sulit tidur maupun tidur berlebihan, serta gangguan pada nafsu makan yang bisa berupa kehilangan nafsu makan atau justru makan secara berlebihan. Gejala-gejala ini sering disertai rasa lelah yang sangat ekstrem, yang tidak hilang meskipun ibu telah beristirahat cukup. Selain itu, ibu juga sering mengalami kesulitan konsentrasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau bahkan dalam menjalankan tugas-tugas sederhana, yang bisa mengganggu fungsi sosial, rumah tangga, maupun pekerjaan.

Salah satu gejala paling serius dari depresi perinatal adalah munculnya perasaan bersalah dan tidak berharga yang intens, yang membuat ibu merasa tidak layak atau tidak mampu dalam menjalani peran sebagai seorang ibu. Pada beberapa kasus yang lebih parah, kondisi ini dapat berkembang hingga munculnya pikiran tentang kematian atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengenali gejala-gejala ini sejak dini guna mencegah perkembangan kondisi yang lebih serius.

Faktor risiko munculnya depresi perinatal sangat beragam dan kompleks. Salah satu faktor risiko yang paling kuat adalah riwayat gangguan mental sebelumnya, terutama riwayat depresi atau kecemasan yang pernah dialami ibu sebelum kehamilan. Faktor lainnya adalah kurangnya dukungan sosial, baik dari pasangan, keluarga, atau lingkungan sosial terdekat. Kondisi ini semakin berat apabila terdapat masalah hubungan dengan pasangan, seperti konflik berkepanjangan atau minimnya keterlibatan pasangan dalam proses kehamilan dan perawatan bayi. Stres keuangan juga merupakan faktor yang berpengaruh besar, karena tekanan ekonomi yang berat sering kali menyebabkan ibu mengalami kecemasan yang berlebihan, yang kemudian berkembang menjadi depresi.

Selain faktor-faktor psikososial tersebut, komplikasi medis selama kehamilan atau persalinan juga dapat menjadi pemicu timbulnya depresi perinatal. Komplikasi seperti preeklamsia, kelahiran prematur, atau proses persalinan yang sulit, dapat menyebabkan ibu mengalami trauma fisik maupun psikologis yang kemudian meningkatkan risiko terjadinya depresi.

Mengingat dampak serius dari depresi perinatal terhadap kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan, maka deteksi dini merupakan langkah penting dalam penanganan kondisi ini. Deteksi dini dilakukan melalui skrining secara rutin dengan menggunakan instrumen yang telah terbukti efektif, salah satunya adalah Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Instrumen ini berupa kuesioner singkat yang menilai tingkat keparahan gejala depresi yang dialami oleh ibu. Dengan menggunakan EPDS secara rutin, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi ibu yang berisiko tinggi mengalami depresi perinatal secara dini, sehingga intervensi seperti konseling psikologis, psikoterapi, atau pengobatan farmakologis dapat segera diberikan secara tepat waktu dan efektif.

Intervensi dini tersebut sangat krusial dalam mencegah komplikasi jangka panjang, seperti gangguan bonding antara ibu dan bayi, hambatan perkembangan psikososial anak, dan terganggunya keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai depresi perinatal serta implementasi praktik skrining dan intervensi yang konsisten merupakan komponen penting dalam upaya menjaga kesehatan mental ibu dan keluarga pada periode perinatal.

Berbeda dengan rasa khawatir atau cemas yang wajar yang dialami oleh hampir semua ibu hamil maupun ibu baru, kecemasan perinatal bersifat lebih intens, berlebihan, sulit dikontrol, dan dapat mengganggu kemampuan ibu dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta dalam menjalankan perannya sebagai seorang ibu.

Gejala-gejala kecemasan perinatal yang paling umum adalah perasaan khawatir yang terus-menerus tentang berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama yang terkait dengan kehamilan, persalinan, dan kondisi bayi setelah dilahirkan. Rasa khawatir ini biasanya sulit untuk dikendalikan dan sering kali tidak proporsional terhadap kenyataan atau situasi sebenarnya yang sedang dihadapi. Ibu juga sering merasa gelisah tanpa alasan yang jelas, mengalami ketegangan emosional, serta mudah marah bahkan terhadap hal-hal yang sederhana sekalipun.

Selain gejala psikologis, kecemasan perinatal juga sering disertai oleh berbagai gejala fisik. Di antaranya adalah jantung berdebar-debar (palpitasi), sesak napas, rasa mual yang persisten, gangguan pencernaan, hingga rasa pusing.

Gangguan tidur juga merupakan gejala yang sangat umum terjadi, yang ditandai oleh kesulitan untuk tidur nyenyak, terbangun secara tiba-tiba di malam hari, atau bahkan mengalami insomnia kronis. Semua gejala tersebut dapat memperparah kondisi ibu secara fisik dan psikologis, mengurangi energi ibu, dan memengaruhi kualitas hidup serta kesejahteraan ibu dan bayinya.

Faktor risiko munculnya kecemasan perinatal sangat bervariasi dan kompleks. Salah satu faktor paling kuat adalah riwayat gangguan kecemasan yang pernah dialami oleh ibu sebelumnya. Ibu yang sebelumnya pernah mengalami gangguan kecemasan, depresi, atau trauma psikologis lainnya cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kecemasan perinatal. Pengalaman kehamilan atau persalinan traumatis pada masa lalu juga menjadi faktor risiko utama, di mana ibu yang pernah mengalami komplikasi medis atau situasi darurat selama persalinan sebelumnya, cenderung akan lebih mudah mengalami kecemasan pada kehamilan berikutnya.

Kurangnya dukungan emosional dari pasangan maupun keluarga terdekat juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya kecemasan perinatal. Dukungan sosial yang minim atau tidak adekuat membuat ibu merasa sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perinatal, sehingga memperbesar risiko munculnya rasa cemas. Selain itu, kekhawatiran berlebihan tentang kondisi kesehatan bayi, ketakutan akan cacat bawaan, kelainan janin, atau komplikasi selama persalinan juga menjadi faktor pemicu yang sering kali memperparah kecemasan perinatal.

Mengingat dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan, kecemasan perinatal memerlukan intervensi yang tepat dan efektif sedini mungkin. Salah satu intervensi yang terbukti efektif adalah konseling psikologis. Melalui konseling, ibu dapat mengekspresikan kekhawatirannya secara terbuka dalam lingkungan yang aman dan mendapat bimbingan profesional untuk mengelola pikiran serta perasaan cemas secara lebih sehat. Dalam banyak kasus, konseling juga membantu ibu dalam memperbaiki pola komunikasi dengan pasangan maupun keluarga, sehingga meningkatkan dukungan emosional yang diterima.

Selain konseling psikologis, teknik relaksasi juga sangat dianjurkan sebagai bagian dari intervensi kecemasan perinatal. Teknik-teknik seperti latihan pernapasan dalam, meditasi, yoga prenatal, atau metode mindfulness terbukti membantu ibu menurunkan tingkat stres dan kecemasan secara signifikan.

Pelaksanaan teknik relaksasi ini dapat diintegrasikan dalam rutinitas harian ibu, sehingga memberikan manfaat jangka panjang dalam pengelolaan kecemasan.

Edukasi tentang manajemen stres juga menjadi bagian penting dalam intervensi kecemasan perinatal. Edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada ibu mengenai cara-cara yang efektif dalam mengelola situasi stres selama kehamilan maupun periode postpartum. Informasi tentang pengaturan waktu, manajemen tugas rumah tangga, dan pemanfaatan sumber daya sosial merupakan aspek yang kerap dibahas dalam edukasi tersebut.

Dalam kasus-kasus yang lebih berat atau kompleks, rujukan kepada profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater menjadi sangat penting. Para profesional ini dapat memberikan intervensi yang lebih spesifik dan intensif seperti psikoterapi atau bahkan terapi farmakologis jika diperlukan.

Secara keseluruhan, pendekatan intervensi yang komprehensif, meliputi deteksi dini, dukungan psikologis, teknik relaksasi, edukasi, serta kolaborasi dengan profesional kesehatan mental sangatlah penting guna memastikan ibu dapat melewati masa perinatal dengan lebih sehat secara mental, sehingga meningkatkan kualitas hidup ibu, bayi, dan seluruh keluarganya.

C. Clinical Resources for Professionals

Clinical resources atau sumber daya klinis merupakan kumpulan alat, panduan, instrumen, serta layanan yang digunakan oleh tenaga kesehatan, khususnya profesional kebidanan, untuk mendukung pelayanan yang efektif, aman, dan berbasis bukti dalam penanganan kasus-kasus kesehatan mental perinatal. Penggunaan clinical resources yang tepat dapat membantu bidan dan tenaga kesehatan lain dalam mengidentifikasi, mendiagnosis, memberikan intervensi dini, serta mengelola berbagai kondisi psikologis yang dialami ibu selama periode perinatal secara lebih optimal.

Berbagai sumber daya klinis yang penting dalam praktik kebidanan dalam konteks kesehatan mental perinatal antara lain sebagai berikut:

1. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

EPDS merupakan sebuah instrumen atau skala skrining yang secara khusus dikembangkan untuk mendeteksi gejala-gejala depresi pada ibu hamil dan postpartum. EPDS terdiri dari 10 pertanyaan yang mengukur berbagai aspek gejala depresi seperti suasana hati yang buruk, kecemasan, gangguan tidur, hilangnya semangat hidup, dan pikiran tentang mencelakai diri sendiri. EPDS memiliki validitas dan reliabilitas tinggi serta telah digunakan secara luas di

seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penggunaan instrumen ini sangat penting, karena memungkinkan tenaga kebidanan mendeteksi dini tanda-tanda depresi sebelum kondisi ini berkembang menjadi lebih berat dan kompleks. Hasil skor EPDS dapat menentukan apakah ibu memerlukan intervensi lebih lanjut, konseling intensif, atau rujukan segera ke tenaga kesehatan mental profesional.

2. Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7)

Skala GAD-7 adalah instrumen skrining yang secara khusus digunakan untuk mendeteksi gejala kecemasan umum pada ibu selama masa kehamilan dan setelah melahirkan. GAD-7 terdiri dari 7 pertanyaan yang mengevaluasi tingkat kecemasan melalui gejala-gejala seperti rasa cemas berlebihan, sulit mengontrol pikiran cemas, sulit berkonsentrasi, gelisah, mudah tersinggung, gangguan tidur, serta berbagai gejala fisik seperti palpitasi atau mual. Penggunaan GAD-7 membantu tenaga kebidanan untuk membedakan antara kecemasan ringan yang umum dialami oleh ibu hamil dan kecemasan patologis yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan deteksi dini melalui GAD-7, tenaga kebidanan dapat memberikan edukasi, konseling, atau bahkan rujukan kepada spesialis kesehatan mental secara tepat waktu, sehingga meningkatkan prognosis dan kualitas hidup ibu dan bayi secara keseluruhan.

3. Guidelines dan Panduan Klinis Terbaru dari Organisasi Kredibel (WHO, NICE, ACOG)

Tenaga kebidanan perlu selalu memperbaharui pengetahuannya mengenai praktik berbasis bukti dalam penanganan kesehatan mental perinatal melalui panduan klinis atau clinical guidelines yang diterbitkan oleh organisasi terpercaya secara internasional. Organisasi seperti WHO (World Health Organization), NICE (National Institute for Health and Care Excellence, Inggris), dan ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists, Amerika Serikat) secara berkala menerbitkan panduan yang komprehensif mengenai standar skrining, diagnosis, dan intervensi dalam kesehatan mental perinatal. Guidelines ini mencakup berbagai aspek mulai dari rekomendasi tentang penggunaan obat, pendekatan psikososial yang efektif, hingga rencana penanganan pada kasus-kasus kompleks seperti risiko bunuh diri atau kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mengacu pada panduan klinis ini, profesional kebidanan dapat memastikan bahwa praktik yang mereka lakukan tetap sesuai dengan standar ilmiah terkini, aman, dan efektif.

4. Pelatihan Lanjutan dalam Bidang Kesehatan Mental Perinatal (CBT dan Mindfulness)

Pelatihan lanjutan dalam bidang kesehatan mental perinatal sangat diperlukan bagi tenaga kebidanan untuk memperkaya keterampilan klinis mereka. Dua jenis intervensi yang efektif dan populer dalam manajemen kesehatan mental perinatal adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dan intervensi berbasis mindfulness.

- a. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) merupakan terapi psikologis yang bertujuan membantu individu untuk mengenali, memahami, dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku maladaptif yang memperburuk kondisi kecemasan atau depresi. Pelatihan CBT untuk tenaga kebidanan memungkinkan mereka memberikan dukungan psikologis yang lebih mendalam dan efektif kepada ibu, khususnya dalam mengatasi stres atau gejala-gejala ringan hingga sedang.
- b. Intervensi berbasis mindfulness membantu ibu dalam mengelola kecemasan dan stres melalui latihan relaksasi, meditasi, dan kesadaran penuh terhadap sensasi tubuh serta lingkungan sekitarnya. Melalui pelatihan ini, tenaga kebidanan dapat mengajarkan ibu teknik-teknik sederhana untuk mengurangi stres, meningkatkan ketenangan emosional, dan memperkuat kemampuan ibu dalam menghadapi tantangan psikologis selama masa perinatal.

5. Layanan Rujukan ke Profesional Kesehatan Mental (Psikolog Klinis, Psikiater, atau Pusat Layanan Khusus)

Tidak semua kasus kesehatan mental perinatal dapat ditangani secara mandiri oleh tenaga kebidanan, terutama pada kondisi yang serius atau kompleks. Oleh karena itu, keberadaan jaringan rujukan atau referral system ke layanan spesialis kesehatan mental sangat penting dalam praktik kebidanan. Layanan ini meliputi rujukan ke psikolog klinis untuk intervensi psikoterapi intensif, psikiater untuk terapi farmakologis apabila diperlukan, atau pusat layanan kesehatan mental perinatal khusus yang menyediakan pelayanan komprehensif bagi ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Rujukan yang tepat waktu memastikan bahwa ibu mendapatkan intervensi profesional sesuai kebutuhan klinisnya, sehingga mencegah komplikasi jangka panjang serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan keluarga secara keseluruhan.

Dengan pemanfaatan secara maksimal dari sumber daya klinis yang tersedia ini, profesional kebidanan akan mampu memberikan pelayanan kesehatan mental perinatal yang lebih komprehensif, aman, efektif, dan berbasis bukti kepada ibu dan keluarganya. Hal ini pada akhirnya akan mendukung

tercapainya kesejahteraan mental, emosional, dan fisik ibu serta pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi.

D. Latihan Soal

Soal Kasus 1 (Depresi Perinatal)

Seorang ibu, usia 27 tahun, melahirkan anak pertamanya dua bulan lalu di sebuah klinik kebidanan. Saat kunjungan nifas, ibu mengaku sering menangis tanpa sebab jelas, merasa sangat lelah, tidak tertarik merawat bayinya, dan mengungkapkan perasaan bersalah karena merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik. Ia juga sulit tidur dan makan lebih sedikit dibandingkan biasanya.

Apa tindakan pertama yang paling tepat dilakukan bidan dalam kasus ini?

- A. Memberikan vitamin untuk meningkatkan energi
- B. Menyarankan ibu untuk memperbanyak istirahat saja
- C. Merujuk ibu segera ke layanan kesehatan mental profesional
- D. Meminta keluarga untuk lebih banyak membantu merawat bayi
- E. Memberikan edukasi bahwa kondisi ini normal dialami setelah melahirkan

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Gejala yang dialami ibu menunjukkan depresi postpartum yang memerlukan intervensi segera oleh profesional kesehatan mental. Merujuk ke psikolog atau psikiater akan membantu ibu mendapatkan terapi atau konseling intensif lebih lanjut.

Soal Kasus 2 (Kecemasan Perinatal)

Seorang ibu hamil usia 32 minggu datang ke TPMB mengeluhkan sulit tidur, rasa gelisah terus-menerus, dan cemas berlebihan terhadap kondisi janinnya. Ia sering merasa mual, berdebar-debar, dan khawatir tanpa sebab yang jelas. Riwayat sebelumnya ibu pernah mengalami keguguran pada kehamilan pertama.

Apa tindakan awal yang paling tepat dilakukan bidan?

- A. Memberikan rujukan segera ke spesialis kandungan
- B. Menyarankan ibu agar minum obat penenang secara mandiri
- C. Memberikan edukasi tentang teknik relaksasi dan manajemen stres
- D. Meminta ibu menjalani pemeriksaan USG lebih sering
- E. Menyarankan ibu untuk mengabaikan perasaan tersebut

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Kecemasan yang dialami ibu dipengaruhi oleh riwayat keguguran sebelumnya. Tindakan awal yang paling tepat adalah memberikan edukasi tentang teknik relaksasi dan manajemen stres, yang terbukti efektif dalam mengurangi gejala kecemasan perinatal.

Soal Kasus 3 (Clinical Resources - EPDS)

Seorang bidan di Puskesmas sedang melakukan kunjungan rumah pada ibu postpartum 4 minggu. Ibu tampak murung, kurang berinteraksi dengan bayinya, dan terlihat kehilangan semangat hidup. Untuk memastikan kondisi emosional ibu, instrumen klinis apakah yang paling tepat digunakan bidan?

- A. Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7)
- B. Beck Depression Inventory (BDI)
- C. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
- D. Hamilton Rating Scale for Anxiety (HAM-A)
- E. Postpartum Depression Screening Scale (PDSS)

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) merupakan instrumen khusus dan paling tepat untuk mendeteksi dini depresi perinatal, khususnya pada masa postpartum, yang relevan dengan gejala yang ditunjukkan ibu dalam kasus ini.

Soal Kasus 4 (Clinical Resources – GAD-7)

Seorang ibu hamil usia 20 minggu datang ke bidan mengeluhkan sering merasa gelisah, sulit berkonsentrasi, dan tidur yang terganggu akibat pikiran cemas berlebihan. Ibu juga merasakan keluhan fisik seperti jantung berdebar dan pusing tanpa sebab medis jelas. Alat skrining apa yang paling tepat digunakan bidan untuk mengidentifikasi kondisi ibu?

- A. Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
- B. Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7)
- C. Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D)
- D. Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
- E. State-Trait Anxiety Inventory (STAI)

Kunci Jawaban: B

Rasional:

GAD-7 merupakan instrumen skrining khusus untuk kecemasan umum yang efektif digunakan selama masa perinatal. Instrumen ini paling tepat untuk membantu bidan mengidentifikasi gejala kecemasan berlebihan pada ibu hamil tersebut.

Soal Kasus 5 (Clinical Resources – Rujukan Profesional)

Seorang ibu usia 30 tahun, postpartum 6 minggu, menunjukkan gejala depresi berat seperti perasaan putus asa, tidak mampu merawat bayi, bahkan mulai menunjukkan pikiran tentang bunuh diri. Keluarga ibu tampak sangat cemas dan meminta bantuan kepada bidan yang merawat.

Apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh bidan dalam situasi ini?

- A. Memberikan edukasi umum tentang kondisi postpartum blues
- B. Merujuk ibu segera ke psikolog klinis atau psikiater
- C. Mengajarkan keluarga cara merawat bayi lebih intensif
- D. Menyarankan ibu untuk melakukan meditasi mandiri
- E. Menyuruh keluarga memberikan perhatian lebih pada ibu di rumah

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Gejala depresi berat dengan pikiran tentang bunuh diri membutuhkan penanganan segera dari profesional kesehatan mental seperti psikolog klinis atau psikiater. Intervensi cepat dapat menyelamatkan nyawa ibu dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

E. Rangkuman Materi

Depresi perinatal dan kecemasan perinatal merupakan dua kondisi gangguan psikologis yang sangat signifikan dalam periode perinatal, yaitu sejak kehamilan hingga satu tahun setelah kelahiran bayi. Kedua kondisi ini memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental ibu, hubungan keluarga, dan perkembangan bayi secara keseluruhan. Depresi perinatal ditandai oleh perasaan sedih yang mendalam, hilangnya minat, gangguan tidur, perubahan nafsu makan, hingga munculnya rasa bersalah dan pikiran bunuh diri. Kecemasan perinatal ditandai oleh kecemasan berlebihan, sulit dikontrol, gangguan tidur, serta gejala fisik seperti jantung berdebar, mual, dan gelisah berlebihan. Faktor risiko utama dari kedua gangguan ini mencakup riwayat gangguan mental sebelumnya, kurangnya dukungan sosial, pengalaman kehamilan atau persalinan traumatis, dan stresor lingkungan seperti masalah hubungan pasangan maupun keuangan.

Deteksi dini sangat penting dilakukan melalui penggunaan instrumen klinis seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) untuk depresi perinatal dan Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7) untuk kecemasan perinatal. Penggunaan instrumen ini memungkinkan tenaga kebidanan mengidentifikasi kondisi psikologis ibu secara cepat dan akurat, sehingga intervensi dapat segera diberikan. Intervensi yang efektif meliputi konseling psikologis, terapi perilaku

kognitif (CBT), teknik relaksasi berbasis mindfulness, edukasi pengelolaan stres, serta rujukan ke profesional kesehatan mental untuk kasus-kasus yang lebih kompleks.

Agar intervensi dapat berjalan optimal, tenaga kebidanan perlu secara rutin memperbarui pengetahuan melalui panduan klinis terbaru dari organisasi internasional seperti WHO, NICE, dan ACOG, serta mengikuti pelatihan lanjutan khusus dalam bidang kesehatan mental perinatal. Selain itu, sistem rujukan yang terintegrasi dan efektif kepada psikolog klinis, psikiater, maupun pusat layanan kesehatan mental perinatal juga merupakan komponen kunci dalam manajemen kesehatan mental perinatal.

Dengan pendekatan yang komprehensif, kolaborasi multidisiplin, serta pemanfaatan maksimal dari clinical resources yang tersedia, profesional kebidanan mampu memberikan pelayanan berbasis bukti yang efektif, aman, dan berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan selama masa perinatal.

F. Glosarium

Depresi Perinatal

Gangguan suasana hati yang serius dan berkepanjangan, terjadi selama masa kehamilan hingga satu tahun setelah melahirkan, ditandai oleh rasa sedih mendalam, hilang minat, rasa bersalah, gangguan tidur dan nafsu makan, serta terkadang muncul pikiran ingin mencelakai diri sendiri.

Depresi Antenatal

Depresi yang terjadi selama masa kehamilan dengan gejala yang mirip depresi pada umumnya, tetapi khusus muncul saat ibu masih mengandung.

Depresi Postpartum

Depresi yang dialami ibu setelah melahirkan, umumnya muncul dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah proses persalinan, ditandai oleh perasaan sedih, kehilangan minat terhadap bayi, dan gangguan fungsi sehari-hari.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

Instrumen skrining khusus yang terdiri dari 10 pertanyaan singkat untuk mendeteksi secara dini risiko dan gejala depresi perinatal pada ibu hamil atau ibu postpartum.

Kecemasan Perinatal

Gangguan psikologis berupa rasa cemas yang berlebihan, sulit dikendalikan, dan berlangsung terus-menerus sejak masa kehamilan hingga periode postpartum, mengganggu aktivitas sehari-hari serta peran ibu.

Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7)

Instrumen skrining berisi 7 pertanyaan yang secara spesifik digunakan untuk mendeteksi gejala kecemasan umum, terutama untuk ibu selama masa perinatal.

Faktor Risiko

Kondisi atau situasi tertentu yang meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan mental perinatal, misalnya riwayat gangguan mental sebelumnya, kurangnya dukungan sosial, stres keuangan, serta komplikasi kehamilan dan persalinan.

Konseling Psikologis

Proses intervensi yang dilakukan oleh profesional terlatih untuk membantu ibu mengatasi dan mengelola perasaan atau pikiran negatif secara sehat dan efektif, terutama dalam kasus kecemasan atau depresi perinatal.

Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Terapi psikologis yang membantu individu mengenali dan mengubah pola pikir negatif serta perilaku maladaptif yang memperburuk kecemasan atau depresi perinatal.

Intervensi Berbasis Mindfulness

Pendekatan terapi yang berfokus pada peningkatan kesadaran penuh (mindfulness) melalui meditasi, latihan pernapasan, dan relaksasi untuk membantu ibu mengelola stres dan kecemasan secara efektif.

Panduan Klinis (Clinical Guidelines)

Pedoman resmi dan terstandar yang diterbitkan oleh organisasi kredibel (WHO, NICE, ACOG) untuk membantu profesional kesehatan dalam memberikan layanan yang sesuai standar, efektif, dan aman bagi ibu dengan gangguan kesehatan mental perinatal.

Pelatihan Lanjutan Kesehatan Mental Perinatal

Pendidikan atau pelatihan tambahan bagi tenaga kesehatan seperti bidan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, memahami, serta memberikan intervensi yang tepat bagi kasus gangguan kesehatan mental pada ibu di masa perinatal.

Layanan Rujukan

Sistem atau mekanisme untuk merujuk ibu dengan gangguan kesehatan mental yang kompleks atau serius ke tenaga kesehatan mental profesional, seperti psikolog klinis atau psikiater, guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Psikolog Klinis

Tenaga profesional yang kompeten melakukan asesmen psikologis mendalam, memberikan terapi intensif, serta membantu ibu mengatasi kondisi kecemasan atau depresi yang lebih serius.

Psikiater

Dokter spesialis kesehatan jiwa yang memiliki kewenangan untuk memberikan diagnosis medis, psikoterapi intensif, dan pemberian terapi farmakologis (obat-obatan) jika dibutuhkan.

Komplikasi Psikososial

Dampak negatif yang terjadi akibat gangguan kesehatan mental perinatal yang tidak tertangani, termasuk gangguan hubungan ibu-bayi (bonding), terganggunya perkembangan emosional anak, serta terganggunya keharmonisan keluarga.

Dukungan Sosial

Bantuan emosional, fisik, atau sosial yang diberikan oleh pasangan, keluarga, atau lingkungan sekitar, yang sangat penting dalam upaya mencegah atau mengurangi dampak negatif kecemasan dan depresi perinatal.

Intervensi Dini

Upaya tindakan yang dilakukan segera setelah deteksi dini kondisi kecemasan atau depresi perinatal, bertujuan untuk mencegah perkembangan gejala menjadi lebih parah.

G. Daftar Pustaka

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2018). Screening for perinatal depression. ACOG Committee Opinion No. 757. *Obstetrics & Gynecology*, 132(5), e208–e212. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002927>
- Howard, L. M., & Khalifeh, H. (2020). Perinatal mental health: A review of progress and challenges. *World Psychiatry*, 19(3), 313–327. <https://doi.org/10.1002/wps.20769>
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2020). Antenatal and postnatal mental health: Clinical management and service guidance (NICE guideline CG192). Retrieved from <https://www.nice.org.uk/guidance/cg192>
- O'Hara, M. W., & McCabe, J. E. (2013). Postpartum depression: Current status and future directions. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 379–407. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612>
- Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: The GAD-7. *Archives of Internal Medicine*, 166(10), 1092–1097. <https://doi.org/10.1001/archinte.166.10.1092>
- Wisner, K. L., Sit, D. K. Y., McShea, M. C., Rizzo, D. M., Zoretich, R. A., Hughes, C. L., ... Hanusa, B. H. (2013). Onset timing, thoughts of self-harm, and diagnoses in postpartum women with screen-positive depression findings. *JAMA Psychiatry*, 70(5), 490–498. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2013.87>
- World Health Organization (WHO). (2022). WHO guide for integration of perinatal mental health in maternal and child health services. Geneva: World Health

Organization. Retrieved from
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240057142>
Zhong, Q. Y., Gelaye, B., Zaslavsky, A. M., Fann, J. R., Rondon, M. B., Sánchez, S. E., & Williams, M. A. (2015). Diagnostic validity of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) for detecting depression in pregnant women. PLoS ONE, 10(8), e0135096. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0135096>

BAB 7

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TRAUMA: PENCEGAHAN TRAUMA, PENYEMBUHAN TRAUMA

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu melakukan tindakan pencegahan dan penanganan trauma psikologis pada ibu selama masa perinatal secara profesional, berlandaskan etika dan evidence-based practice.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi faktor risiko terjadinya trauma psikologis pada ibu hamil dan melahirkan.
- Mengaplikasikan teknik-teknik pencegahan trauma dalam pelayanan kebidanan.
- Mengelola kasus trauma psikologis secara efektif menggunakan metode terapeutik yang tepat.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan strategi dan intervensi yang efektif dalam mencegah trauma selama masa perinatal.
- Mengaplikasikan pendekatan psikologis dalam mengidentifikasi tanda awal trauma pada ibu.
- Mempraktikkan teknik penyembuhan trauma yang relevan dan berbasis bukti.

Pendahuluan

Trauma psikologis merupakan pengalaman emosional yang mendalam akibat situasi yang mengancam keselamatan fisik atau psikis seseorang. Dalam praktik kebidanan, trauma dapat timbul akibat pengalaman buruk selama kehamilan, persalinan, atau pasca-persalinan. Mengingat dampak jangka panjang trauma terhadap kesehatan mental ibu dan perkembangan anak, maka pencegahan dan penanganan trauma perlu mendapat perhatian serius dari tenaga kebidanan.

A. Pencegahan Trauma

Pencegahan trauma adalah serangkaian tindakan preventif yang bertujuan secara khusus untuk mengurangi risiko terjadinya trauma psikologis pada ibu selama masa perinatal, yaitu periode yang meliputi kehamilan, persalinan, hingga masa pasca melahirkan. Masa perinatal dikenal sebagai periode yang sangat rentan secara emosional karena berbagai perubahan fisik, hormonal, dan psikososial yang dialami ibu. Oleh karena itu, berbagai strategi pencegahan trauma menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi untuk memastikan kesejahteraan psikologis yang optimal.

1. Edukasi Prenatal

Strategi pertama dalam pencegahan trauma adalah pemberian edukasi prenatal yang menyeluruh dan realistis kepada ibu hamil. Edukasi prenatal ini dilakukan sejak awal masa kehamilan hingga menjelang proses persalinan. Tujuan utama dari edukasi ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan realistis mengenai apa saja yang mungkin terjadi selama kehamilan dan persalinan. Informasi yang diberikan biasanya mencakup tahapan perkembangan janin, perubahan fisik dan emosional ibu selama kehamilan, teknik-teknik relaksasi dan manajemen nyeri, serta potensi komplikasi yang mungkin terjadi selama proses persalinan dan cara menghadapinya. Dengan memiliki pemahaman yang jelas dan realistis mengenai proses ini, ibu akan merasa lebih siap secara mental, sehingga mengurangi rasa cemas dan ketidakpastian yang sering menjadi pemicu trauma psikologis.

2. Dukungan Emosional dan Sosial

Pemberian dukungan emosional dan sosial secara konsisten dari lingkungan sekitar juga merupakan elemen krusial dalam pencegahan trauma. Dukungan ini mencakup peran aktif dari pasangan, keluarga terdekat, serta tenaga kesehatan yang mendampingi ibu selama masa perinatal. Pasangan yang memberikan dukungan emosional yang kuat dapat membantu ibu mengurangi tingkat stres dan memberikan rasa aman dan nyaman selama kehamilan maupun persalinan. Keluarga dekat, seperti orang tua dan saudara, juga memiliki peran penting dalam membantu ibu merasa didukung secara sosial, sehingga tidak merasa terisolasi atau sendirian menghadapi situasi sulit. Selain itu, tenaga kesehatan memiliki peran khusus dalam memberikan dukungan psikologis, di mana mereka harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda awal stres dan trauma serta secara aktif memberikan dukungan empatik kepada ibu.

3. Pendampingan Profesional

Pendampingan profesional oleh tenaga kesehatan yang terlatih adalah strategi lain yang tidak kalah penting dalam pencegahan trauma. Pendampingan profesional berarti bahwa tenaga kesehatan yang terlibat selama proses kehamilan, persalinan, hingga postpartum memiliki keahlian khusus dalam mengenali kebutuhan emosional ibu dan mampu memberikan dukungan psikologis secara empatik. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan perlu menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan emosional ibu, serta mampu melakukan komunikasi yang efektif sehingga ibu merasa didengar, dihargai, dan dimengerti sepenuhnya. Adanya tenaga kesehatan yang terlatih dan profesional juga memastikan bahwa ibu mendapatkan respon yang cepat, efektif, dan tepat dalam situasi-situasi kritis yang dapat memicu trauma, seperti proses persalinan yang sulit atau komplikasi yang tidak terduga.

4. Intervensi Psikoedukasi

Strategi pencegahan trauma yang terakhir adalah pelaksanaan intervensi psikoedukasi. Intervensi psikoedukasi adalah proses edukasi psikologis yang diberikan dalam bentuk sesi kelompok maupun individual untuk membantu ibu mengembangkan keterampilan coping atau pengelolaan stres. Dalam sesi psikoedukasi ini, ibu akan diajarkan berbagai teknik seperti relaksasi, mindfulness, dan meditasi yang bertujuan agar ibu mampu mengelola tekanan emosional secara efektif. Selain itu, sesi psikoedukasi juga menjadi wadah bagi ibu untuk berdiskusi secara terbuka tentang ketakutan, kecemasan, dan tantangan yang dialami selama kehamilan dan persalinan. Dengan mengikuti sesi psikoedukasi secara rutin, ibu menjadi lebih siap dan mampu menghadapi berbagai situasi sulit yang dapat memicu trauma secara lebih efektif dan sehat.

Dengan mengintegrasikan secara optimal edukasi prenatal, dukungan sosial-emosional, pendampingan profesional yang empatik, dan intervensi psikoedukasi, maka risiko ibu mengalami trauma psikologis selama masa perinatal dapat ditekan secara signifikan. Upaya-upaya ini secara holistik memastikan bahwa ibu tidak hanya mendapatkan perhatian pada aspek fisiknya saja, melainkan juga kesehatan emosionalnya, sehingga pengalaman kehamilan dan persalinan dapat berlangsung secara aman, nyaman, dan meminimalkan dampak traumatik jangka panjang.

B. Penyembuhan Trauma

Penyembuhan trauma merupakan suatu proses terapeutik yang sistematis dan bertujuan untuk membantu ibu mengatasi dampak psikologis yang timbul akibat pengalaman traumatis selama masa perinatal, seperti pengalaman persalinan yang sulit, kehilangan bayi, komplikasi medis, atau situasi emosional yang berat lainnya. Proses penyembuhan ini tidak hanya berfokus pada mengurangi gejala traumatis yang muncul tetapi juga membangun kembali keseimbangan psikologis serta meningkatkan kemampuan ibu dalam menghadapi kehidupan sehari-hari setelah mengalami trauma. Ada berbagai pendekatan terapeutik yang efektif digunakan dalam proses penyembuhan trauma, beberapa di antaranya yaitu Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), serta dukungan kelompok terapi.

1. Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Cognitive Behavioral Therapy (CBT). CBT merupakan terapi yang berfokus pada identifikasi dan perubahan pola pikir negatif serta perilaku maladaptif yang berkembang akibat trauma. Terapi ini didasarkan pada prinsip bahwa cara berpikir seseorang sangat berpengaruh terhadap perasaan dan perilakunya. Dalam konteks trauma perinatal, ibu yang mengalami trauma cenderung memiliki pikiran negatif yang berulang, seperti perasaan bersalah, merasa tidak mampu, atau rasa takut yang berlebihan terhadap proses melahirkan di masa depan. Dalam CBT, ibu akan diajak mengenali pikiran-pikiran tersebut melalui teknik restrukturisasi kognitif, yang bertujuan untuk mengganti pola pikir negatif dengan pikiran yang lebih positif dan realistis. Selain itu, terapi ini juga mengajarkan teknik-teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, serta visualisasi yang membantu ibu untuk mengelola kecemasan dan ketegangan emosional secara efektif.

2. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). EMDR adalah sebuah metode terapi yang unik karena melibatkan stimulasi bilateral melalui gerakan mata yang terstruktur untuk membantu individu memproses kembali ingatan traumatis yang tersimpan secara maladaptif di otak. Terapi ini berlandaskan pada prinsip bahwa trauma psikologis terjadi karena ingatan traumatis tidak dapat diproses secara optimal, sehingga terus memicu reaksi emosional yang intens setiap kali individu mengingat peristiwa tersebut. Dalam terapi EMDR, ibu akan diarahkan untuk fokus pada ingatan traumatis sambil mengikuti gerakan mata yang dilakukan oleh terapis. Proses ini membantu otak memproses kembali

memori traumatis secara adaptif, sehingga secara bertahap reaksi emosional yang intens terhadap trauma tersebut berkurang. Terapi EMDR terbukti efektif dalam menurunkan gejala trauma secara signifikan, seperti kilas balik (flashbacks), mimpi buruk, serta kecemasan akut yang muncul saat mengingat kejadian traumatis tersebut.

3. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Metode ini didasarkan pada prinsip mindfulness atau kesadaran penuh, yang mengajarkan ibu untuk mengarahkan perhatian secara sadar pada momen saat ini tanpa menghakimi atau menilai. Teknik mindfulness yang digunakan meliputi meditasi kesadaran penuh, latihan pernapasan, dan berbagai aktivitas relaksasi lainnya. Dengan menerapkan mindfulness, ibu belajar untuk menerima dan mengelola emosi negatif seperti kecemasan, ketakutan, serta depresi tanpa merasa kewalahan atau larut dalam perasaan tersebut. Selain itu, mindfulness juga membantu ibu untuk meningkatkan kontrol diri dan stabilitas emosional dalam menghadapi berbagai situasi stres yang berhubungan dengan trauma. Penelitian menunjukkan bahwa terapi berbasis mindfulness secara signifikan mampu menurunkan gejala stres, kecemasan, dan depresi pada ibu yang mengalami trauma perinatal, serta meningkatkan kesejahteraan emosional secara umum.

4. Dukungan Kelompok Terapi

dukungan kelompok terapi. Pendekatan ini memanfaatkan dinamika kelompok sebagai sarana penyembuhan, dengan menggabungkan ibu yang mengalami trauma perinatal dalam satu kelompok terapi yang terfasilitasi oleh seorang terapis profesional. Dalam sesi kelompok, ibu memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, perasaan, dan tantangan yang dialami terkait trauma mereka. Pengalaman berbagi ini memberikan rasa penerimaan dan pengakuan bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi masalah tersebut, yang secara signifikan membantu mengurangi perasaan terisolasi atau terasingkan. Interaksi dalam kelompok juga memungkinkan ibu untuk memperoleh berbagai strategi coping dari pengalaman sesama peserta terapi, sehingga membantu mereka memperluas keterampilan mengatasi stres. Lingkungan kelompok terapi yang suportif dan saling memahami menjadi wadah penyembuhan yang efektif, karena ibu merasa aman untuk mengungkapkan emosi mereka secara terbuka tanpa takut mendapatkan penilaian negatif.

Keseluruhan pendekatan terapeutik tersebut—baik CBT, EMDR, MBSR, maupun terapi kelompok—sering kali diintegrasikan dalam suatu program penyembuhan trauma yang komprehensif. Pendekatan terpadu ini memungkinkan ibu mendapatkan manfaat maksimal dalam pemulihan trauma perinatal mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan secara optimal kembali setelah mengalami pengalaman traumatis. Dengan demikian, integrasi strategi pencegahan serta berbagai pendekatan penyembuhan trauma tersebut merupakan komponen penting dalam praktik kebidanan modern. Pemahaman dan kompetensi tenaga kebidanan dalam bidang ini akan secara nyata meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, memperbaiki kualitas hidup ibu dan keluarga, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sehat secara mental dan emosional.

C. Latihan Soal

Soal 1:

Seorang ibu primigravida usia 26 tahun datang ke klinik bidan dengan usia kehamilan 34 minggu. Ia tampak cemas dan mengaku sering merasa takut terhadap proses persalinan karena cerita buruk yang pernah didengarnya dari temannya. Sebagai bidan, tindakan pencegahan trauma yang paling tepat untuk ibu tersebut adalah:

- A. Merujuk ibu ke psikolog klinis secara langsung.
- B. Memberikan edukasi prenatal secara detail dan realistis tentang proses persalinan.
- C. Menyarankan ibu untuk mencari informasi sendiri di internet tentang pengalaman positif persalinan.
- D. Memberikan obat anti-kecemasan agar ibu lebih tenang menghadapi persalinan.
- E. Menyarankan ibu agar tidak mendengar cerita orang lain.

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Edukasi prenatal secara detail dan realistis penting untuk menurunkan kecemasan dan memberikan gambaran nyata tentang apa yang bisa dihadapi ibu, sehingga mengurangi risiko trauma akibat ketakutan yang tidak beralasan atau tidak realistis.

Soal 2:

Seorang ibu multipara usia 32 tahun datang ke tempat praktik bidan, tampak lelah secara emosional dan mengaku merasa kesepian sejak suaminya bekerja jauh di luar

kota. Ia juga mengeluhkan kecemasan meningkat menjelang persalinan. Langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh bidan untuk mencegah trauma psikologis adalah:

- A. Menyarankan ibu agar bersabar menunggu kedatangan suami.
- B. Menghubungi keluarga dekat ibu agar memberikan dukungan sosial dan emosional.
- C. Memberikan ibu brosur tentang teknik relaksasi tanpa interaksi langsung.
- D. Menyarankan ibu untuk istirahat total di rumah.
- E. Merujuk ibu langsung ke rumah sakit jiwa.

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Dukungan emosional dari keluarga sangat penting untuk mencegah trauma psikologis karena mampu mengurangi stres, rasa kesepian, dan kecemasan yang dapat berkembang menjadi trauma yang lebih serius.

Soal 3:

Seorang ibu usia 29 tahun datang ke klinik bersalin untuk melahirkan anak pertamanya. Selama proses persalinan, ia mengalami kesulitan dan terlihat panik serta menangis. Sebagai bidan yang terlatih, langkah pencegahan trauma yang tepat dalam situasi tersebut adalah:

- A. Menegur ibu agar berhenti menangis.
- B. Melakukan komunikasi secara empatik, mendukung secara emosional dan menenangkan ibu.
- C. Segera merujuk ibu ke psikolog.
- D. Memberikan sedasi agar ibu tertidur selama persalinan.
- E. Menyuruh ibu untuk berdoa saja.

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Pendampingan profesional dengan pendekatan empatik oleh tenaga kesehatan membantu ibu merasa aman, didengar, dihargai, dan dimengerti, sehingga mampu mencegah perkembangan pengalaman emosional negatif menjadi trauma.

Soal 4:

Seorang ibu usia 27 tahun mengalami trauma setelah persalinan sulit yang menyebabkan bayi harus dirawat di NICU. Ia sering merasa bersalah, cemas, dan takut setiap mengingat kejadian tersebut. Terapi yang paling efektif untuk membantu ibu mengatasi trauma ini adalah:

- A. Mengajak ibu bergabung dalam sesi olahraga rutin.
- B. Menyarankan terapi Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).
- C. Menyarankan ibu melupakan kejadian tersebut.
- D. Memberikan obat penenang secara rutin.
- E. Menyarankan ibu membaca buku tentang pola asuh bayi sehat.

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Terapi EMDR terbukti efektif untuk membantu memproses kembali ingatan traumatis sehingga ibu dapat mengurangi gejala trauma seperti kecemasan akut, kilas balik, dan mimpi buruk secara signifikan.

Soal 5:

Seorang ibu postpartum usia 31 tahun mengalami depresi ringan dan kecemasan setelah persalinan yang penuh komplikasi. Ibu merasa terisolasi karena tidak ada teman atau keluarga di dekatnya. Bidan menyarankan ibu mengikuti sesi kelompok terapi. Manfaat utama yang diperoleh ibu dari mengikuti kelompok terapi ini adalah:

- A. Mendapatkan resep obat antidepresan secara gratis.
- B. Belajar mengabaikan masalah emosional yang dialami.
- C. Merasa didukung dan diterima serta mampu berbagi pengalaman secara terbuka.
- D. Dapat segera kembali bekerja penuh waktu.
- E. Menghindari konseling individual dengan terapis.

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Dukungan kelompok terapi menciptakan lingkungan aman yang membantu ibu merasa didukung, tidak terisolasi, dan mampu berbagi pengalaman secara terbuka. Hal ini efektif dalam proses penyembuhan trauma, khususnya dalam mengurangi rasa kesepian, kecemasan, dan depresi.

D. Rangkuman Materi

Pencegahan dan penyembuhan trauma psikologis pada masa perinatal merupakan dua komponen yang sangat penting dalam praktik kebidanan modern. Pencegahan trauma dilakukan melalui serangkaian tindakan preventif yang bertujuan mengurangi risiko munculnya trauma psikologis selama periode kehamilan, persalinan, hingga pasca melahirkan. Strategi ini mencakup edukasi prenatal yang komprehensif untuk mempersiapkan mental ibu dalam menghadapi berbagai situasi perinatal, dukungan emosional dan sosial yang konsisten dari pasangan, keluarga, serta tenaga kesehatan, pendampingan profesional yang empatik untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman selama proses perinatal, serta intervensi psikoedukasi untuk membangun keterampilan coping ibu dalam mengelola stres dan tantangan emosional.

Sementara itu, penyembuhan trauma berfokus pada proses terapeutik yang bertujuan membantu ibu mengatasi dampak psikologis dari pengalaman traumatis, seperti persalinan sulit, kehilangan bayi, atau komplikasi emosional lainnya. Berbagai pendekatan terapeutik yang terbukti efektif dalam penyembuhan trauma adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT) untuk merestrukturisasi pola pikir negatif, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) untuk memproses ulang ingatan traumatis, Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) untuk meningkatkan kesadaran dan mengelola emosi secara positif, serta terapi kelompok yang memberikan wadah saling mendukung dan berbagi pengalaman secara aman.

Secara holistik, integrasi strategi pencegahan dan penyembuhan trauma ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, memperbaiki kesejahteraan emosional ibu dan keluarganya, serta mendukung terciptanya lingkungan keluarga dan masyarakat yang sehat secara mental dan emosional. Oleh karena itu, kompetensi tenaga kesehatan khususnya bidan dalam menguasai aspek pencegahan dan penyembuhan trauma menjadi sangat krusial dalam mendukung kesejahteraan psikologis ibu dan keluarganya selama masa perinatal.

E. Glosarium

Trauma Psikologis Perinatal

Dampak emosional yang serius dan berkepanjangan akibat pengalaman stres atau traumatis yang dialami ibu selama kehamilan, persalinan, atau masa setelah melahirkan, yang ditandai dengan perasaan takut berlebihan, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya.

Masa Perinatal

Periode waktu yang mencakup masa kehamilan, persalinan, hingga satu tahun setelah kelahiran bayi, dikenal sebagai periode rentan karena berbagai perubahan fisik, hormonal, serta psikologis yang dialami ibu.

Edukasi Prenatal

Proses pemberian informasi secara sistematis dan realistis kepada ibu hamil mengenai tahapan perkembangan janin, perubahan yang dialami ibu selama kehamilan, teknik relaksasi, manajemen nyeri, dan kemungkinan komplikasi persalinan, untuk mengurangi kecemasan dan rasa tidak pasti.

Dukungan Emosional dan Sosial

Dukungan psikologis yang diberikan oleh pasangan, keluarga, tenaga kesehatan, atau lingkungan sekitar kepada ibu selama masa perinatal, bertujuan membantu mengurangi stres, menciptakan rasa aman, dan mencegah perasaan terisolasi.

Pendampingan Profesional

Pendampingan psikologis oleh tenaga kesehatan terlatih secara khusus selama proses kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan untuk mengidentifikasi kebutuhan emosional ibu, memberikan dukungan empatik, dan menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis.

Intervensi Psikoedukasi

Pendekatan edukasi psikologis melalui sesi individual atau kelompok yang bertujuan mengajarkan keterampilan coping atau pengelolaan stres kepada ibu, meliputi teknik relaksasi, mindfulness, meditasi, serta sarana berbagi pengalaman secara terbuka.

Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Terapi psikologis yang berfokus pada pengenalan dan perubahan pola pikir negatif serta perilaku maladaptif, dengan teknik restrukturisasi kognitif dan relaksasi untuk mengatasi gejala traumatis yang muncul akibat pengalaman traumatik.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Metode terapi psikologis yang menggunakan stimulasi bilateral berupa gerakan mata terstruktur untuk membantu ibu memproses kembali ingatan traumatis secara adaptif sehingga mengurangi intensitas reaksi emosional negatif.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

Terapi berbasis kesadaran penuh yang mengajarkan ibu untuk fokus pada momen sekarang tanpa menghakimi, melalui teknik meditasi, latihan pernapasan, dan relaksasi untuk mengelola emosi negatif seperti kecemasan dan depresi.

Dukungan Kelompok Terapi

Metode terapeutik yang memanfaatkan dinamika interaksi dalam kelompok, di mana para ibu yang mengalami trauma dapat berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, serta mengembangkan strategi coping bersama-sama, untuk mengurangi isolasi emosional dan mempercepat proses penyembuhan trauma.

Strategi Terpadu

Pendekatan holistik dalam praktik kebidanan yang mengintegrasikan berbagai teknik pencegahan dan penyembuhan trauma seperti edukasi prenatal, dukungan sosial-emosional, pendampingan profesional, psikoedukasi, CBT, EMDR, MBSR, serta dukungan kelompok terapi demi kesejahteraan psikologis ibu secara menyeluruh.

F. Daftar Pustaka

- American Psychological Association. (2017). Clinical practice guideline for the treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD) in adults. American Psychological Association. <https://www.apa.org/ptsd-guideline>
- Beck, C. T., Driscoll, J. W., & Watson, S. (2013). Traumatic childbirth. Routledge.
- Dimidjian, S., & Goodman, S. H. (2019). Expecting mindfulness: Using mindfulness-based cognitive therapy to enhance mental health during pregnancy and early parenthood. Guilford Press.
- Follette, V. M., Briere, J., Rozelle, D., Hopper, J. W., & Rome, D. I. (Eds.). (2015). Mindfulness-oriented interventions for trauma: Integrating contemplative practices. Guilford Press.
- Gamble, J., Creedy, D. K., Moyle, W., Webster, J., McAllister, M., & Dickson, P. (2005). Effectiveness of a counseling intervention after a traumatic childbirth: A randomized controlled trial. *Birth*, 32(1), 11–19. <https://doi.org/10.1111/j.0730-7659.2005.00340.x>
- Harris, R., & Ayers, S. (2012). What makes labour and birth traumatic? A survey of intrapartum 'hotspots'. *Psychology & Health*, 27(10), 1166–1177. <https://doi.org/10.1080/08870446.2011.649755>

- Kabat-Zinn, J. (2013). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness* (Rev. ed.). Bantam Books.
- Kingston, D., Tough, S., & Whitfield, H. (2012). Prenatal and postpartum maternal psychological distress and infant development: A systematic review. *Child Psychiatry & Human Development*, 43(5), 683–714. <https://doi.org/10.1007/s10578-012-0291-4>
- Shapiro, F. (2018). *Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy: Basic principles, protocols, and procedures* (3rd ed.). Guilford Press.
- Simkin, P., & Klaus, P. (2004). When survivors give birth: Understanding and healing the effects of early sexual abuse on childbearing women. *Birth*, 31(3), 241–241. <https://doi.org/10.1111/j.0730-7659.2004.00309.x>
- Wenzel, A., Stuart, S., & Beck, A. T. (2005). *Cognitive therapy for pregnancy and postpartum depression: A treatment manual*. American Psychological Association.
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations on intrapartum care for a positive childbirth experience. World Health Organization. <https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/>

BAB 8

TREN DAN ISU PSIKOLOGI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan psikologi kebidanan untuk memberikan asuhan yang komprehensif, sensitif secara budaya, dan responsif terhadap kebutuhan psikologis ibu, bayi, dan keluarga dalam berbagai konteks praktik kebidanan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai tren dan isu psikologis dalam praktik kebidanan secara efektif dan berbasis bukti, serta mampu mengembangkan intervensi yang mendukung kesehatan mental ibu dan keluarga.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan peran psikologi dalam praktik kebidanan.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tren terbaru terkait kondisi psikologis ibu dalam konteks kebidanan.
3. Mahasiswa mampu menganalisis isu-isu psikologis kontemporer dan dampaknya terhadap kesehatan ibu dan bayi.
4. Mahasiswa mampu merancang pendekatan intervensi psikologis dalam praktik kebidanan berdasarkan tren dan isu terkini.

Pendahuluan

Psikologi dalam praktik kebidanan merupakan elemen penting dalam memberikan asuhan yang menyeluruh kepada ibu dan bayi. Perubahan emosional, sosial, dan psikologis yang dialami perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas menuntut tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang aspek psikologis. Dalam konteks tersebut, perkembangan zaman turut memunculkan berbagai tren dan isu baru yang memengaruhi kondisi psikologis ibu dan keluarga.

Munculnya media sosial, tekanan sosial, peningkatan angka kejadian gangguan mental perinatal, serta krisis kepercayaan terhadap layanan kesehatan adalah sebagian dari isu yang menonjol dewasa ini. Isu-isu tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ibu, tetapi juga pada kualitas hubungan ibu-anak dan keberhasilan proses persalinan serta perawatan pasca kelahiran. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon bidan untuk memahami secara kritis dinamika tren dan isu psikologi kontemporer agar mampu memberikan intervensi yang adaptif dan berbasis bukti.

A. Perubahan Psikososial Ibu dan Keluarga dalam Era Modern

Masa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan masa transisi besar dalam kehidupan seorang perempuan dan keluarganya. Transisi ini tidak hanya bersifat fisik dan hormonal, tetapi juga melibatkan perubahan besar dalam dimensi psikososial. Ibu yang tengah hamil atau baru melahirkan mengalami perubahan peran, dari perempuan menjadi ibu, dari pasangan menjadi pengasuh utama, serta menghadapi tanggung jawab baru yang menuntut kesiapan mental dan emosional. Dalam situasi ini, berbagai emosi seperti kegembiraan, kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan rasa tidak berdaya, sering kali muncul secara bersamaan dan kompleks.

Dalam era modern, perubahan sosial dan teknologi menambah lapisan baru dalam dinamika psikososial ini. Perempuan modern kini seringkali harus menyeimbangkan antara tuntutan karir profesional dan tanggung jawab sebagai ibu. Tekanan untuk kembali bekerja dengan cepat setelah melahirkan atau harus terus produktif selama kehamilan dapat meningkatkan tingkat stres secara signifikan (Field, 2021). Kondisi ini diperburuk oleh ekspektasi sosial yang tinggi terhadap ibu untuk menjadi "sempurna" dalam mengasuh anak, yang sering kali dibentuk oleh media sosial dan budaya populer.

Relasi digital juga turut berperan dalam mempengaruhi kondisi psikologis ibu dan keluarga. Meski internet dan media sosial dapat menjadi sarana informasi yang membantu, namun tidak jarang ibu merasa tertekan karena membandingkan dirinya dengan gambaran ideal yang ditampilkan oleh ibu-ibu lain secara daring. Fenomena ini dikenal sebagai social comparison dan telah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan perasaan tidak mampu, cemas, dan bahkan gejala depresi (Tandon et al., 2021). Di samping itu, paparan informasi yang tidak valid mengenai kehamilan dan parenting juga bisa menambah kebingungan dan ketakutan, apalagi jika tidak disertai dengan literasi kesehatan yang memadai.

Dalam konteks keluarga, dinamika psikososial turut memengaruhi hubungan antara pasangan. Ketidakseimbangan peran dalam pengasuhan anak dan perubahan dalam hubungan intim suami istri menjadi sumber stres tambahan, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik rumah tangga atau penurunan kualitas hubungan (Topalidou et al., 2020). Selain itu, keluarga besar seperti orang tua atau mertua seringkali memiliki pengaruh signifikan dalam proses adaptasi peran ibu baru. Dukungan keluarga yang konstruktif sangat membantu

stabilitas emosional ibu, namun intervensi berlebihan juga bisa menjadi sumber tekanan psikologis.

Bidan memiliki peran sentral dalam membantu ibu dan keluarga menghadapi perubahan ini. Kemampuan untuk melakukan asesmen psikososial, memberikan edukasi, serta membangun hubungan empatik dengan ibu dan pasangan menjadi kunci penting dalam mendukung kesejahteraan mental selama masa transisi ini. Pendekatan asuhan yang holistik dan berbasis hubungan saling percaya sangat penting agar bidan tidak hanya menjadi pemberi layanan klinis, tetapi juga mitra psikologis yang mampu membangun ketahanan keluarga (Waqas et al., 2023).

Dengan memperhatikan kompleksitas perubahan psikososial pada masa kini, bidan harus memiliki sensitivitas terhadap faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi kondisi ibu. Asuhan psikososial tidak lagi bisa bersifat umum, melainkan perlu disesuaikan dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan ekspektasi individual dari setiap ibu dan keluarga. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dalam aspek psikologi kebidanan menjadi sebuah kebutuhan dalam meningkatkan kualitas layanan kebidanan di era modern (O'Hara et al., 2022).

B. Tren Gangguan Psikologis Selama Masa Kehamilan dan Pascamelahirkan

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap gangguan psikologis yang terjadi selama kehamilan dan pascamelahirkan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya data epidemiologis yang menunjukkan bahwa gangguan ini tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Di antara berbagai jenis gangguan psikologis yang umum terjadi, depresi postpartum menempati posisi teratas sebagai kondisi yang paling sering dilaporkan oleh ibu setelah melahirkan. Gangguan ini ditandai oleh suasana hati yang sangat rendah, perasaan tidak berdaya, dan hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari, bahkan terhadap bayinya sendiri. Depresi ini dapat berkembang dalam beberapa minggu setelah melahirkan, namun pada beberapa kasus, dapat muncul dalam waktu satu tahun setelah persalinan (Shorey & Chee, 2021).

Selain itu, baby blues, meskipun sering dianggap ringan dan bersifat sementara, tidak bisa diabaikan. Kondisi ini dialami oleh hampir 50–80% ibu baru dan ditandai dengan perubahan suasana hati yang tiba-tiba, mudah menangis, kelelahan ekstrem, dan perasaan kewalahan. Meskipun tidak tergolong gangguan psikiatrik, baby blues dapat menjadi gerbang menuju gangguan yang lebih berat jika tidak ditangani dengan baik. Di sisi lain, gangguan kecemasan seperti generalized anxiety disorder (GAD), panic disorder, dan obsessive-compulsive disorder (OCD) juga menunjukkan peningkatan prevalensi, baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan. Banyak ibu merasa cemas secara berlebihan tentang

kesehatan bayi, peran sebagai ibu, maupun kemampuan mereka dalam mengasuh anak. Kecemasan yang persisten ini bisa berdampak serius terhadap kualitas hidup ibu dan perkembangan emosional anak (Dennis et al., 2022).

Tren peningkatan gangguan psikologis ini tidak dapat dilepaskan dari beragam faktor risiko yang semakin menonjol dalam konteks kehidupan modern. Salah satu faktor utama adalah riwayat gangguan mental sebelum kehamilan, termasuk depresi, kecemasan, atau trauma psikologis lainnya. Ibu dengan riwayat tersebut memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kekambuhan atau eksaserbasi selama periode perinatal. Selain itu, minimnya dukungan sosial, baik dari pasangan, keluarga, maupun lingkungan sekitar, berkontribusi secara signifikan terhadap munculnya gangguan psikologis. Ibu yang merasa sendiri dalam menghadapi tantangan kehamilan dan menjadi ibu baru cenderung mengalami stres yang lebih berat, yang jika dibiarkan, dapat berkembang menjadi gangguan mental (Guintivano et al., 2020).

Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga menjadi pemicu gangguan psikologis. Tekanan untuk mencukupi kebutuhan finansial keluarga di tengah meningkatnya biaya hidup, termasuk biaya perawatan anak, dapat menimbulkan kecemasan dan rasa bersalah, terutama pada ibu yang merasa tidak mampu memberikan yang terbaik bagi anaknya. Ketidakpastian ekonomi yang meningkat akibat krisis global, pandemi, atau PHK massal semakin memperburuk kondisi psikologis ibu hamil dan menyusui (Lebel et al., 2020).

Pentingnya pemahaman terhadap tren gangguan psikologis selama kehamilan dan pascamelahirkan menjadi kunci utama dalam praktik kebidanan yang responsif dan berbasis bukti. Deteksi dini melalui skrining psikologis rutin selama antenatal dan postnatal care merupakan langkah strategis yang direkomendasikan oleh berbagai organisasi profesional, termasuk WHO dan ACOG. Selain itu, pendekatan intervensi awal, seperti konseling psikososial, terapi kognitif perilaku (CBT), dan dukungan kelompok ibu, terbukti efektif dalam mencegah perkembangan gangguan menjadi lebih berat dan meningkatkan kualitas hidup ibu secara keseluruhan (O'Hara & Wisner, 2022).

Dengan memahami dinamika tren ini, bidan dapat menjalankan peran penting sebagai ujung tombak dalam menjaga kesehatan mental ibu dan anak. Pendidikan dan pelatihan dalam aspek psikologi perinatal harus menjadi bagian integral dari kurikulum kebidanan, agar bidan tidak hanya terampil dalam aspek klinis, tetapi juga mampu memberikan asuhan psikososial yang efektif dan empatik.

C. Pengaruh Media Sosial dan Digitalisasi terhadap Kesehatan Mental Ibu

Media sosial dan digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, termasuk bagi ibu hamil dan menyusui. Teknologi digital, dengan segala kemudahan dan kecepatan aksesnya, telah mengubah cara ibu memperoleh informasi, membangun koneksi sosial, serta mengekspresikan pengalaman keibuan mereka. Di satu sisi, media sosial menyediakan ruang edukatif dan dukungan emosional. Berbagai komunitas ibu, blog parenting, dan akun kesehatan yang dikelola profesional dapat menjadi sumber informasi terpercaya yang memperkaya pengetahuan ibu tentang kehamilan, persalinan, dan pengasuhan bayi (Ali et al., 2021).

Namun, di sisi lain, media sosial membawa tantangan baru yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental ibu. Salah satu fenomena yang banyak dialami adalah perbandingan sosial yang tidak sehat, di mana ibu merasa dirinya tidak cukup baik ketika melihat postingan ibu lain yang tampak “sempurna” dalam menjalani peran keibuan. Unggahan yang menunjukkan keberhasilan menyusui, keberhasilan menurunkan berat badan pasca persalinan, atau keintiman hubungan ibu dan bayi sering kali membuat ibu lain merasa tertinggal atau gagal, meskipun mereka sebenarnya menjalani proses yang normal dan sehat. Proses ini berpotensi memicu stres, rasa cemas, dan rendah diri, terutama pada ibu yang sebelumnya memiliki kerentanan psikologis (Chae et al., 2023).

Fenomena lain yang mengemuka adalah mom-shaming, yaitu kritik atau penghakiman terhadap keputusan atau gaya pengasuhan ibu lain yang dilakukan secara terbuka di media sosial. Mom-shaming dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kritik terhadap cara melahirkan (normal atau caesar), pilihan menyusui (ASI atau susu formula), hingga keputusan kembali bekerja setelah melahirkan. Tekanan sosial ini menambah beban psikologis ibu dan menciptakan rasa takut akan penilaian, yang pada akhirnya mengganggu kesehatan mental dan menghambat pengambilan keputusan berdasarkan kebutuhan pribadi dan keluarga (Muscanell & Guadagno, 2020).

Selain itu, media sosial juga menjadi saluran penyebaran informasi yang tidak selalu akurat atau berbasis bukti ilmiah. Banyak ibu yang mencari solusi cepat atau jawaban instan atas keluhan atau keraguan seputar kehamilan dan bayi, tetapi tanpa menyaring kebenaran informasi yang diperoleh. Informasi yang menyesatkan, terutama yang berasal dari akun-akun tanpa keahlian di bidang kesehatan, dapat memunculkan kecemasan, ketakutan berlebihan, bahkan mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat secara medis (Jiang et al., 2021).

Namun demikian, media sosial tidak sepenuhnya harus dihindari. Justru dalam dunia digital saat ini, media sosial dapat dimanfaatkan secara strategis oleh tenaga

kesehatan, termasuk bidan, untuk membangun intervensi promosi kesehatan mental berbasis digital yang efektif dan luas jangkauannya. Konten edukasi yang dirancang dengan bahasa yang ramah, visual yang menarik, dan pendekatan empatik terbukti mampu menjangkau ibu secara lebih personal. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa program intervensi berbasis media sosial memiliki efek positif dalam mengurangi gejala kecemasan dan depresi ringan hingga sedang pada ibu hamil dan postpartum (Moon et al., 2022).

Dengan demikian, para praktisi kebidanan perlu menyadari bahwa media sosial adalah ruang potensial untuk menjangkau ibu secara lebih inklusif dan preventif. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis literasi digital yang kuat. Bidan juga berperan penting dalam membimbing ibu untuk memilah informasi yang akurat, merekomendasikan sumber terpercaya, dan mendorong interaksi positif di media sosial. Selain itu, perlu dikembangkan kebijakan dan pelatihan kebidanan yang mencakup keterampilan komunikasi digital serta pengelolaan risiko psikososial yang ditimbulkan oleh media digital.

D. Isu Kepercayaan terhadap Layanan Kesehatan dan Praktik Medis

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan, termasuk dalam konteks kebidanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu kepercayaan terhadap layanan kesehatan mengalami tantangan yang signifikan, khususnya di kalangan ibu hamil dan pascamelahirkan. Ketidakpercayaan ini muncul dari berbagai sumber, seperti pengalaman negatif masa lalu (termasuk trauma medis), interaksi tenaga kesehatan yang tidak sensitif secara emosional, serta penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media sosial dan jaringan informal. Akumulasi dari pengalaman dan informasi ini berpotensi menurunkan kualitas hubungan terapeutik antara bidan dan pasien, yang pada akhirnya berdampak pada pemanfaatan layanan dan kesehatan mental ibu secara keseluruhan (Altman et al., 2021).

Trauma medis adalah salah satu penyebab utama munculnya ketidakpercayaan terhadap layanan kesehatan. Banyak perempuan yang melaporkan pernah mengalami intervensi medis yang dilakukan tanpa persetujuan eksplisit, komunikasi yang buruk, atau perlakuan yang dianggap kasar selama proses persalinan. Pengalaman seperti ini dapat menyebabkan trauma yang membekas dan memengaruhi persepsi mereka terhadap institusi kesehatan, termasuk ketakutan untuk kembali menjalani pemeriksaan atau melahirkan di fasilitas kesehatan (Schroll et al., 2022). Trauma ini tidak hanya berpengaruh pada

aspek psikologis, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan ikatan ibu-anak, gangguan tidur, dan munculnya gejala depresi pascapersalinan.

Selain trauma, maraknya informasi hoaks dan teori konspirasi di media sosial juga turut merusak kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Berita palsu yang menyebar mengenai vaksinasi, prosedur medis, atau intervensi kebidanan dapat menciptakan kebingungan dan rasa takut pada ibu hamil. Misalnya, hoaks mengenai efek samping imunisasi bayi atau rumor tentang risiko prosedur caesar yang dilebih-lebihkan dapat membuat ibu ragu menjalani prosedur yang sebenarnya aman dan terbukti secara ilmiah. Ketika informasi yang salah tersebut lebih dipercaya dibandingkan sumber resmi, maka muncul jurang kepercayaan yang sulit dijembatani (Loomba et al., 2021).

Isu kepercayaan juga semakin kompleks ketika berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Dalam beberapa komunitas, tenaga kesehatan dianggap sebagai pihak yang terlalu menekankan pendekatan medis Barat, tanpa mempertimbangkan nilai dan kepercayaan lokal. Ketika ibu merasa bahwa keyakinan budaya mereka diabaikan dalam proses pelayanan, maka keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan menjadi rendah, dan ketidakpercayaan pun meningkat (Zolnikov & Furio, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa membangun kepercayaan bukan sekadar soal memberikan informasi, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang dimiliki oleh ibu dan keluarganya.

Di tengah tantangan tersebut, praktik kebidanan yang empatik dan berbasis hubungan saling percaya menjadi sangat penting. Bidan memiliki peran strategis sebagai figur kunci dalam membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka, menghormati otonomi ibu dalam pengambilan keputusan, serta menunjukkan keterlibatan emosional yang tulus. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang empatik antara bidan dan pasien secara signifikan meningkatkan kepuasan terhadap layanan, memperkuat kepatuhan terhadap anjuran medis, dan mengurangi risiko gangguan psikologis selama dan setelah kehamilan (Kirkham et al., 2023).

Salah satu strategi yang terbukti efektif dalam mengatasi isu ketidakpercayaan adalah pendekatan trauma-informed care, yaitu model pelayanan yang memahami dampak pengalaman traumatis dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keselamatan, pilihan, dan kolaborasi dalam setiap aspek asuhan. Dengan menerapkan prinsip ini, bidan dapat memberikan lingkungan yang lebih suportif, mengurangi potensi pemicu trauma, dan membangun kembali rasa aman yang sangat dibutuhkan oleh ibu (Mosley et al., 2021).

Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan terhadap layanan kebidanan tidak bisa dilakukan secara teknis semata. Diperlukan komitmen profesional dan

kelembagaan untuk mereformasi pendekatan komunikasi, menciptakan lingkungan yang ramah, serta melibatkan pasien secara aktif dalam proses pelayanan. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang dibangun dalam satu pertemuan, tetapi merupakan hasil dari kontinuitas interaksi yang dilandasi dengan penghargaan terhadap martabat dan pengalaman perempuan sebagai individu yang unik.

E. Tantangan Budaya dan Stigma terhadap Gangguan Psikologis pada Ibu

Dalam banyak masyarakat, terutama di negara-negara berkembang dan komunitas tradisional, isu gangguan psikologis pada ibu hamil dan pascamelahirkan masih dipenuhi oleh stigma dan tabu. Konsepsi umum tentang menjadi ibu sering kali diasosiasikan dengan kebahagiaan, keberhasilan, dan kekuatan, sehingga segala bentuk gangguan emosional atau mental dianggap sebagai kelemahan pribadi atau bahkan kegagalan dalam menjalankan peran sebagai ibu. Narasi budaya seperti ini menyebabkan perempuan yang mengalami kecemasan, depresi, atau stres berlebihan enggan mengungkapkan kondisinya secara terbuka atau mencari pertolongan profesional (Abrams et al., 2020).

Stigma sosial terhadap gangguan mental bukan hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga diperkuat oleh norma keluarga dan komunitas. Dalam beberapa budaya, misalnya, kondisi seperti depresi pascamelahirkan dipandang sebagai sesuatu yang tidak nyata atau sebagai tanda kurangnya keimanan, kesyukuran, atau keteguhan hati. Ibu yang menunjukkan gejala psikologis dianggap "manja," "lemah," atau "tidak bersyukur," sehingga mereka kerap menyembunyikan perasaannya demi mempertahankan citra sosial atau untuk menghindari kecaman keluarga (Rahman et al., 2021). Akibatnya, banyak kasus gangguan psikologis pada ibu tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan risiko komplikasi, seperti gangguan hubungan ibu-anak, gangguan tidur kronis, bahkan pikiran untuk menyakiti diri atau bayi.

Budaya patriarki yang kuat juga berperan dalam memperburuk situasi ini. Dalam masyarakat di mana suara perempuan tidak terlalu dihargai dalam pengambilan keputusan kesehatan, ibu cenderung mengandalkan izin atau restu dari suami atau keluarga besar untuk mengakses layanan kesehatan mental. Ketika anggota keluarga tidak memahami pentingnya intervensi psikologis, maka ibu akan semakin terisolasi dan kehilangan akses terhadap dukungan profesional. Hambatan struktural ini tidak hanya memperburuk gejala psikologis, tetapi juga memperpanjang durasi penderitaan ibu (Yıldız et al., 2021).

Tantangan budaya ini semakin kompleks ketika digabungkan dengan keterbatasan sistem layanan kesehatan yang belum sepenuhnya mengintegrasikan

aspek psikologis dalam asuhan kebidanan. Banyak fasilitas kesehatan primer yang belum memiliki mekanisme skrining psikologis, apalagi tenaga terlatih dalam konseling perinatal. Akibatnya, deteksi gangguan psikologis selama kehamilan dan masa nifas bergantung sepenuhnya pada inisiatif individu atau pengamatan bidan secara kasat mata, yang tentu saja rentan terlewat. Di sinilah peran bidan menjadi sangat krusial. Bidan, sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat secara sosial dan budaya dengan masyarakat, memiliki potensi strategis dalam menjembatani pemahaman antara nilai budaya lokal dan pendekatan kesehatan mental modern (Barlow et al., 2022).

Untuk dapat menjalankan peran ini secara efektif, bidan tidak hanya perlu memahami ilmu psikologi perinatal, tetapi juga harus memiliki kecerdasan budaya (*cultural competence*). Kecerdasan budaya memungkinkan bidan untuk memahami cara pandang masyarakat terhadap gangguan mental, bahasa yang digunakan untuk menggambarkan perasaan atau tekanan batin, serta hambatan-hambatan sosial yang dihadapi oleh ibu dalam mencari bantuan. Dengan pemahaman ini, bidan dapat menyampaikan edukasi secara lebih sensitif, tidak menghakimi, dan dalam bahasa yang sesuai dengan konteks budaya. Sebagai contoh, dalam komunitas yang memandang gangguan mental sebagai "penyakit spiritual," bidan dapat menyampaikan pentingnya dukungan emosional dengan cara yang menghargai keyakinan tersebut tanpa menolak pendekatan medis (Ahmed et al., 2023).

Selain edukasi individual, advokasi komunitas juga merupakan pendekatan penting. Bidan dapat melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, atau kader kesehatan lokal dalam kampanye tentang kesehatan mental ibu, sehingga informasi dapat diterima secara lebih luas dan dengan resistensi yang lebih rendah. Program berbasis komunitas yang menekankan pentingnya kesejahteraan emosional selama kehamilan dan pascapersalinan telah terbukti meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma, dan mendorong ibu untuk mencari bantuan lebih awal (Kim et al., 2021).

Dengan demikian, tantangan budaya dan stigma terhadap gangguan psikologis pada ibu tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan medis semata, melainkan memerlukan strategi edukasi dan advokasi yang kontekstual, berkelanjutan, dan berbasis empati. Bidan, sebagai pelayan kesehatan yang memiliki posisi sosial yang kuat dalam masyarakat, perlu diperlengkapi dengan keterampilan ini agar dapat menjadi agen perubahan dalam upaya meningkatkan kesehatan mental ibu.

F. Latihan Soal

Soal 1

Kasus:

Ny. R, usia 29 tahun, baru saja melahirkan anak pertama satu minggu yang lalu. Ia tampak cemas, mudah menangis, dan merasa tidak mampu mengurus bayinya. Suaminya bekerja di luar kota dan jarang pulang. Ny. R mengatakan bahwa ia merasa sendirian dan tidak yakin bisa menjadi ibu yang baik.

Pertanyaan:

Apa intervensi awal yang paling tepat dilakukan bidan terhadap kondisi psikologis Ny. R?

- A. Menyarankan Ny. R untuk fokus pada rutinitas bayi agar tidak terlalu banyak berpikir
- B. Memberikan dukungan emosional dan melakukan asesmen psikososial
- C. Mengarahkan Ny. R untuk segera mengunjungi psikiater
- D. Memberi saran untuk tinggal sementara dengan orang tua
- E. Menunda diskusi karena kondisi ibu masih terlalu emosional

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Bidan perlu memberikan dukungan emosional dan segera melakukan asesmen psikososial agar dapat mengidentifikasi tingkat stres, kondisi emosi, dan dukungan sosial yang dimiliki ibu. Ini penting sebagai langkah awal untuk menentukan apakah kondisi ibu normal (baby blues) atau memerlukan rujukan lebih lanjut.

Soal 2

Kasus:

Ny. A, usia 34 tahun, datang ke posyandu 3 bulan setelah melahirkan. Ia mengeluhkan kelelahan berlebih, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, sulit tidur, dan merasa bersalah tidak bisa menyusui secara eksklusif. Ia juga menangis tanpa alasan yang jelas.

Pertanyaan:

Berdasarkan gejala yang dialami, kemungkinan besar Ny. A mengalami kondisi:

- A. Postpartum euforia
- B. Baby blues
- C. Depresi pascapersalinan
- D. Gangguan kepribadian
- E. Gangguan tidur ringan

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Gejala yang dialami Ny. A sesuai dengan tanda-tanda depresi pascamelahirkan, yaitu munculnya rasa bersalah, kehilangan energi, penurunan minat, serta perubahan pola tidur dan emosi. Berbeda dengan baby blues yang biasanya terjadi dalam dua minggu pertama, kondisi ini terjadi lebih lama dan membutuhkan penanganan lebih serius.

Soal 3

Kasus:

Ny. M merasa cemas dan rendah diri setelah sering membandingkan dirinya dengan ibu-ibu lain yang terlihat sukses menyusui dan mengurus bayi di media sosial. Ia merasa gagal menjadi ibu yang baik, meskipun kondisi bayinya sehat.

Pertanyaan:

Apa bentuk intervensi bidan yang paling tepat dalam menghadapi situasi ini?

- A. Menyarankan Ny. M berhenti menggunakan media sosial
- B. Mengedukasi tentang literasi digital dan dampak perbandingan sosial
- C. Menyalahkan media sosial sebagai penyebab utama stres ibu
- D. Menganjurkan Ny. M untuk menghapus semua akun media sosial
- E. Menyarankan Ny. M menuliskan semua kekhawatirannya di buku harian

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Bidan berperan penting dalam memberikan edukasi kepada ibu tentang bagaimana media sosial bisa mempengaruhi persepsi diri. Literasi digital membantu ibu memahami bahwa apa yang ditampilkan di media sosial belum tentu mencerminkan kenyataan. Ini akan mengurangi dampak perbandingan sosial dan kecemasan yang ditimbulkan.

Soal 4

Kasus:

Seorang ibu menolak periksa ke puskesmas karena pernah mengalami tindakan episiotomi tanpa penjelasan pada persalinan sebelumnya. Ia merasa trauma dan tidak percaya pada layanan kesehatan.

Pertanyaan:

Pendekatan apa yang paling tepat digunakan bidan dalam membangun kembali kepercayaan ibu tersebut?

- A. Meyakinkan ibu bahwa pelayanan sekarang sudah berbeda
- B. Memberikan selebaran tentang prosedur episiotomi
- C. Menggunakan pendekatan trauma-informed care dan empati
- D. Menyarankan ibu pindah ke klinik swasta
- E. Menjelaskan bahwa trauma adalah reaksi berlebihan

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Bidan harus memahami bahwa pengalaman buruk dapat membentuk persepsi jangka panjang terhadap layanan kesehatan. Dengan pendekatan trauma-informed care, bidan menunjukkan empati, menghargai otonomi pasien, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk mengembalikan kepercayaan ibu secara bertahap.

Soal 5

Kasus:

Ny. L, seorang ibu muda dari komunitas adat, menunjukkan tanda-tanda depresi pascapersalinan. Namun ia menolak dirujuk ke psikolog karena khawatir dianggap "lemah iman" oleh keluarganya.

Pertanyaan:

Apa peran bidan yang paling strategis dalam kasus ini?

- A. Menghentikan upaya rujukan karena ibu menolak
- B. Mengedukasi dengan bahasa medis secara langsung
- C. Melibatkan tokoh adat atau keluarga dalam edukasi sensitif budaya
- D. Menyarankan ibu pindah ke lingkungan yang lebih terbuka
- E. Menunggu hingga ibu sendiri meminta bantuan

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Bidan harus menggunakan pendekatan sensitif budaya dalam memberikan edukasi. Dengan melibatkan tokoh yang dihormati dalam komunitas atau keluarga, pesan tentang pentingnya kesehatan mental lebih mudah diterima. Ini adalah strategi efektif untuk menurunkan stigma dan membuka akses layanan bagi ibu.

G. Rangkuman Materi

Psikologi dalam praktik kebidanan merupakan aspek fundamental dalam pemberian asuhan yang komprehensif kepada ibu, bayi, dan keluarga. Aspek psikologis ini menjadi sangat krusial karena kehamilan, persalinan, dan masa nifas adalah periode transisi yang penuh tantangan emosional dan sosial. Di era modern, dinamika ini semakin kompleks seiring dengan berkembangnya media sosial, tuntutan hidup, dan perubahan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Perubahan psikososial ibu dalam era digital ditandai dengan meningkatnya tekanan terhadap peran sebagai ibu yang sempurna, perbandingan sosial yang tidak sehat melalui media digital, serta ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan pengasuhan anak. Bidan memiliki peran penting dalam memberikan dukungan psikososial dengan pendekatan empatik dan berbasis hubungan saling percaya.

Gangguan psikologis selama masa kehamilan dan pascamelahirkan, seperti baby blues, depresi postpartum, dan gangguan kecemasan, menunjukkan tren peningkatan. Faktor risiko utama meliputi riwayat gangguan mental sebelumnya, kurangnya dukungan sosial, tekanan ekonomi, serta rendahnya literasi kesehatan mental. Oleh karena itu, bidan diharapkan mampu melakukan deteksi dini melalui skrining psikologis dan memberikan intervensi awal seperti konseling, terapi kognitif perilaku, dan rujukan yang sesuai.

Media sosial dan digitalisasi berdampak ganda terhadap kesehatan mental ibu. Di satu sisi, platform digital memberi akses informasi dan dukungan, namun di sisi lain memunculkan mom-shaming, kecemasan karena perbandingan sosial, dan penyebaran informasi yang tidak valid. Bidan perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi literasi digital dan membimbing ibu dalam menggunakan media sosial secara sehat.

Isu kepercayaan terhadap layanan kesehatan juga menjadi tantangan yang serius, terutama bagi ibu dengan pengalaman traumatis atau yang terpapar informasi menyesatkan. Pendekatan trauma-informed care menjadi strategi penting yang harus dikuasai bidan untuk membangun kembali kepercayaan pasien dengan cara menghormati otonomi, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menciptakan lingkungan yang aman.

Selain itu, tantangan budaya dan stigma terhadap gangguan psikologis masih menjadi hambatan dalam pencarian pertolongan. Dalam banyak komunitas, gangguan mental dianggap tabu atau sebagai kelemahan pribadi. Oleh karena itu, bidan harus memiliki kecerdasan budaya dalam menyampaikan edukasi dan menjalin kolaborasi dengan tokoh masyarakat serta keluarga untuk menurunkan stigma dan meningkatkan akses layanan psikologis.

Secara keseluruhan, pemahaman terhadap tren dan isu psikologi dalam praktik kebidanan menuntut bidan untuk tidak hanya mahir secara klinis, tetapi juga peka terhadap kondisi psikologis, sosial, budaya, dan digital yang melingkupi kehidupan ibu dan keluarganya.

H. Glosarium

Psikologi Kebidanan

Cabang ilmu yang mempelajari aspek psikologis ibu, bayi, dan keluarga dalam masa kehamilan, persalinan, dan nifas serta implikasinya terhadap praktik asuhan kebidanan yang komprehensif dan empatik.

Perubahan Psikososial

Perubahan dalam aspek emosional, sosial, dan perilaku yang dialami individu selama masa transisi kehidupan, seperti kehamilan dan pascapersalinan.

Baby Blues

Gangguan emosional ringan yang umum terjadi pada ibu beberapa hari setelah melahirkan, ditandai dengan perubahan mood, menangis tiba-tiba, dan kelelahan, biasanya bersifat sementara.

Depresi Postpartum

Gangguan suasana hati yang serius dan berlangsung lebih lama setelah melahirkan, ditandai dengan rasa sedih mendalam, kehilangan minat, dan gangguan dalam menjalin hubungan dengan bayi.

Trauma-Informed Care

Pendekatan pelayanan yang berlandaskan pada pemahaman terhadap dampak trauma dan bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pilihan pasien, dan mendorong pemulihan emosional.

Social Comparison

Proses membandingkan diri dengan orang lain, khususnya dalam konteks media sosial, yang dapat berdampak negatif terhadap harga diri dan kesehatan mental.

Literasi Digital Kesehatan

Kemampuan untuk mengakses, memahami, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan yang diperoleh melalui media digital secara tepat dan bertanggung jawab.

Kecerdasan Budaya (Cultural Competence)

Kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami dan menghormati nilai, keyakinan, dan kebiasaan budaya pasien dalam pemberian layanan asuhan kesehatan.

Mom-Shaming

Fenomena sosial berupa kritik atau penilaian negatif terhadap cara seorang ibu mengasuh anaknya, sering terjadi di media sosial dan dapat menyebabkan stres emosional.

Intervensi Psikososial

Upaya atau tindakan yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok menghadapi masalah psikologis atau sosial, seperti konseling, dukungan kelompok, dan edukasi.

I. Daftar Pustaka

- Abrams, L. S., Dornig, K., & Curran, L. (2020). Barriers to service use for postpartum depression symptoms among low-income ethnic minority mothers in the United States. *Qualitative Health Research, 30*(4), 489–502. <https://doi.org/10.1177/1049732319880539>
- Ahmed, S., Ali, N. S., & Khan, M. (2023). Exploring cultural perceptions of postpartum mental health in South Asian communities: A qualitative study. *BMC Women's Health, 23*(1), 98. <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02278-6>
- Ali, S. H., Foreman, J., Capasso, A., Jones, A. M., Tozan, Y., & DiClemente, R. J. (2021). Social media as a recruitment platform for a nationwide online survey of COVID-19 knowledge, beliefs, and practices in the United States. *JMIR Formative Research, 5*(7), e27700. <https://doi.org/10.2196/27700>
- Altman, M. R., Oseguera, T., McLemore, M. R., Kantrowitz-Gordon, I., Franck, L. S., & Lyndon, A. (2021). Information and power: Women of color's experiences interacting with health care providers in pregnancy and birth. *Social Science & Medicine, 270*, 113674. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113674>
- Barlow, J., Sleet, M., & Midgley, N. (2022). Cultural adaptations of parenting and mental health interventions: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(7), 4105. <https://doi.org/10.3390/ijerph19074105>
- Chae, J., Lee, C. J., & Park, E. (2023). Comparing oneself with moms on social media: The effect of social comparison and emotional support on maternal mental health. *Journal of Health Communication, 28*(1), 40–51. <https://doi.org/10.1080/10810730.2022.2160754>
- Dennis, C. L., Falah-Hassani, K., Shiri, R., Brown, H. K., & Vigod, S. (2022). The epidemiology of perinatal anxiety and depression: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Psychiatry, 83*(1), 22r14462. <https://doi.org/10.4088/JCP.22r14462>
- Field, T. (2021). Prenatal anxiety effects: A review. *Infant Behavior and Development, 63*, 101552. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2021.101552>

- Guintivano, J., Sullivan, P. F., & Stuebe, A. M. (2020). Preeclampsia and postpartum depression: A bidirectional relationship. *Obstetrics & Gynecology*, 135(1), 52–61. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003600>
- Jiang, H., Li, M., Wen, L. M., Hu, Q., & He, G. (2021). Digital media use and postpartum depression among Chinese mothers: A cross-sectional study. *BMC Psychiatry*, 21, 359. <https://doi.org/10.1186/s12888-021-03402-w>
- Kim, J. E., Lee, S. H., & Lee, K. (2021). Community-based mental health promotion and stigma reduction: Evaluating a maternal wellness program. *Journal of Community Psychology*, 49(3), 758–773. <https://doi.org/10.1002/jcop.22487>
- Kirkham, M., Stapleton, H., Curtis, P., & Thomas, G. (2023). Building trust in maternity care: The midwife–mother relationship. *Midwifery*, 119, 103662. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103662>
- Lebel, C., MacKinnon, A., Bagshawe, M., Tomfohr-Madsen, L., & Giesbrecht, G. (2020). Elevated depression and anxiety symptoms among pregnant individuals during the COVID-19 pandemic. *Journal of Affective Disorders*, 277, 5–13. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.07.126>
- Loomba, S., de Figueiredo, A., Piatek, S. J., de Graaf, K., & Larson, H. J. (2021). Measuring the impact of COVID-19 vaccine misinformation on vaccination intent in the UK and USA. *Nature Human Behaviour*, 5(3), 337–348. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01056-1>
- Moon, H. Y., Park, S. Y., & Song, Y. (2022). Social media–based interventions for perinatal depression: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(18), 11300. <https://doi.org/10.3390/ijerph191811300>
- Mosley, E. A., Kintziger, K. W., Sabo, R. T., & Shannon, C. N. (2021). Implementing trauma-informed care in maternal and child health systems. *Maternal and Child Health Journal*, 25(3), 348–356. <https://doi.org/10.1007/s10995-020-03031-2>
- Muscanell, N. L., & Guadagno, R. E. (2020). The impact of social media on maternal mental health: A review of current literature and future directions. *Journal of Reproductive and Infant Psychology*, 38(5), 482–495. <https://doi.org/10.1080/02646838.2020.1740185>
- O'Hara, M. W., & Wisner, K. L. (2022). Perinatal mental illness: Definition, description and a framework for action. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 77, 3–14. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2021.10.005>
- O'Hara, M. W., Stuart, S., & Watson, D. (2022). The perinatal mental health crisis: Opportunities and challenges for care delivery. *American Psychologist*, 77(2), 187–202. <https://doi.org/10.1037/amp0000911>

- Rahman, A., Fisher, J., Bower, P., Luchters, S., Tran, T., Yasamy, M. T., & Saxena, S. (2021). Interventions for common perinatal mental disorders in women in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Bulletin of the World Health Organization*, 99(5), 359–370. <https://doi.org/10.2471/BLT.20.270223>
- Schroll, A. M., Wenzlaff, H., & Midtgaard, J. (2022). "I was stripped of my power": Women's experiences of traumatic childbirth and its impact on trust in maternity care. *Women and Birth*, 35(2), 148–155. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.03.008>
- Shorey, S., & Chee, C. Y. I. (2021). A systematic review of psychological interventions for maternal anxiety and depression in the perinatal period. *Archives of Women's Mental Health*, 24, 813–826. <https://doi.org/10.1007/s00737-020-01070-z>
- Tandon, S. D., Ward, E. A., Heller, C. G., & Hamil, J. L. (2021). Social media use and postpartum anxiety: A mixed-methods study. *JMIR Mental Health*, 8(5), e25375. <https://doi.org/10.2196/25375>
- Topalidou, A., Boorman, R., Cope, S., & Hollowell, J. (2020). COVID-19 and maternal mental health: Are we getting the balance right? *BMJ Open*, 10(10), e038888. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038888>
- Waqas, A., Elhady, M., Surya, M., & Rahman, A. (2023). Psychological interventions for maternal mental health in low- and middle-income countries: A systematic review. *The Lancet Psychiatry*, 10(2), 110–125. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(23\)00015-6](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00015-6)
- Yildiz, P. D., Ayers, S., & Phillips, L. (2021). The prevalence of posttraumatic stress disorder in the perinatal period: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 263, 413–426. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.11.027>
- Zolnikov, T. R., & Furio, F. (2020). Trust and mistrust in the perceptions of healthcare: Voices from Africa. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1), 689. <https://doi.org/10.3390/ijerph17020689>

BAB 9

KESEHATAN MENTAL PADA PERINATAL

Pendahuluan

Masa nifas merupakan masa yang rawan bagi ibu, sekitar 60% kematian ibu terjadi setelah melahirkan dan hampir 50% dari kematian pada masa nifas terjadi komplikasi masa nifas. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab bidan untuk memberikan asuhan kebidanan ibu nifas dengan memantauwan mencegah beberapa kematian ini (Arumsari et al., 2023). Pada masa nifas atau sehabis bersalin ibu merasa lelah harus istirahat dengan tidur terlentang untuk beberapa jam kemudian baru boleh miring kanan dan kiri untuk mencegah thrombosis dan tromboemboli. Ibu yang melahirkan secara normal bisa melakukan mobilisasi 6 jam setelah bersalin dan 8 jam setelah bersalin pada ibu yang mengalami sesar. Ibu nifas akan lebih sehat dan kuat dengan mobilisasi dini, karena otot-otot panggul dan perut akan kembali normal sehingga menjadi kuat dan mengurangi rasa sakit, fungsi usus dan kandung kencing lebih baik dan mempercepat organ-organ tubuh kembali seperti semula dan memperlancar sirkulasi darah menjadi normal atau lancar (Howard and Khalifeh, 2020).

Berikut adalah beberapa komponen yang biasanya terdapat dalam pendahuluan sebuah buku ajar:

1. Judul: Psikologi dalam Praktik Kebidanan
2. Pengantar Penulis: Penulis adalah seorang dosen yang saat ini ditugaskan di Prodi Pendidikan Profesi Bidan. Penulis sudah berpengalaman secara teori maupun praktik terkait kesehatan mental pada perinatal.
3. Tujuan Buku: Tujuan dari bab ini adalah untuk menambah wawasan pembaca terkait kesehatan mental pada perinatal tentang definisi kesehatan mental pada perinatal dan perubahan normal emosi selama kehamilan, persalinan, dan nifas
4. Sasaran Pembaca: Bab ini harapannya dapat digunakan oleh mahasiswa di bidang kesehatan, khususnya mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dokter, dan konselor kesehatan atau psikolog. Buku ini juga dapat digunakan untuk masyarakat umum, terutama bagi perempuan, ibu hamil, bersalin, dan nifas serta keluarganya.
5. Isi Buku: Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang dirancang untuk menambah pemahaman tentang kesehatan mental perempuan. Sub bab ini terdiri dari:

- a. Definisi kesehatan mental pada perinatal: Sub bab ini membahas terkait definisi kesehatan mental pada perinatal dari berbagai ahli atau referensi.
 - b. Perubahan normal emosi selama kehamilan, persalinan, dan nifas: Sub bab ini membahas terkait berbagai macam perubahan yang normal pada emosi ibu selama masa hamil, bersalin, dan nifas, serta membahas terkait peran bidan dalam mengelola masalah tersebut.
6. Metode Pembelajaran: Bab ini menggunakan metode pembelajaran teks tulisan, gambar, latihan, atau sumber daya tambahan seperti ceramah, diskusi kelompok dan simulasi. Pembaca dapat mengerjakan soal latihan untuk menilai pemahaman terkait materi ajar yang telah dibaca. Pembaca juga dapat melakukan simulasi atau mengaplikasikan asuhan yang diberikan berdasarkan kasus yang ditemui saat di lapangan atau tempat praktik terkait kesehatan mental pada perinatal.
7. Pendekatan Pembelajaran: Pendekatan pembelajaran dalam bab ini bersifat partisipatif dan reflektif. Pembaca didorong untuk mengaitkan informasi yang diperoleh dengan pengalaman praktis serta berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Pembelajaran ini juga menerapkan komunikasi efektif dalam menghadapi permasalahan terkait kesehatan mental pada perinatal.
8. Pedoman Penggunaan: Bab ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembaca untuk dapat memahami setiap materi yang ada pada bab ini, mulai dari definisi kesehatan mental pada perinatal dari berbagai ahli atau referensi. Berbagai macam perubahan yang normal pada emosi ibu selama masa hamil, bersalin, dan nifas, serta membahas terkait peran bidan dalam mengelola masalah tersebut. Pembaca disarankan untuk mempelajari setiap sub bab secara bertahap, dengan melakukan refleksi kasus yang ditemukan di sekitar dan mengerjakan latihan soal yang telah disediakan. Pembaca juga disarankan untuk mengeksplorasi sumber daya tambahan, seperti literatur review, jurnal atau artikel terkait intervensi atau asuhan kebidanan yang sesuai dengan permasalahan kesehatan mental pada perinatal sebagai upaya untuk mengukur pemahaman dan keterampilan pembaca.

Tujuan Intruksional:

1. Memahami definisi kesehatan mental pada perinatal
2. Memahami perubahan normal emosi selama kehamilan, persalinan, dan nifas
3. Memahami hal-hal yang berisiko mempengaruhi kesehatan mental
4. Memahami faktor yang mempengaruhi perubahan emosi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu menjelaskan definisi kesehatan mental pada perinatal
2. Mampu menjelaskan perubahan normal emosi selama kehamilan, persalinan, dan nifas
3. Mampu menjelaskan hal-hal yang berisiko mempengaruhi kesehatan mental
4. Mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan emosi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Uraian Materi

Kehamilan merupakan suatu peristiwa penting dan kompleks bagi seorang wanita yang disertai dengan adanya berbagai macam respon fisik dan psikologis. Kehamilan adalah proses transisi biologis, sosial, dan emosional bagi seorang perempuan. Masa kehamilan terjadi selama 36 minggu. Proses kehamilan melibatkan perubahan psikologis yang dapat membuat wanita rentan terkena gejala masalah kesehatan mental. Skala global 10% ibu hamil dan 13% wanita yang baru saja melahirkan mengalami masalah kesehatan mental, terutama depresi. Negara-negara berkembang seperti Indonesia angka kejadian masalah kesehatan mental pada ibu hamil lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Berbagai macam masalah kesehatan mental yang dialami ibu hamil yaitu depresi, gangguan suasana hati yang rendah, kecemasan, psikosis, dan emosi yang tidak terkendali (Savitri et al., 2022).

Tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam melakukan deteksi dini masalah kesehatan mental ibu hamil. Tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan ibu hamil seringkali tidak menyadari tanda-tanda adanya masalah kesehatan mental pada wanita selama masa kehamilan. Tanda-tanda tersebut seringkali disalahartikan sebagai faktor hormon, fisik dan sosial lainnya. Ketidakmampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi masalah kesehatan mental akan berdampak negatif terhadap ibu hamil. Kegagalan dalam mengatasi atau menangani masalah kesehatan mental pada periode kehamilan berdampak pada buruknya status kesehatan ibu dan bayi, meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, terlambatnya perkembangan anak, adanya masalah perilaku, bunuh diri, dan pembunuhan bayi (Antoniou et al., 2021).

A. Definisi Kesehatan Mental pada Perinatal

Kesehatan mental perinatal adalah gangguan kejiwaan yang sering terjadi pada wanita selama kehamilan dan hingga satu tahun setelah melahirkan. Hal ini mencakup berbagai masalah seperti baby blues, gangguan kecemasan, depresi pascapersalinan, dan psikosis pascapersalinan. Gangguan ini dapat mempengaruhi ibu dan bayi, dan penting dikenali dan ditangani dengan tepat (Law et al., 2021).

Kesehatan mental adalah keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan/kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidup (Law et al., 2021). Kesehatan mental adalah terwujudnya integritas kepribadian, keselarasan dengan jati diri, pertumbuhan ke arah realisasi diri, dan ke arah hubungan yang sehat dengan orang lain, sehingga kesehatan mental adalah keadaan "Tingkat,

kesejahteraan mental” dimana individu dapat berfungsi secara adekuat dapat menikmati hidupnya secara seimbang dan mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan hidup dan mampu berkontribusi pada kehidupan sosial budaya dan agama berperan dalam memberi batasan sehat/tidak sehat. Pada pengertian yang lebih “positif” tersebut kesehatan mental merupakan fondasi dari tercapainya kesejahteraan (well-being) individu dan fungsi yang efektif dalam komunitasnya (Griffen et al., 2021).

Periode perinatal merupakan periode yang dimulai dari awal terbentuknya hasil konsepsi hingga awal postpartum. Pada periode perinatal ini banyak perubahan yang terjadi pada tubuh ibu baik secara fisiologis maupun psikologis. Salah satu perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu adalah perubahan kadar estrogen dan progesteron. Kadar estrogen dan progesteron sangat tinggi pada saat hamil kemudian mulai menurun menjelang persalinan dan akan menurun secara drastis setelah melahirkan. Adanya perubahan hormon estrogen dan progesteron secara drastis dapat menyebabkan perinatal mood and anxiety disorders. Perubahan psikologis yang terjadi pada periode perinatal terutama pada trimester III adalah adanya ketakutan dalam menghadapi persalinan sehingga dapat menimbulkan kecemasan pada ibu hamil (Moore et al., 2021).

Ibu primigravida akan mengalami kecemasan terhadap persalinan lebih besar daripada ibu multigravida karena ibu primigravida belum memiliki pengalaman proses persalinan sebelumnya. Mereka hanya mengetahui proses persalinan dari buku-buku yang mereka baca atau dari informasi yang mereka dapatkan dari orang sekitar tetapi jika informasi yang didapat tidak tepat dapat menimbulkan kecemasan pada ibu hamil. Kecemasan yang terjadi membuat syaraf otonom mengaktifkan hormon adrenal yang mempengaruhi sistem hormon epinefrin. Peningkatan hormon adrenal dan epinefrin dapat menyebabkan disregulasi biokimia pada tubuh ibu sehingga terjadi ketegangan fisik pada ibu hamil. Oleh karena itu, ibu hamil akan mudah marah, tesinggung, dan gelisah (Arumsari et al., 2023).

Perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu hamil tersebut dapat menyebabkan *Perinatal Mood And Anxiety Disorders* (PMADs). Perinatal mood and anxiety disorders adalah gangguan mood dan kecemasan terjadi selama kehamilan hingga 1 tahun pascapersalinan. Perinatal mood and anxiety disorders diklasifikasikan menjadi 6 adalah baby blues, depresi postpartum, psikosis, gangguan panik, gangguan obsesif-kompulsif, gangguan stres pasca trauma. Wanita hamil dan postpartum memiliki gejala perinatal mood and anxiety disorders sebanyak 15% - 20% seperti depresi, cemas, gangguan kompulsif-obsesif,

gangguan stress pasca trauma, dan psikosis postpartum (Howard and Khalifeh, 2020).

Kesehatan mental perinatal merujuk pada masalah kesehatan mental yang terjadi selama periode perinatal, yaitu selama kehamilan dan hingga satu tahun setelah melahirkan (Howard and Khalifeh, 2020).

1. Jenis gangguan

- a. Baby blues: Perasaan sedih, menangis, dan mudah tersinggung yang umum terjadi setelah melahirkan
- b. Gangguan kecemasan: Kecemasan yang berlebihan dan tidak wajar selama kehamilan atau setelah melahirkan
- c. Depresi pascapersalinan: Depresi yang terjadi setelah melahirkan, yang ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan hilangnya minat pada kegiatan sehari-hari
- d. Psikosis pascapersalinan: Gangguan jiwa yang serius dan jarang terjadi, yang ditandai dengan delusi, halusinasi, dan perubahan perilaku yang drastis.

2. Pentingnya

Perinatal mental health adalah hal yang penting karena gangguan kejiwaan selama periode ini dapat berdampak pada kesehatan ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan.

3. Dampak

Gangguan kesehatan mental perinatal dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental ibu, hubungan ibu-bayi, dan perkembangan bayi.

4. Penanganan

Penting untuk mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan mental perinatal dan mencari bantuan profesional, seperti psikolog atau psikiater.

5. Dukungan

Dukungan sosial, keluarga, dan teman juga sangat penting dalam membantu ibu mengatasi masalah kesehatan mental perinatal (Howard and Khalifeh, 2020).

Kesehatan mental memiliki hubungan yang bersifat kontinum. Kesehatan mental dan *mental illness* ditentukan oleh berbagai faktor biologis, psikologis serta sosial, seperti kesehatan dan penyakit pada umumnya. Jika dilihat dari kontinumnya, kesehatan mental yang tidak diperhatikan dapat berkembang menjadi *mental illness*. Keadaan ini relatif menetap namun dapat berubah seiring waktu ataupun situasi yang dialami individu (Arumsari et al., 2023).

1. Positive Mental Health

Individu yang sehat mental atau memiliki *positive mental health* mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan dan dapat menyesuaikan diri

dengan baik. Individu menunjukkan kesejahteraan dan merasakan kebahagiaan. Salah satu ciri individu yang sehat mental adalah memiliki resiliensi. Resiliensi didefinisikan sebagai proses dinamis dimana individu menunjukkan fungsi adaptif dalam menghadapi kesulitan yang signifikan. Resiliensi merupakan kapasitas untuk mengatasi kesulitan dan menghadapi berbagai peristiwa hidup. Resiliensi erat kaitannya dengan kemampuan dalam menyesuaikan diri. Ketika individu mampu menyesuaikan diri, mampu mengatasi kesulitan dan bangkit dari kesulitannya, mereka dianggap memiliki resiliensi (Savitri et al., 2022).

2. Mental Health Problem

Mental health problem mengganggu cara seseorang berpikir, merasa dan berperilaku. Bedanya, tingkatan terganggunya lebih rendah dibanding *mental illness*. *Mental health problem* lebih umum dan dapat dialami dalam waktu sementara sebagai reaksi terhadap tekanan hidup. *Mental health problem* memang lebih ringan dibanding *mental illness*, tetapi masalah ini mungkin berkembang menjadi *mental illness* jika tidak ditangani secara efektif. *Mental health problem* dapat muncul dari berbagai aspek, seperti emosi, perilaku, atensi, serta regulasi diri. Mengalami kekerasan di masa kecil, merasa terasing dari lingkungan, kehilangan orang yang dicintai, stress yang berkepanjangan, kehilangan pekerjaan, penyalahgunaan obat-obatan adalah beberapa contoh faktor yang dapat memicu seseorang memiliki *mental health problem*. Teknik perawatan diri dan perubahan gaya hidup umumnya dapat membantu mengelola gejala *mental health problem* dan memiliki kemungkinan mencegah beberapa masalah berkembang menjadi lebih buruk. Mencari dukungan dari teman, menjaga kesehatan fisik, dan melakukan berbagai aktivitas yang baik untuk kesehatan mental adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi *mental health problem* (Howard and Khalifeh, 2020).

3. Mental illness

American Psychiatric Association (APA) memberikan pengertian terkait *mental illness* sebagai berikut: "...health conditions involving changes in emotion, thinking or behavior (or a combination of these). Mental illnesses are associated with distress and/or problems functioning in social, work or family activities" (APA, 2018) *Mental illness* adalah kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran, atau perilaku (atau kombinasi dari ini). *Mental illness* dikaitkan dengan kesulitan dan/atau masalah yang mengganggu keberfungsian dalam kegiatan sosial, pekerjaan, atau aktivitas keluarga. Artinya, orang yang memiliki *mental illness* secara signifikan memengaruhi cara mereka merasa, berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. *Mental illness* bukanlah hal yang

memalukan melainkan sebuah kondisi medis, sama seperti penyakit jantung atau diabetes (Arumsari et al., 2023).

Mental illness dapat disembuhkan dan para ahli di bidangnya terus memperluas pemahaman serta mengembangkan perawatan untuk membantu orang dengan kondisi kesehatan mental supaya dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. *Mental illness* dapat berbentuk ringan yang hanya mengganggu keberfungsian hidup sehari-hari, namun ada pula kondisi *mental illness* yang sangat parah sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit. Beberapa bentuk *mental illness* adalah skizofrenia, gangguan kecemasan, gangguan mood, dan gangguan kepribadian. Gangguan kesehatan mental dibagi menjadi beberapa klasifikasi oleh para dokter dan ahli supaya menjadi sarana yang dapat dimengerti dalam menggambarkan kondisi gangguan tertentu. Adanya sistem klasifikasi gangguan ini dapat dijadikan pegangan diagnostik untuk para ahli supaya terdapat pemahaman yang sama mengenai pengertian, gejala dan dapat dipilih tindakan mana yang kiranya dapat efektif untuk menanganinya. Klasifikasi yang paling populer digunakan adalah klasifikasi gangguan yang dikemukakan oleh *American Psychiatric Association* (APA) yang disebut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM). DSM telah mengalami revisi sejak tahun 1979 dan saat ini telah mencapai DSM-V. Selain itu, WHO juga membuat klasifikasi gangguan kejiwaan yang disebut *International Classification of Diseases of the World* (Antoniou et al., 2021).

Health Organization (ICD) yang saat ini telah mencapai ICD-10. Kedua sistem klasifikasi ini dioperasionalkan dengan munculnya kriteria dalam bentuk gejala-gejala tetap. Di Indonesia, sistem klasifikasi gangguan yang digunakan oleh para ahli dan tentunya dibuat sesuai dengan gangguan khas yang ada di Indonesia disebut Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa (PPDGJ) dan saat ini telah mencapai PPDGJ-III. *Mental illness* memiliki kriteria standar yang perlu dipenuhi apabila ingin menegakkan diagnosis. Dalam mendiagnosis, apa saja gejala yang dialami, berapa lama gejala tersebut dialami dan dampak apa yang muncul pada individu akibat dari gejala tersebut menjadi pertimbangannya. Perlu diketahui bahwa diagnosis untuk gangguan kesehatan mental tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang melainkan hanya dapat dilakukan oleh profesional seperti psikiater dan psikolog (Arumsari et al., 2023).

B. Perubahan Normal Emosi Selama Kehamilan, Persalinan, dan Nifas

Perubahan emosi sangat banyak dan beragam, karena ibu dihadapkan pada berbagai pengambilan keputusan yang perlu diambil, sehingga merupakan hal yang fisiologis jika ibu mengalami periode kebingungan dan krisis kepercayaan diri.

Kenyataannya banyak ibu yang mengalami fluktuasi antara emosi positif dan negatif. Ketika bidan melakukan pengkajian pada perubahan emosi dan psikologis ibu postpartum, maka bidan perlu mengingat bahwa perubahan emosi dan psikologis yang terjadi pada masa postpartum sangat dipengaruhi perubahan-perubahan emosi dan psikologis tahap sebelumnya dan bagaimana adaptasinya, yaitu pada tahap kehamilan (antenatal) dan tahap persalinan (intranatal). Perubahan emosi mencakup hal-hal sebagai berikut: (Herbert et al., 2022).

1. Perubahan emosi pada masa kehamilan (antenatal)

a. Trimester pertama

- 1) Kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan.
- 2) Kecemasan, kekecewaan.
- 3) Ambivalensi.
- 4) Emosi yang labil (misalnya episode kesedihan yang diperparah oleh kejadian fisiologis seperti mual, muntah, dan kelelahan).
- 5) Peningkatan feminitas (Lustiani et al., 2024).

b. Trimester kedua

- 1) Perasaan sejahtera, terutama saat efek fisiologis seperti kelelahan, mual, dan muntah menghilang.
- 2) Meningkatnya rasa keterikatan dengan janin.
- 3) Stres dan kecemasan mengenai skrining antenatal dan pemeriksaan diagnostik.
- 4) Peningkatan kebutuhan pengetahuan dan informasi sebagai persiapan seiring dengan mendekatnya waktu persalinan.
- 5) Adanya perasaan untuk mengurangi pekerjaan/kesibukan (Alini et al., 2024).

c. Trimester ketiga

- 1) Hilang atau meningkatnya libido.
- 2) Gangguan citra tubuh.
- 3) Dampak psikologis akibat ketidaknyamanan fisiologis, misalnya nyeri punggung dan nyeri epigastrik.
- 4) Kecemasan akan persalinan (misalnya cemas terhadap rasa nyeri).
- 5) Kecemasan mengenai abnormalitas pada janin, yang dapat mengganggu tidur atau menyebabkan mimpi buruk.
- 6) Peningkatan kerentanan terhadap peristiwa penting dalam hidup, misalnya kondisi keuangan, pindah rumah atau kurangnya dukungan persalinan (Herbert et al., 2022).

2. Perubahan emosi pada persalinan (intranatal)

Pada sebagian besar ibu, persalinan akan disambut dengan beragam respon emosi, mulai dari: (Herbert et al., 2022).

- a. Kebahagiaan yang besar dan antisipasi untuk mengungkapkan ketakutan-ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui yang mungkin terjadi.
- b. Ketakutan terhadap peralatan, teknologi yang digunakan, intervensi, penatalaksanaan dan hospitalisasi.
- c. Ketegangan, ketakutan, dan kecemasan mengenai nyeri serta kemampuan untuk melatih kontrol diri selama persalinan.
- d. Perhatian mengenai kesejahteraan bayi dan kemampuan pasangan untuk melakukan coping.
- e. Ketakutan terhadap kematian, rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain tempat ibu melahirkan, kematian, dan sekarat. Kuatnya perasaan semacam ini dapat meningkat jika ibu mengalami komplikasi, seperti perdarahan hebat postpartum, distosia bahu, atau bahkan SC emergency.
- f. Proses persalinan menyebabkan banyak hal yang sifatnya pribadi diketahui oleh orang lain dan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan ketakutan akan berkurangnya privasi dan rasa malu (Herbert et al., 2022).

Bukti yang diperoleh dari studi prospektif yang dilakukan oleh Green et al (1998) tentang harapan ibu dan pengalaman persalinan menunjukkan bahwa ketika ibu bersalin diberi kesempatan membuat pilihan-pilihan dalam persalinan, misalnya pilihan tentang bidan yang akan menolong persalinannya, rencana tempat persalinan, kelas perawatan dll, akan meningkatkan kepuasan yang lebih dan memberikan ketenangan kepada ibu. Isu utama untuk praktik yang muncul dari penelitian ini adalah: (Arumsari et al., 2023).

- a. Persepsi ibu terhadap persalinan dan kelahiran merupakan hal yang krusial untuk penyesuaian emosi ibu.
- b. Intervensi untuk mengatasi masalah psikologis postnatal tidak sama antar ibu, dukung ibu untuk mengambil keputusan yang tepat dalam asuhan terhadap dirinya.
- c. Informasi yang adekuat menurunkan kecenderungan morbisitas psikologis.
- d. Dengan terlibat dalam diskusi mengenai apa yang telah terjadi tidaklah cukup bagi ibu, tetapi dengan berperan dalam memutuskan hasil, akan lebih positif bagi ibu.
- e. Ketidakmampuan bersikap asertif di hadapan tenaga kesehatan lebih cenderung membuat ibu mengalami penurunan suasana hati.
- f. SC emergency berhubungan dengan perasaan yang lebih negatif terhadap bayi.
- g. Pandangan ibu terhadap bayinya berhubungan dengan perasaan kontrol sebelumnya.

Selama persalinan, bidan harus mempertimbangkan faktor yang dapat memicu stres dan hal tersebut harus dicegah atau diminimalisasi, karena apabila tidak diadaptasikan dan diantisipasi dengan baik, maka akan menimbulkan dampak negatif psikologis dan menjadi pengalaman melahirkan yang negatif atau tidak menyenangkan (Arumsari et al., 2023).

3. Perubahan emosi pada nifas (postnatal)

Masa nifas adalah suatu periode 6-8 minggu postpartum yang merupakan masa dimana ibu menyesuaikan diri secara fisiologis dan psikososial untuk menjadi ibu. Respon emosi yang dialami mungkin sangat kuat dan penuh semangat, baik pada ibu yang sudah pernah mengalaminya maupun pada ibu baru. Perubahan psikologis mayor bersifat emosi, dan suasana hati ibu tampak menjadi barometer, yang merefleksikan kebutuhan bayi akan pola menyusui, tidur, dan menangis. Ibu baru cenderung mudah kesal dan sangat sensitif. Rasa keseimbangan sangat mudah hilang karena ibu mungkin merasa tertekan dan mudah marah oleh hal-hal atau kesalahan yang kecil. Ibu mulai memperoleh kembali rasa keseimbangan dan menjadi normal kembali antara 6-12 minggu postpartum (Savitri et al., 2022).

Kemungkinan faktor yang paling penting untuk mendapatkan kembali normalitas ibu adalah kemampuan ibu untuk dapat tidur dengan nyenyak ketika malam, karena sejak menyusui pola tidur berubah mengikuti pola menyusui bayi, ibu sering terbangun pada malam hari, karena menyusui. Hal ini tampaknya akan dapat dicapai pada saat bayi juga mulai mengembangkan pola yang dapat diperkirakan, aktivitasnya rutin, dan menjadi lebih responsif. Namun perasaan sangat lelah dapat timbul pada ibu yang menyusui 6 bulan pertama, pada saat bayi belum mendapatkan makanan pendamping lain selain ASI. Oleh karena itu, ibu juga membutuhkan waktu beberapa bulan atau lebih untuk memperoleh kembali dorongan seksual, stabilitas emosi, dan ketajaman intelektual serta merasa utuh kembali (Howard and Khalifeh, 2020).

Dengan demikian, perubahan emosi normal pada masa nifas bersifat pilihan dan kompleks dan mungkin meliputi hal-hal berikut: (Savitri et al., 2022).

- a. Perasaan yang kontradiktif dan bertentangan mulai dari kepuasan, kegembiraan, kebahagiaan hingga kelelahan, ketidakberdayaan dan kekecewaan karena pada beberapa minggu pertama tampak didominasi oleh hal yang baru dan asing yang tidak terduga.
- b. Kelegaan, 'syukurlah semua telah berakhir', mungkin diungkapkan oleh kebanyakan ibu segera setelah kelahiran, kadang-kadang ibu menanggapi secara dingin terhadap peristiwa yang baru terjadi, terutama bila ibu mengalami persalinan lama dengan komplikasi yang sulit.

- c. Beberapa ibu mungkin merasa dekat dengan pasangan dan bayi, beberapa ibu ingin segera merasakan adanya kontak kulit-ke-kulit (skin to skin contact) dan segera menyusui.
- d. Tidak tertarik atau sangat perhatian terhadap bayi.
- e. Takut terhadap hal yang tidak diketahui dan terhadap tanggungjawab yang sangat berat dan mendadak.
- f. Kelelahan dan peningkatan emosi.
- g. Ketidaknyamanan karena nyeri (misalnya nyeri perineum, nyeri puting susu, dan lain-lain)
- h. Peningkatan kerentanan, tidak mampu memutuskan (misalnya menyusui), rasa kehilangan, libido, gangguan tidur, kecemasan, dan lain-lain.
- i. Postnatal blues atau Postpartum blues (Savitri et al., 2022).

Postnatal blues atau istilah lain postpartum blues merupakan suatu fenomena perubahan psikologis yang dialami oleh ibu. Menurut Cox & Holden angka kejadian postpartum blues sebesar 50-80%, tetapi bervariasi tergantung pada paritasnya. Hal ini karena pengalaman ibu terkait nifas sebelumnya mempengaruhi kemampuan ibu beradaptasi terhadap kondisi perubahan psikologis dan emosi pada masa postpartum sekarang. Postpartum blues biasanya terjadi pada hari ke-3 sampai ke-5 post partum, tetapi kadang dapat juga berlangsung seminggu atau lebih, meskipun jarang. Gambaran kondisi ini bersifat ringan dan sementara. Kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut: (Arumsari et al., 2023).

- a. Sedih.
- b. Cemas tanpa sebab.
- c. Mudah menangis tanpa sebab.
- d. Euforia, kadang tertawa.
- e. Tidak sabar.
- f. Tidak percaya diri.
- g. Sensitif.
- h. Mudah tersinggung (iritabilitas).
- i. Merasa kurang menyayangi bayinya (Arumsari et al., 2023).

Postpartum blues ini dikategorikan sebagai sindroma gangguan mental yang ringan, yang kadang dapat hilang sendiri. Oleh sebab itu, sering tidak dipedulikan sehingga tidak terdiagnosis dan tidak ditindak lanjuti sebagaimana seharusnya. Jika hal ini dianggap ringan, keadaan ini bisa menjadi serius dan dapat berlanjut menjadi depresi dan psikosis post partum. Banyak ibu yang berjuang sendiri dalam beberapa saat setelah melahirkan. Mereka merasakan ada hal yang salah namun mereka sendiri tidak mengetahui penyebabnya. Kunci

untuk mendukung ibu dalam melalui periode ini adalah berikan perhatian dan dukungan yang baik baginya, serta yakinkan padanya bahwa ibu adalah orang yang berarti bagi keluarga dan suami (Antoniou et al., 2021).

Hal yang terpenting adalah berikan kesempatan untuk beristirahat yang cukup. Selain itu, dukungan positif atas keberhasilannya menjadi orang tua dapat membantu memulihkan kepercayaan diri terhadap kemampuannya. Etiologi yang pasti dari Postpartum blues ini masih belum jelas, tetapi pengaruh hormonal misalnya perubahan kadar estrogen, progesteron dan prolaktin tampaknya berpengaruh karena periode terjadinya peningkatan emosi terlihat bersamaan dengan produksi ASI (Cooper & Murray, 1997; Gregoire, 1995). Meskipun hilang sendiri, terjadinya postpartum blues mengindikasikan perlunya dukungan psikososial (Arumsari et al., 2023).

4. Hal-hal yang Berisiko Mempengaruhi Kesehatan Mental

Hal-hal yang berisiko mempengaruhi kesehatan mental, yaitu: (Law et al., 2021).

a. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam kerangka kekerasan berbasis gender dan kekerasan domestik. Kekerasan ini sering mengakibatkan kerugian secara fisik, seksual, dan psikologis terhadap perempuan yang mengalaminya dan kekerasan ini termasuk tindakan, paksaan atau pengekangan sewenang-wenang terhadap kebebasan perempuan yang dapat terjadi di ranah publik maupun privat. Kekerasan yang dilakukan pun tidak hanya sebatas kekerasan fisik tetapi juga meliputi kekerasan seksual, finansial, dan emosional (Law et al., 2021).

Perempuan lebih rentan menderita gangguan jiwa ringan dibandingkan laki-laki. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor seperti siklus hormonal, persalinan, menopause, dan kondisi sosial yang kerap menempatkan perempuan pada posisi yang merugikan. Kekerasan terhadap perempuan baik yang dilakukan oleh orang yang dikenalnya (seperti suami ataupun pacar) maupun orang asing akan semakin meningkatkan risiko perempuan untuk terkena gangguan jiwa seperti stress, depresi, kecemasan yang berlebihan, dan juga fobia. Bahkan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal ini akan menimbulkan trauma kejiwaan berkepanjangan atau yang lebih dikenal sebagai gangguan stress paska trauma (Griffen et al., 2021).

Dampaknya pun acap kali tidak hanya berhenti pada perempuan tersebut saja, tetapi juga berdampak pula pada orang-orang di sekelilingnya termasuk anak-anaknya. Menurut sebuah penelitian, seorang ibu yang mengalami KDRT akan cenderung untuk melakukan kekerasan pada anak-anaknya di rumah dan

cenderung untuk menelantarkan anak-anaknya. Pada hal ini, anak dijadikan sebagai pelampiasan beban psikologis ibu mereka (Antoniou et al., 2021).

b. Penyalahgunaan obat

Penggunaan beberapa obat secara kronis dapat menyebabkan perubahan jangka pendek dan jangka panjang bagi otak, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental bagi para pengguna pecandu narkoba termasuk paranoia, depresi, kecemasan, agresi, halusinasi, dan masalah lainnya. Efek psikis dari kecanduan narkoba datang dari alasan pengguna pecandu narkoba, serta perubahan yang terjadi di otak begitu seseorang menjadi pecandu narkoba. Pada awalnya, banyak orang mulai menggunakan obat-obatan untuk mengatasi rasa stres atau rasa sakit. Efek dari kecanduan narkoba adalah terciptanya suatu siklus di mana dan kapan pun pengguna menghadapi rasa stres atau sakit, mereka merasa perlu untuk menggunakan obat tersebut. Banyak orang yang kecanduan terhadap narkoba dan juga didiagnosis menderita kelainan mental lain dan sebaliknya (Law et al., 2021).

Dibandingkan dengan populasi umum, orang yang kecanduan terhadap narkoba kira-kira dua kali lebih memungkinkan menderita gangguan anxiety atau kecemasan berlebihan. Meskipun gangguan penggunaan narkoba umumnya terjadi dengan penyakit mental. Jadi, inilah obat-obatan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental (Griffen et al., 2021).

Ada pula beberapa faktor lainnya yang bisa memicu penyalahgunaan narkoba, yaitu: (Antoniou et al., 2021).

- 1) Memiliki teman pecandu NAPZA, terutama bagi kaum muda.
- 2) Mengalami masalah ekonomi.
- 3) Pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual.
- 4) Riwayat kecanduan keluarga, kecanduan narkoba kemungkinan melibatkan kecenderungan genetik (Antoniou et al., 2021).

c. Kabar duka

Prolonged grief disorder merupakan suatu gangguan kesedihan yang berkepanjangan mengacu pada sindrom yang terdiri dari serangkaian gejala yang berbeda setelah kematian orang yang dicintai. Seseorang yang mengalami sindrom tersebut biasanya mengalami kesedihan mendalam secara intensif selama lebih dari 12 bulan usai kematian orang yang dicintainya. Biasanya, kesedihan berlarut-larut tersebut menyebabkan seseorang selalu teringat pada orang yang dicintainya hingga mengganggu aspek-aspek lain kehidupan mereka. Namun, ada juga yang berusaha menghindari ingatan atau

kegiatan yang mengingatkan mereka akan peristiwa kehilangan tersebut (Arumsari et al., 2023).

d. Bahaya prolonged grief disorder

Melansir Mayo Clinic, prolonged grief disorder dapat memengaruhi kita secara fisik, mental, dan sosial. Tanpa perawatan yang tepat, sindrom tersebut bisa menyebabkan berbagai komplikasi seperti: (Law et al., 2021).

- 1) Depresi
- 2) Pikiran atau perilaku bunuh diri
- 3) Kecemasan, termasuk PTSD
- 4) Gangguan tidur yang signifikan
- 5) Peningkatan risiko penyakit fisik, seperti penyakit jantung, kanker atau tekanan darah tinggi
- 6) Kesulitan jangka panjang dengan kehidupan sehari-hari, hubungan atau aktivitas kerja
- 7) Alkohol, penggunaan nikotin, atau penyalahgunaan zat (Law et al., 2021).

5. Faktor yang mempengaruhi perubahan emosi selama kehamilan, persalinan dan nifas

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan emosi selama kehamilan

Faktor penyebab perubahan emosi selama kehamilan (Griffen et al., 2021).

1) Stress

Ibu hamil yang mengalami stress dapat mempengaruhi kesehatan tubuh Ibu dan janin. Janin akan sulit atau lambat dalam perkembangan dan mengalami gangguan emosi saat lahir nanti jika Ibu hamil yang stress tidak ditangani cepat dengan baik (Arumsari et al., 2023).

2) Dukungan keluarga

Dukungan keluarga juga merupakan hal yang besar dalam menentukan status kesehatan Ibu. Jika seluruh anggota keluarga mengharapkan kehamilan Ibu, mendukung dan memberikan semangat bahkan memperlihatkan dukungannya dalam berbagai hal seperti dalam pemilihan makanan, maka Ibu hamil akan merasa lebih percaya diri, lebih bahagia dan siap dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya nanti (Griffen et al., 2021).

3) Faktor lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi

Faktor ini sangat berpengaruh dalam kehamilan yaitu adat istiadat, gaya hidup, dan fasilitas kesehatan serta tentu saja ekonomi. Gaya hidup sehat adalah sebuah gaya yang berisi tentang kesehatan dari berbagai faktor hidup yang digunakan Ibu hamil. Seorang Ibu hamil sebaiknya tidak merokok, bahkan kalau perlu selalu menghindari asap rokok, kapan dan di

mana pun ia berada, serta harus memperhatikan cara atau pola makan Ibu, apalagi yang berhubungan dengan adat istiadat yang berada di lingkungan sekitar. Jika ada makanan yang tidak dibolehkan dalam adat istiadat tersebut padahal baik dan sangat berguna untuk gizi dan kesehatan Ibu hamil, maka sebaiknya tetap dikonsumsi atau dimakan. Begitupun juga sebaliknya. Yang tak kalah penting adalah *personal hygiene*. Seorang Ibu hamil harus selalu menjaga kebersihan pada tubuhnya atau dirinya, seperti mengganti pakaian dalamnya setiap kali pakaian dalam tersebut terasa lembab, menggunakan *bra* yang menunjang payudara, dan pakaian yang menyerap keringat (Arumsari et al., 2023).

Ekonomi juga selalu menjadi faktor penentu dalam proses kehamilan yang sehat dan baik. Keluarga yang memiliki ekonomi yang cukup atau pendapatan yang cukup dapat memeriksakan kehamilannya ke klinik atau puskesmas secara rutin, merencanakan persalinan tenaga kesehatan dan melakukan persiapan lainnya dengan baik. Akan tetapi dengan adanya rencana yang telah di buat sejak awal, yaitu membuat tabungan bersalin, maka kehamilan dan proses persalinan serta masa nifas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal yang harus diperhatikan dengan baik adalah kehamilan bukanlah suatu keadaan patologis yang berbahaya. Dengan demikian, kehamilan harus disambut dan dipersiapkan dengan sangat baik agar dapat dilalui dengan aman dan lancar (Griffen et al., 2021).

4) Kegelisahan dan ketakutan menjelang kelahiran

Walaupun Ibu hamil memiliki banyak waktu yaitu bulan mempersiapkan proses persalinan, ketika waktunya sudah dekat akan melahirkan, Ibu tetap saja merasa panik dan cemas serta khawatir. Kesiapan fisik dan kesehatan hal tersebut tidak cukup untuk melahirkan seorang anak ke dunia. Tetapi, Ibu juga harus mempersiapkan mental atau psikologisnya. Perasaan cemas dan takut melahirkan memang wajar terjadi. Apabila ini merupakan persalinan pertama, ibu bisa saja memikirkan hal-hal buruk atau hal tidak baik akan terjadi. Akan tetapi, persalinan yang kedua juga tetap masih bisa merasakan cemas dan takut. Misalnya karena persalinan pertama Ibu tidak lancar, karena hal itu Ibu takut hal tersebut terulang lagi pada persalinan keduanya. Atau justru karena persalinan pertama Ibu sangat baik dan lancar, yang menyebabkan ibu khawatir persalinan kedua akan bermasalah dan buruk (Antonioni et al., 2021).

Jika Ibu merupakan salah satu dari banyaknya wanita hamil yang takut dan khawatir melahirkan, ibu harus melakukan teknik khusus untuk menangani rasa ketakutan tersebut. Pada dasarnya, persalinan adalah suatu

pengalaman yang dialami setiap wanita dan kejadian yang indah, tidak selalu menakutkan dan menegangkan serta bukan suatu hal yang buruk seperti yang ada dalam pikiran dan perasaan Ibu. Ibu harus mengingat bahwa tubuh wanita sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa melakukan persalinan. Jangan sampai momen berharga tersebut. Ibu melewatkannya hanya karena diliputi rasa takut dan khawatir (Arumsari et al., 2023).

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Emosi Selama Persalinan

Faktor yang perubahan emosi dalam menghadapi persalinan dapat dibagi menjadi faktor presipitasi dan faktor predisposisi yaitu: (Moore et al., 2021).

1) Faktor Presipitasi

- a) Faktor biologi: rasa nyeri persalinan
- b) Faktor psikologi: ketakutan akan menjadi orang tua baru, hubungan keluarga yang tidak harmonis, adanya trauma akan persalinan yang lalu
- c) Faktor sosial: tidak adanya dukungan dalam keluarga.

2) Faktor Predisposisi

a) Tingkat Pengetahuan dan Pendidikan

Pengetahuan yang rendah mengakibatkan seseorang mudah mengalami kecemasan. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang persalinan baik dari orang terdekat, keluarga, tenaga kesehatan, maupun dari berbagai media seperti majalah dan lainnya. Pasangan suami istri yang berpendidikan tinggi dan mengikuti kelas ibu hamil serta banyak membaca buku tentang kelahiran mereka lebih tenang dan siap dalam proses persalinan.

b) Usia

Usia ibu dapat memberikan dampak terhadap perasaan cemas saat persalinan. Ibu usia di bawah 20 tahun kesiapan mental masih sangat kurang sehingga dalam menghadapi kelahiranpun masih belum mantap. Ibu berusia di atas 35 tahun meskipun secara fisik risiko terjadinya komplikasi lebih besar, tetapi secara mental mereka lebih siap.

c) Paritas

Paritas juga dapat mempengaruhi kecemasan. Pada primigravida merasakan kecemasan karena tidak adanya bayangan mengenai apa yang akan terjadi saat bersalin nanti dan mendengar cerita mengerikan dari teman atau kerabat tentang pengalaman saat melahirkan seperti ibu atau bayi meninggal dan hal ini dapat mempengaruhi pikiran ibu mengenai proses persalinan yang menakutkan. Pada multigravida muncul perasaan cemas biasanya diakibatkan oleh bayangan rasa sakit yang dideritanya dulu sewaktu melahirkan.

d) Keadaan fisik ibu

Seseorang yang menderita penyakit akan lebih mudah mengalami kecemasan dibandingkan dengan orang yang tidak menderita sakit. Jika seorang ibu yang hamil disertai dengan suatu penyakit penyerta maka ibu tersebut akan lebih cemas lagi karena berisiko terjadi hal-hal yang patologis.

e) Pendamping Persalinan

Pendamping persalinan merupakan faktor pendukung dalam lancarnya persalinan karena dukungan orang terdekat terutama suami sangat mempengaruhi kecemasan ibu saat persalinan. Kehadiran suami membuat ibu merasa lebih tenang dan siap menghadapi proses persalinan (Antoniou et al., 2021).

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Emosi Selama Nifas

Beberapa hal yang disebutkan sebagai penyebab terjadinya perubahan emosi selama nifas, diantaranya: (Moore et al., 2021).

1) Perubahan hormonal

Pasca melahirkan terjadi penurunan kadar estrogen dan progesterone yang drastis, dan juga disertai penurunan kadar hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang menyebabkan mudah lelah, penurunan mood, dan perasaan tertekan.

2) Fisik

Kehadiran bayi dalam keluarga menyebabkan perubahan ritme kehidupan sosial dalam keluarga, terutama ibu. Mengasuh si kecil sepanjang siang dan malam sangat menguras energi ibu, menyebabkan berjangkanya waktu istirahat, sehingga terjadi penurunan ketahanan dalam menghadapi masalah.

3) Psikis

Kecemasan terhadap dalam berbagai hal, seperti ketidakmampuan dalam mengurus si kecil, ketidakmampuan dalam berbagai permasalahan, rasa tidak percaya diri karena perubahan bentuk tubuh dan sebelum hamil serta kurangnya perhatian terutama suami ikut mempengaruhi terjadinya depresi.

4) Sosial

Perubahan gaya hidup dengan peran sebagai ibu baru butuh adaptasi. Rasa ketertarikan yang sangat pada si kecil dan rasa dijauhi oleh lingkungan juga berperan dalam depresi.

Penyebab baby blues diduga karena perubahan hormonal di dalam tubuh wanita setelah melalui persalinan. Selama menjalani kehamilan, berbagai

hormon dalam tubuh ibu meningkat seiring pertumbuhan janin. Setelah melalui tahap persalinan, jumlah produksi berbagai hormon seperti estrogen, progesteron, dan endorfin mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi kondisi emosional ibu. Kelelahan fisik dan rasa sakit setelah persalinan, air susu yang belum keluar sehingga bayi menjadi alasan lain timbulnya baby blues.

Sedangkan munculnya baby blues juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (Antoniou et al., 2021).

a) Dukungan Sosial

Perhatian dari lingkungan terdekat seperti suami dan keluarga dapat berpengaruh. Dukungan berupa perhatian, komunikasi dan hubungan emosional yang hangat sangat penting. Dorongan moral dari teman-teman yang sudah pernah bersalin juga dapat membantu. Dukungan sosial adalah derajat dukungan yang diberikan kepada individu khususnya sewaktu dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki hubungan emosional yang dekat dengan orang tersebut. Dukungan sosial adalah kenyamanan, bantuan, atau informasi yang diterima oleh seseorang melalui kontak formal dengan individu atau kelompok.

b) Keadaan dan kualitas bayi

Kondisi bayi dapat menyebabkan munculnya baby blues sindrom misalnya jenis kelamin yang tidak sesuai harapan, bayi dengan cacat bawaan ataupun kesehatan yang kurang baik.

c) Komplikasi kelahiran

Proses persalinan juga dapat mempengaruhi munculnya baby blues sindrom, misalnya proses persalinan yang sulit, perdarahan, pecah ketuban dan bayi dengan posisi tidak normal.

d) Persiapan untuk persalinan dan menjadi ibu

Kehamilan yang tidak diharapkan seperti hamil diluar nikah, kehamilan akibat pemerkosaan, kehamilan yang tidak terencana sehingga wanita tersebut belum siap untuk menjadi ibu. Kesiapan menyambut kehamilan dicerminkan dalam kesiapan dan respon emosionalnya dalam menerima kehamilan. Seorang wanita memandang sebagai suatu hasil alami hubungan perkawinan baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan, tergantung dengan keadaan. Sebagian wanita lain menerima kehamilan sebagai kehendak alam dan bahkan pada beberapa wanita termasuk banyak remaja, kehamilan merupakan akibat percobaan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi. Awalnya mereka terkejut ketika tahu bahwa dirinya hamil, namun seiring waktu mereka akan menerima kehadiran

seorang anak.

e) Stresor psikososial

Faktor psikososial seperti umur, latar belakang sosial, ekonomi, tingkat pendidikan dan respon ketahanan terhadap stresor juga dapat mempengaruhi baby blues sindrom.

f) Riwayat depresi

Riwayat depresi atau problem emosional lain sebelum persalinan, seorang dengan riwayat problem emosional sangat rentan untuk mengalami baby blues sindrom.

g) Hormonal

Perubahan kadar hormon progesteron yang menurun disertai peningkatan hormon estrogen, prolaktin dan kortisol yang drastis dapat mempengaruhi kondisi psikolog ibu.

h) Budaya

Pengaruh budaya sangat kuat menentukan muncul atau tidaknya baby blues sindrom. Di Eropa kecenderungan baby blues sindrom lebih tinggi bila dibandingkan dengan Asia, karena budaya timur yang lebih dapat menerima atau berkompromi dengan situasi yang sulit daripada budaya barat (Antoniou et al., 2021).

C. Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan kesehatan mental pada perinatal?
2. Ada berapakah jenis perinatal mood and anxiety disorders? Sebutkan.
3. Sebutkan perubahan emosi pada masa kehamilan (antenatal) trimester pertama!
4. Sebutkan perubahan emosi pada masa nifas!
5. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan emosi selama nifas!

D. Kunci Jawaban

1. Kesehatan mental perinatal adalah gangguan kejiwaan yang sering terjadi pada wanita selama kehamilan dan hingga satu tahun setelah melahirkan. Hal ini mencakup berbagai masalah seperti baby blues, gangguan kecemasan, depresi pascapersalinan, dan psikosis pascapersalinan. Gangguan ini mempengaruhi ibu dan bayi, dan penting untuk dikenali dan ditangani dengan tepat. Kesehatan mental adalah keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan/kelemahannya, kemampuan menghadapi

masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidup.

2. Perinatal mood and anxiety disorders diklasifikasikan menjadi 6 adalah baby blues, depresi postpartum, psikosis, gangguan panik, gangguan obsesif-kompulsif, gangguan stres pasca trauma
3. Perubahan emosi pada masa kehamilan (antenatal) trimester pertama yaitu:
 - a. Kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan.
 - b. Kecemasan, kekecewaan.
 - c. Ambivalensi.
 - d. Emosi yang labil (misalnya episode kesedihan yang diperparah oleh kejadian fisiologis seperti mual, muntah, dan kelelahan).
 - e. Peningkatan feminitas
4. Perubahan emosi normal pada masa nifas bersifat pilihan dan kompleks dan mungkin meliputi hal-hal berikut:
 - a. Perasaan yang kontradiktif dan bertentangan mulai dari kepuasan, kegembiraan, kebahagiaan hingga kelelahan, ketidakberdayaan dan kekecewaan karena pada beberapa minggu pertama tampak didominasi oleh hal yang baru dan asing yang tidak terduga.
 - b. Kelegaan, 'syukurlah semua telah berakhir', mungkin diungkapkan oleh kebanyakan ibu segera setelah kelahiran, kadang-kadang ibu menanggapi secara dingin terhadap peristiwa yang baru terjadi, terutama bila ibu mengalami persalinan lama dengan komplikasi yang sulit.
 - c. Beberapa ibu mungkin merasa dekat dengan pasangan dan bayi, beberapa ibu ingin segera merasakan adanya kontak kulit-ke-kulit (skin to skin contact) dan segera menyusui.
 - d. Tidak tertarik atau sangat perhatian terhadap bayi.
 - e. Takut terhadap hal yang tidak diketahui dan terhadap tanggungjawab yang sangat berat dan mendadak.
 - f. Kelelahan dan peningkatan emosi.
 - g. Ketidaknyamanan karena nyeri (misalnya nyeri perineum, nyeri puting susu, dan lain-lain)
 - h. Peningkatan kerentanan, tidak mampu memutuskan (misalnya menyusui), rasa kehilangan, libido, gangguan tidur, kecemasan, dan lain-lain.
 - i. Postnatal blues atau postpartum blues
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan emosi selama nifas, yaitu:
 - a. Perubahan hormonal
Pasca melahirkan terjadi penurunan kadar estrogen dan progesterone yang drastis, dan juga disertai penurunan kadar hormon yang dihasilkan oleh

kelenjar tiroid yang menyebabkan mudah lelah, penurunan mood, dan perasaan tertekan.

b. Fisik

Kehadiran bayi dalam keluarga menyebabkan perubahan ritme kehidupan sosial dalam keluarga, terutama ibu. Mengasuh si kecil sepanjang siang dan malam sangat menguras energi ibu, menyebabkan berjurangnya waktu istirahat, sehingga terjadi penurunan ketahanan dalam menghadapi masalah.

c. Psikis

Kecemasan terhadap dalam berbagai hal, seperti ketidakmampuan dalam mengurus si kecil, ketidakmampuan dalam berbagai permasalahan, rasa tidak percaya diri karena perubahan bentuk tubuh dan sebelum hamil serta kurangnya perhatian terutama suami ikut mempengaruhi terjadinya depresi.

d. Sosial

Perubahan gaya hidup dengan peran sebagai ibu baru butuh adaptasi. Rasa ketertarikan yang sangat pada si kecil dan rasa dijauhi oleh lingkungan juga berperan dalam depresi.

Penyebab baby blues diduga karena perubahan hormonal di dalam tubuh wanita setelah melalui persalinan. Selama menjalani kehamilan, berbagai hormon dalam tubuh ibu meningkat seiring pertumbuhan janin. Setelah melalui tahap persalinan, jumlah produksi berbagai hormon seperti estrogen, progesteron, dan endorfin mengalami perubahan yang mempengaruhi kondisi emosional ibu. Kelelahan fisik dan rasa sakit setelah persalinan, air susu yang belum keluar sehingga bayi menjadi alasan lain timbulnya baby blues.

E. Rangkuman Materi

Kesehatan mental perinatal adalah gangguan kejiwaan yang sering terjadi pada wanita selama kehamilan dan hingga satu tahun setelah melahirkan. Hal ini mencakup berbagai masalah seperti baby blues, gangguan kecemasan, depresi pascapersalinan, dan psikosis pascapersalinan. Gangguan ini dapat mempengaruhi ibu dan bayi, dan penting untuk dikenali dan ditangani dengan tepat. Kesehatan mental adalah keadaan dimana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan/kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidup.

Perubahan emosi sangat banyak dan beragam, karena ibu dihadapkan pada berbagai pengambilan keputusan yang perlu diambil, sehingga merupakan hal yang fisiologis jika ibu mengalami periode kebingungan dan krisis kepercayaan diri. Kenyataannya banyak ibu yang mengalami fluktuasi antara emosi positif dan negatif. Ketika bidan melakukan pengkajian pada perubahan emosi dan psikologis ibu postpartum, maka bidan perlu mengingat bahwa perubahan emosi dan psikologis yang terjadi pada masa postpartum sangat dipengaruhi perubahan-perubahan emosi dan psikologis tahap sebelumnya dan bagaimana adaptasinya, yaitu pada tahap kehamilan (antenatal) dan tahap persalinan (intranatal).

F. Glosarium

APA	: <i>American Psychiatric Association</i>
DSM	: <i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder</i>
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
PPDGJ	: Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa
PMADs	: <i>Perinatal Mood and Anxiety Disorders</i>

G. Daftar Pustaka

- Alini, A., Meisyalla, L. N., & Novrika, B. (2024). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesehatan Mental Ibu Hamil di Desa Pulau Rambai. *Jurnal Ners*, 8(1), 178-186. <https://doi.org/10.31004/jn.v8i1.23506>
- Antoniou, E., Stamoulou, P., Tzanoulidou, M. D., & Orovou, E. (2021). Perinatal mental health; the role and the effect of the partner: a systematic review. In *Healthcare* (Vol. 9, No. 11, p. 1572). MDPI. <https://doi.org/10.3390/healthcare9111572>
- Arumsari, D. R., Sukma, F., & Istiananingsih, Y. (2023). Kesehatan Mental Perinatal Dan Luaran Menyusui. *NERSMID: Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*, 6(1), 96-113. <https://doi.org/10.55173/nersmid.v6i1.142>
- Griffen, A., McIntyre, L., Belsito, J. Z., Burkhard, J., Davis, W., Kimmel, M., ... & Meltzer-Brody, S. (2021). Perinatal Mental Health Care In The United States: An Overview Of Policies And Programs: Study examines perinatal mental health care policies and programs in the United States. *Health Affairs*, 40(10), 1543-1550. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.00796>
- Herbert, D., Young, K., Pietrusińska, M., & MacBeth, A. (2022). The mental health impact of perinatal loss: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 297, 118-129. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.10.026>
- Howard, L. M., & Khalifeh, H. (2020). Perinatal mental health: a review of progress and challenges. *World Psychiatry*, 19(3), 313-327. <https://doi.org/10.1002/wps.20769>
- Law, S., Ormel, I., Babinski, S., Plett, D., Dionne, E., Schwartz, H., & Rozmovits, L.

- (2021). Dread and solace: Talking about perinatal mental health. *International Journal of Mental Health Nursing*, 30, 1376-1385. <https://doi.org/10.1111/inm.12884>
- Lustiani, I., Fairuza, F., & Ummu, S. (2024). Asuhan Kebidanan Holistik dengan Pendekatan Continuity of Care Terhadap Kesehatan Mental Ibu Postpartum. *Jurnal Kesehatan Mercusuar*, 7(2), 155-161. <https://doi.org/10.36984/jkm.v7i2.536>
- Moore, J. E., McLemore, M. R., Glenn, N., & Zivin, K. (2021). Policy Opportunities To Improve Prevention, Diagnosis, And Treatment Of Perinatal Mental Health Conditions: Study examines policy opportunities to improve prevention, diagnosis, and treatment of perinatal mental health. *Health Affairs*, 40(10), 1534-1542. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.00779>
- Savitri, E. N., Hayatiin, E. N., & Daryanti, M. S. (2022). Scoping Review: Layanan perinatal mental health oleh bidan di Negara Asean. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 8(2), 115-130. <https://doi.org/10.33490/jkm.v8i2.479>

BAB 10

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN EMOSI SELAMA KEHAMILAN, PERSALINAN, DAN NIFAS, TANTANGAN KESEHATAN MENTAL DALAM PERIODE KEHAMILAN, PERSALINAN, DAN NIFAS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

- Mampu memberikan asuhan kebidanan yang holistik dengan memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan budaya dalam setiap tahap kehidupan reproduksi perempuan.
- Mampu menjalin komunikasi terapeutik dan memberikan dukungan emosional kepada perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas.
- Mampu mengidentifikasi faktor risiko dan tantangan psikologis yang mungkin timbul selama periode perinatal serta memberikan edukasi dan rujukan yang sesuai.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi perubahan emosi selama kehamilan, persalinan, dan nifas.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan kesehatan mental yang umum terjadi dalam periode perinatal.
- Mahasiswa mampu merancang pendekatan edukatif dan preventif untuk menjaga kesehatan mental ibu selama kehamilan hingga masa nifas.

Sub-CPMK

- Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan hormonal dan fisiologis yang berdampak pada kondisi emosi selama kehamilan.
- Mahasiswa mampu menganalisis peran dukungan sosial, relasi pasangan, dan kondisi sosio-ekonomi terhadap stabilitas emosional ibu.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi gejala stres, kecemasan, atau depresi yang umum terjadi selama kehamilan dan setelah melahirkan.

- Mahasiswa mampu menyusun strategi pendekatan psikososial yang dapat diberikan bidan sebagai bentuk promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan mental ibu.

Pendahuluan

Periode perinatal, yang mencakup masa kehamilan, persalinan, dan nifas, adalah fase yang penuh perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial dalam kehidupan seorang perempuan. Selama masa ini, perempuan mengalami berbagai dinamika emosional yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Ketidakseimbangan hormon, perubahan peran, dinamika keluarga, serta ekspektasi sosial dapat memicu fluktuasi emosi yang signifikan. Ketidakmampuan dalam mengelola perubahan emosi ini dapat berdampak pada kesehatan mental ibu dan proses adaptasi terhadap peran sebagai orang tua.

Pemahaman terhadap faktor yang memengaruhi perubahan emosi serta tantangan kesehatan mental pada periode ini sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan. Bidan memiliki peran strategis dalam deteksi dini, pemberian edukasi, dukungan psikososial, serta rujukan yang tepat bila diperlukan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa kebidanan untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aspek psikologis pada masa perinatal.

A. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Emosi Selama Kehamilan, Persalinan, dan Nifas

Perubahan emosi selama masa perinatal merupakan hal yang umum terjadi dan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Biologis

a. Perubahan hormone

Selama kehamilan, tubuh mengalami peningkatan drastis terhadap sejumlah hormon, seperti estrogen, progesteron, oksitosin, dan prolaktin.

- 1) Estrogen dan progesteron sangat berperan dalam menjaga kehamilan, namun peningkatannya juga memengaruhi sistem saraf pusat, yang berdampak pada perubahan mood, perasaan cemas, atau bahkan depresi ringan.
- 2) Oksitosin, hormon yang merangsang kontraksi saat persalinan dan meningkatkan ikatan ibu-bayi, juga dapat menyebabkan fluktuasi emosi.
- 3) Prolaktin, hormon pemicu produksi ASI, memengaruhi tidur dan kestabilan emosi.
- 4) Kombinasi hormon-hormon ini bisa menyebabkan ibu mengalami emosi yang tidak stabil, menangis tanpa alasan, mudah tersinggung, atau merasa sangat sensitif.

b. Kondisi fisik

Perubahan fisik selama kehamilan seperti mual, muntah, nyeri punggung, kelelahan, insomnia, dan peningkatan berat badan juga memengaruhi kenyamanan ibu. Ketidaknyamanan fisik ini sering kali memperburuk emosi, membuat ibu merasa frustrasi, tidak berdaya, atau marah. Ketika tubuh lelah, kemampuan untuk mengontrol emosi juga menurun.

2. Faktor Psikologis

a. Kecemasan akan peran baru sebagai ibu

Calon ibu sering kali merasa khawatir apakah mereka mampu menjalani peran baru ini dengan baik. Mereka mungkin merasa tidak siap, tidak tahu bagaimana merawat bayi, atau khawatir kehilangan identitas diri sebagai individu. Perasaan ini bisa menimbulkan stres, keraguan diri, hingga gangguan kecemasan.

b. Pengalaman sebelumnya (trauma persalinan, keguguran)

Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan seperti keguguran, kehamilan ektopik, atau trauma saat persalinan sebelumnya dapat menimbulkan ketakutan mendalam terhadap kehamilan dan persalinan saat

ini. Trauma yang belum terselesaikan dapat memunculkan kembali emosi negatif yang memperburuk kondisi mental ibu.

c. Riwayat gangguan mental

Ibu yang memiliki riwayat depresi, gangguan kecemasan, atau bipolar sebelumnya memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan emosi selama kehamilan dan masa nifas. Masa perinatal dapat menjadi pemicu kekambuhan, apalagi jika tidak ada dukungan yang memadai atau jika pengobatan dihentikan.

3. Faktor Sosial

Lingkungan sosial ibu, termasuk dukungan dari keluarga dan pasangan, memiliki peran protektif maupun risiko terhadap kestabilan emosi.

a. Dukungan pasangan dan keluarga

Kehadiran dan dukungan emosional dari pasangan sangat penting bagi kestabilan mental ibu. Ketika pasangan bersikap suportif, membantu, dan terlibat dalam proses kehamilan dan perawatan bayi, ibu akan merasa lebih tenang dan percaya diri. Sebaliknya, konflik rumah tangga, ketidakhadiran pasangan, atau penolakan keluarga dapat memperburuk kondisi emosional.

b. Status ekonomi dan pekerjaan

Kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi sumber stres tersendiri bagi ibu hamil dan menyusui. Kekhawatiran akan biaya persalinan, pemenuhan kebutuhan bayi, serta keamanan pekerjaan (khususnya bagi ibu pekerja) dapat memicu perasaan cemas dan tidak aman. Ketidakpastian ini bisa menyebabkan gangguan tidur, mudah marah, dan menarik diri dari lingkungan sosial.

c. Budaya dan nilai-nilai masyarakat mengenai peran ibu

Dalam beberapa budaya, peran ibu sangat ditekankan, bahkan idealisasi ibu sebagai sosok yang sempurna membuat ibu merasa tertekan. Harapan masyarakat agar ibu selalu sabar, bahagia, dan penuh pengorbanan dapat membuat ibu merasa bersalah jika mereka mengalami kelelahan, amarah, atau ingin waktu untuk diri sendiri. Stigma terhadap "ibu yang gagal" dapat memicu depresi dan krisis identitas.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan sekitar dan perkembangan teknologi juga memengaruhi kondisi emosional ibu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

a. Akses terhadap layanan kesehatan

Ibu yang tinggal di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas, tidak memiliki asuransi, atau sulit mengakses bidan/dokter mengalami rasa cemas berlebih. Mereka merasa tidak aman jika terjadi komplikasi, atau bingung mencari

informasi tentang kehamilan dan bayi. Ketidakpastian dan ketakutan ini dapat menciptakan ketegangan mental yang besar.

b. Pengaruh media sosial dan informasi digital

Media sosial bisa menjadi sumber informasi, tetapi juga sumber tekanan. Banyak ibu yang merasa “tidak cukup baik” ketika melihat ibu lain yang tampak bahagia, bugar, dan sukses mengasuh anak tanpa kesulitan. Perbandingan sosial yang tidak realistis ini menimbulkan rasa tidak percaya diri, iri, dan sedih. Selain itu, informasi yang salah atau menyesatkan di internet juga dapat membuat ibu semakin bingung dan cemas.

Bidan harus peka terhadap perubahan emosi ini untuk memberikan pendekatan yang empatik dan mendukung adaptasi ibu secara positif.

B. Tantangan Kesehatan Mental dalam Periode Kehamilan, Persalinan, dan Nifas

Masa perinatal adalah masa transisi besar dalam kehidupan seorang perempuan, mencakup fase kehamilan, proses persalinan, dan masa nifas (postpartum). Selama periode ini, tidak hanya terjadi perubahan biologis dan sosial, tetapi juga tekanan psikologis yang luar biasa. Berbagai tantangan emosional dan mental dapat muncul, dan jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi mengganggu kesehatan ibu, perkembangan anak, dan dinamika keluarga.

Beberapa tantangan psikologis yang sering dialami oleh ibu pada masa perinatal meliputi:

1. Stres dan Kecemasan Perinatal

Stres dan kecemasan merupakan keluhan yang paling sering dirasakan oleh ibu selama kehamilan hingga setelah melahirkan.

Ketakutan akan proses persalinan – apakah akan berjalan lancar, apakah akan terasa sangat menyakitkan, atau apakah bayi akan lahir dengan selamat – menjadi sumber kecemasan utama. Selain itu, ketidakpastian mengenai kondisi janin, hasil pemeriksaan kehamilan, atau kekhawatiran tentang kemungkinan cacat bawaan juga meningkatkan beban mental ibu.

Kecemasan ini seringkali diperparah oleh perasaan tidak yakin terhadap kemampuan diri sendiri dalam menjalani peran sebagai ibu. Banyak perempuan merasa takut apakah mereka akan mampu merawat bayi dengan baik, memahami kebutuhannya, atau menghadapi perubahan hidup yang drastis. Apabila dibiarkan, kecemasan ini bisa mengganggu kualitas tidur, hubungan dengan pasangan, dan konsentrasi dalam aktivitas sehari-hari.

2. Depresi Antenatal dan Postpartum

Depresi antenatal adalah gangguan suasana hati yang terjadi selama kehamilan, sedangkan depresi postpartum muncul setelah melahirkan. Keduanya ditandai dengan gejala seperti:

- a. Perasaan sedih yang menetap dan mendalam
- b. Kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya menyenangkan
- c. Penurunan energi dan motivasi
- d. Gangguan tidur (insomnia atau hipersomnia)
- e. Perasaan bersalah berlebihan, tidak berguna, bahkan muncul pikiran untuk menyakiti diri atau bayi

Depresi perinatal sering kali tidak terdeteksi karena dianggap sebagai “hal biasa” akibat kelelahan atau perubahan hormonal. Padahal, jika tidak ditangani secara tepat, kondisi ini bisa berdampak serius terhadap kemampuan ibu untuk menjalin ikatan dengan bayinya dan menjalani perannya sebagai pengasuh utama.

3. Baby Blues

Baby blues adalah kondisi emosional yang sangat umum dan terjadi pada sekitar 70–80% ibu setelah melahirkan, terutama pada 2 hingga 14 hari pertama postpartum.

Gejala utamanya antara lain:

- a. Mudah menangis tanpa sebab yang jelas
- b. Rasa cemas dan gelisah
- c. Mudah tersinggung
- d. Merasa kewalahan dan tidak percaya diri

Meskipun baby blues biasanya akan membaik dengan sendirinya tanpa intervensi medis, kondisi ini tetap perlu mendapat perhatian. Jika berlangsung lebih dari dua minggu, atau disertai dengan gejala depresi berat, maka bisa berkembang menjadi depresi postpartum, yang membutuhkan evaluasi profesional.

4. Risiko Gangguan Kecemasan atau PTSD

Beberapa ibu mengalami gangguan kecemasan berat atau bahkan PTSD sebagai akibat dari pengalaman kehamilan atau persalinan yang traumatis.

Hal ini dapat disebabkan oleh:

- a. Proses persalinan yang sangat menyakitkan atau tidak sesuai harapan
- b. Komplikasi serius (misalnya perdarahan hebat, preeklamsia, bayi yang harus dirawat di NICU)
- c. Pengalaman buruk dengan tenaga medis atau rasa kehilangan kontrol saat melahirkan

PTSD pada ibu bisa muncul dengan gejala seperti kilas balik terhadap pengalaman buruk saat persalinan, mimpi buruk, dan menghindari segala sesuatu yang mengingatkan pada pengalaman tersebut. Jika tidak ditangani, PTSD dapat memengaruhi bonding dengan bayi dan memperburuk kesejahteraan psikologis ibu.

5. Kurangnya Dukungan Sosial

Perasaan kesepian dan tidak didukung merupakan pemicu besar bagi gangguan kesehatan mental pada ibu.

Ibu yang menjalani kehamilan atau merawat bayi tanpa kehadiran pasangan, tinggal jauh dari keluarga, atau berada di lingkungan yang tidak suportif akan merasa terisolasi. Kurangnya bantuan praktis seperti dukungan dalam mengurus rumah, menyusui, atau sekadar teman bicara dapat memperparah rasa kelelahan emosional yang dialami.

Dukungan sosial yang kuat – baik dari pasangan, keluarga, teman sebaya, maupun komunitas ibu – terbukti mampu menurunkan risiko depresi perinatal dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalani peran sebagai ibu.

6. Stigma terhadap Gangguan Mental

Salah satu hambatan besar dalam penanganan gangguan mental pada masa perinatal adalah stigma sosial yang masih kuat. Banyak perempuan merasa takut atau malu untuk mengungkapkan bahwa mereka mengalami kesulitan emosional, karena khawatir dianggap lemah, tidak bersyukur, atau gagal menjadi ibu yang baik.

Stigma ini dapat menyebabkan ibu menyembunyikan kondisinya, tidak mencari pertolongan, atau merasa bersalah atas perasaan negatif yang mereka alami. Padahal, mengakui adanya masalah adalah langkah pertama yang penting menuju pemulihan. Tenaga kesehatan, termasuk bidan, harus berperan aktif dalam membuka ruang aman bagi ibu untuk berbicara dan mendapatkan bantuan psikologis tanpa takut dihakimi.

C. Latihan Soal

Soal 1

Seorang perempuan usia 27 tahun, G1P0A0, hamil 34 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan sering menangis tanpa sebab, merasa sangat sensitif, dan mudah tersinggung. Ia mengaku sering merasa lelah, sulit tidur, dan merasa tidak percaya

diri untuk menjadi seorang ibu. Pemeriksaan fisik dan kehamilan dalam batas normal.

Apa faktor utama yang kemungkinan besar mempengaruhi kondisi emosional ibu tersebut?

- A. Kekurangan zat besi pada kehamilan trimester ketiga
- B. Ketidakseimbangan kadar glukosa dalam darah
- C. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron
- D. Penurunan hormon prolaktin selama kehamilan
- E. Infeksi saluran kemih yang tidak disadari

Kunci: C

Rasional:

Kondisi ibu yang menunjukkan gejala emosional seperti mudah menangis, sensitif, dan sulit tidur dapat dikaitkan dengan perubahan hormonal, khususnya peningkatan estrogen dan progesteron, yang sangat berpengaruh terhadap pusat pengatur emosi di otak selama trimester ketiga kehamilan.

Soal 2

Seorang ibu berusia 30 tahun datang ke bidan dua minggu pasca melahirkan. Ia menangis saat wawancara, mengaku merasa kewalahan, sering gelisah, dan mudah tersinggung terhadap pasangannya. Ia juga merasa tidak percaya diri sebagai seorang ibu, meskipun tidak ada tanda fisik atau kelainan medis.

Berdasarkan gejala tersebut, apa kemungkinan kondisi psikologis yang dialami ibu?

- A. Depresi postpartum berat
- B. Baby blues
- C. PTSD postpartum
- D. Psikosis puerperalis
- E. Gangguan bipolar

Kunci: B

Rasional:

Baby blues adalah gangguan emosional ringan yang umum terjadi dalam 2 minggu pertama pasca melahirkan, ditandai dengan gejala seperti menangis tanpa sebab, kecemasan ringan, mudah tersinggung, dan rasa kewalahan. Gejala biasanya hilang dengan sendirinya dan tidak mengganggu fungsi ibu secara signifikan.

Soal 3

Seorang ibu 29 tahun, G2P1A0, datang ke klinik 6 minggu setelah melahirkan anak keduanya. Ia mengeluh kehilangan minat dalam merawat bayinya, merasa tidak

berguna, dan sempat berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Ia memiliki riwayat depresi saat kehamilan sebelumnya namun tidak pernah mendapatkan terapi.

Apa diagnosis yang paling tepat untuk kondisi ini?

- A. Depresi postpartum
- B. Gangguan cemas umum
- C. Baby blues
- D. Stres kehamilan
- E. PTSD pascapersalinan

Kunci: A

Rasional:

Gejala berupa kehilangan minat, perasaan tidak berguna, dan pikiran menyakiti diri sendiri adalah ciri khas depresi postpartum. Riwayat depresi antenatal meningkatkan risiko terjadinya kondisi ini. Berbeda dengan baby blues, depresi postpartum membutuhkan penanganan medis dan psikologis.

Soal 4

Seorang ibu primigravida usia 26 tahun tampak sangat cemas saat kontrol ANC trimester kedua. Ia terus menanyakan kemungkinan cacat janin, merasa takut menghadapi proses persalinan, dan menyampaikan bahwa ia tidak yakin bisa menjadi ibu yang baik.

Apa tindakan awal paling tepat yang dilakukan oleh bidan dalam situasi ini?

- A. Memberikan obat penenang agar ibu bisa tidur
- B. Mengacu ibu ke bagian kejiwaan tanpa penjelasan
- C. Memberikan edukasi dan dukungan psikologis dasar
- D. Menyarankan untuk segera berhenti bekerja
- E. Membiarkan ibu agar menyadari kondisinya sendiri

Kunci: C

Rasional:

Tindakan paling tepat yang dilakukan bidan adalah memberikan dukungan psikologis dasar, validasi perasaan ibu, dan edukasi bahwa kecemasan ringan adalah hal yang umum. Jika gejala berlanjut atau memburuk, baru dilakukan rujukan ke psikolog/psikiater.

Soal 5

Seorang perempuan usia 32 tahun, baru melahirkan secara emergensi karena preeklamsia berat. Saat kontrol nifas hari ke-10, ia menunjukkan gejala kilas balik (flashback) terhadap kejadian persalinan, mimpi buruk, dan menghindari berbicara tentang kejadian tersebut.

Apa diagnosis psikologis yang paling mungkin dialami ibu ini?

- A. Depresi postpartum
- B. Gangguan tidur ringan pascamelahirkan
- C. Baby blues
- D. PTSD postpartum
- E. Gangguan adaptasi

Kunci: D

Rasional:

PTSD postpartum dapat terjadi setelah pengalaman persalinan traumatis, seperti preeklamsia berat atau tindakan emergensi. Gejalanya mencakup flashback, mimpi buruk, dan penghindaran topik terkait trauma, serta kecemasan tinggi. Diagnosis ini memerlukan evaluasi dan terapi profesional.

D. Rangkuman Materi

Perubahan emosi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan respons alami tubuh terhadap serangkaian transformasi biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan yang kompleks. Faktor biologis seperti fluktuasi hormon (estrogen, progesteron, oksitosin, dan prolaktin) serta perubahan fisik (mual, kelelahan, nyeri) memainkan peran besar dalam ketidakstabilan emosional. Di sisi lain, faktor psikologis seperti kecemasan akan peran baru, trauma masa lalu, dan riwayat gangguan mental juga sangat memengaruhi kesejahteraan emosional ibu. Dukungan sosial dari pasangan dan keluarga, kondisi ekonomi, serta konstruksi budaya mengenai "peran ideal ibu" turut membentuk persepsi diri ibu dan dapat memperkuat atau justru memperburuk kondisi emosinya. Lingkungan eksternal, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan paparan media sosial, juga memiliki dampak signifikan dalam membentuk pengalaman emosional ibu selama masa perinatal.

Tantangan kesehatan mental yang dihadapi ibu pada periode ini sangat beragam, mulai dari stres dan kecemasan perinatal, depresi antenatal dan postpartum, baby blues, hingga risiko gangguan kecemasan berat atau PTSD akibat persalinan traumatis. Kurangnya dukungan sosial serta stigma terhadap gangguan mental kerap kali menjadi penghalang bagi ibu untuk mengakses bantuan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peran bidan menjadi sangat vital sebagai pendamping profesional yang tidak hanya memberikan layanan fisik, tetapi juga menghadirkan pendekatan yang empatik dan suportif terhadap kondisi emosional ibu. Upaya pencegahan, deteksi dini, dan intervensi tepat terhadap gangguan psikologis

perinatal sangat penting untuk mendukung kesehatan mental ibu, menjamin perkembangan optimal bayi, dan menjaga keseimbangan fungsi keluarga

E. Glosarium

Baby Blues

Kondisi emosional ringan yang umum terjadi dalam 2 minggu pertama setelah persalinan, ditandai dengan gejala seperti mudah menangis, gelisah, mudah tersinggung, dan perasaan kewalahan. Biasanya membaik tanpa penanganan medis.

Bidan

Tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, termasuk mendeteksi dan mendukung kesehatan mental ibu.

Depresi Antenatal

Gangguan suasana hati yang terjadi selama masa kehamilan, ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat, kelelahan, dan gangguan tidur atau makan.

Depresi Postpartum

Gangguan psikologis yang terjadi setelah melahirkan, lebih berat dari baby blues, dengan gejala seperti rasa tidak berharga, kehilangan minat merawat bayi, bahkan pikiran menyakiti diri atau bayi.

Dukungan Sosial

Bantuan emosional, fisik, dan praktis yang diberikan oleh pasangan, keluarga, teman, atau komunitas kepada ibu, yang berperan penting dalam menstabilkan kondisi emosional selama masa perinatal.

Estrogen dan Progesteron

Hormon reproduksi wanita yang mengalami peningkatan selama kehamilan. Peningkatan drastis dapat memengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan mood atau gejala depresi ringan.

Kecemasan Perinatal

Kondisi psikologis yang ditandai dengan rasa takut, cemas berlebihan, dan kekhawatiran terhadap kehamilan, persalinan, maupun kemampuan menjadi orang tua.

Masa Perinatal

Periode waktu yang mencakup masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas (pasca persalinan), yang merupakan fase transisi besar bagi seorang perempuan.

Media Sosial

Platform digital yang dapat menjadi sumber informasi maupun tekanan psikologis bagi ibu, terutama bila terjadi perbandingan sosial yang tidak realistis terhadap peran sebagai ibu.

Oksitosin

Hormon yang berperan dalam merangsang kontraksi saat persalinan serta memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi, namun juga dapat menyebabkan fluktuasi emosional.

Perubahan Emosi Perinatal

Gejala emosional yang dialami ibu akibat pengaruh hormonal, psikologis, sosial, dan lingkungan selama masa perinatal, seperti menangis tanpa sebab, mudah tersinggung, dan sensitif.

Prolaktin

Hormon yang merangsang produksi ASI, berpengaruh terhadap kualitas tidur dan kestabilan emosi ibu selama masa menyusui.

PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)

Gangguan stres pascatrauma yang dapat dialami ibu setelah mengalami persalinan atau kehamilan traumatis, ditandai dengan kilas balik, mimpi buruk, dan penghindaran.

Riwayat Gangguan Mental

Catatan masa lalu individu yang pernah mengalami gangguan psikologis seperti depresi, gangguan cemas, atau gangguan bipolar, yang menjadi faktor risiko terjadinya gangguan emosional saat perinatal.

Stigma

Pandangan negatif dari masyarakat terhadap kondisi gangguan mental, yang dapat menghambat ibu untuk mencari bantuan dan memperburuk kondisi emosionalnya.

Trauma Persalinan

Pengalaman menyakitkan atau menakutkan yang dialami ibu selama proses persalinan, seperti persalinan darurat, intervensi medis yang tidak diinginkan, atau kehilangan kontrol.

Transisi Peran

Perubahan identitas dan tanggung jawab yang terjadi ketika seorang perempuan memasuki peran baru sebagai ibu, yang dapat menjadi sumber tekanan dan ketidakpastian emosional.

F. Daftar Pustaka

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Beck, C. T. (2001). Predictors of postpartum depression: An update. *Nursing Research*, 50(5), 275–285. <https://doi.org/10.1097/00006199-200109000-00004>
- Dennis, C. L., & Dowswell, T. (2013). Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2, CD001134. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001134.pub3>
- Field, T. (2010). Postpartum depression effects on early interactions, parenting, and safety practices: A review. *Infant Behavior and Development*, 33(1), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2009.10.005>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kesehatan jiwa ibu hamil dan nifas*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Jiwa.
- Kozhimannil, K. B., Vogelsang, C. A., Hardeman, R. R., & Prasad, S. (2016). Disrupting the pathways of social determinants of health: Doula support during pregnancy and childbirth. *Journal of the American Board of Family Medicine*, 29(3), 308–317. <https://doi.org/10.3122/jabfm.2016.03.150300>
- Norhayati, M. N., Hazlina, N. H. N., Asrenee, A. R., & Emilin, W. M. A. W. (2015). Magnitude and risk factors for postpartum symptoms: A literature review. *Journal of Affective Disorders*, 175, 34–52. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.12.041>
- Soetjiningsih. (2012). *Tumbuh kembang anak*. Jakarta: EGC.
- Suryani, E., & Keliat, B. A. (2016). *Kesehatan mental ibu hamil dan nifas*. Jakarta: EGC.
- Yulianti, N., & Lestari, D. (2021). *Asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

PROFIL PENULIS



Bdn., Agriyaningsih Oktaviana H., S.Tr.Keb., M.Keb

Penulis lahir di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Pada Tanggal, 28 Oktober 1998. Penulis menyelesaikan pendidikan D-IV Kebidanan Pada Tahun 2020 di Poltekkes Kemenkes Kendari, Magister Kebidanan pada Tahun 2022 di Universitas Hasanuddin Makassar, dan Pendidikan Profesi Bidan pada Tahun 2024 di STIKes Abdi Nusantara Jakarta. Penulis merupakan dosen tetap di STIKes Salsabila Serang pada Program Studi Kebidanan. Berbagai karya ilmiah sudah dihasilkan oleh penulis yaitu Buku Referensi, Artikel Nasional dan Artikel Internasional. Motto penulis *"Strong Mentality Does Not Beat Patience"*



Dwi Ardani Rochmaniah, SST., M.Keb. Lahir di Madiun, 30 Maret 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Diploma III Kebidanan, Stikes Muhammadiyah Klaten tahun 2009. Selanjutnya menempuh jenjang D-IV pada Program Studi Diploma IV Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2019. Saat ini penulis bekerja di Stikes Bhakti Husada Mulia mengampu

mata kuliah Anatomi Fisiologi, Biologi Reproduksi, Promosi Kesehatan, Fisika Kesehatan, Dokumentasi Kebidanan dan Humaniora dalam praktik kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dwiardani.rochmaniah1@gmail.com

Motto: *"from zero to hero"* and *"inna ma'al usri yusroo"*

PROFIL PENULIS



Bdn. Emi Br Barus, S.ST., M.Keb. Merupakan Dosen Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan Sumatera Utara (INKES SUMUT). Lahir di Rumah Sumbul 13 Nopember 1987. Pendidikan yang telah di tempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Pada Program Studi Bidan Pendidik di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Kebidanan Pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan lulus tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan di INKES SUMUT dan Lulus 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009-2011 sebagai Bidan Pelaksana di Praktik Bidan. Tahun 2011-2025 (sekarang) Dosen di prodi Diploma - III Kebidanan, Sarjana Kebidanan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan INKES SUMUT. Dan Dosen Tamu di Akademi Kebidanan Nusantara 2000 Tahun TA 2017/2018. Penulis aktif dalam kegiatan tri dharma Pendidikan dan mengampu mata kuliah Evidence Based Dalam Kebidanan, Komunikasi Efektif, Asuhan Kebidanan Pada Nifas, dan Fisiologi Kehamilan, Bersalin, Nifas dan BBL. Penulis juga aktif dalam Penelitian dan memenangkan beberapa hibah penelitian dari Kemenristekdikti serta terpublikasi pada Jurnal Scopus Q3 dan Terindeks Sinta 2-6. Penulis juga aktif melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dan terpublikasi terindeks sinta. Penulis dapat di hubungi melalui e-mail : emibarus@gmail.com



Uliyatul Laili, SST.Bdn., M.Keb. lahir di Sidoarjo, pada 15 Mei 1987. Ia tercatat sebagai lulusan Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2014 pada program Magister Kebidanan. Wanita yang kerap disapa Uli ini adalah anak dari pasangan M.Usman (ayah) dan Mucholisnah (ibu). Uliyatul Laili berprofesi sebagai Dosen pada PTS sejak tahun 2012 dan mulai menulis beberapa artikel penelitian yang telah terbit pada jurnal-jurnal nasional dan internasional.

PROFIL PENULIS



Asima Lamtiar Hotnauli Pakpahan, S.Tr.Keb.,M.Keb. lahir di Pintu Angin, 29 Juni 1990. Penulis menyelesaikan program Diploma III Kebidanan di Akademi Kebidanan Imelda Medan. Setelah lulus dari program Diploma III kebidanan, penulis melanjutkan studi di Program Diploma IV Kebidanan di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Setelah menyelesaikan program Diploma IV Kebidanan, penulis melanjutkan studi Magister Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada Bandung dan lulus pada Tahun 2023. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Columbia Asia Medan Program Studi Kebidanan.



Wahyu Nindi Sayekti, S.ST., M.Keb Lahir di Surya Adi, 28 Januari 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Program Studi Kebidanan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada. Kemudian lanjut pendidikan DIV pada Program Studi Bidan Pendidik, Universitas Respati Yogyakarta tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kebidanan pada Universitas Hasanuddin dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 sampai tahun 2022 di IKest MP. Kemudian pada tahun 2023 saya menjadi dosen tetap Program Studi Sarjana dan Profesi Bidan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada di Palembang sampai saat ini. Saat ini mengampu mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan dan Nifas dalam kebidanan, mata kuliah Psikologi Kehamilan, Persalinan dan Nifas dalam Kebidanan, dan mata kuliah Evidence Based dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku Panduan Kesehatan Ibu dan Anak, dan berbagai publikasi terkait tentang terapi komplementer dalam kebidanan, serta publikasi seputar gizi dan anemia pada anak. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wahyunindi95@gmail.com
Motto: "Jalani Kehidupan dengan Senyum, Sabar dan Syukur"

PROFIL PENULIS



Iin Tri Marlinawati, S.Tr.Keb., MPH., M.Keb. Lahir di Sragen, 01 Maret 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV pada Program Studi D-IV Kebidanan, Universitas Ngudi Waluyo tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Ibu dan Anak) di Universitas Sebelas Maret dan lulus pada tahun 2017, serta S2 Kebidanan di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2022.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai dosen di STIKes Faathir Husada Tangerang. Saat ini penulis bekerja di STIKes Bakti Utama Pati, *homebase* di Prodi Pendidikan Profesi Bidan, mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Nifas, Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan pada Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar yang berkaitan dengan kebidanan, terutama Asuhan Kebidanan pada Nifas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: iin3marlina@gmail.com.

Motto: *"Life is a beautiful struggle"*



Eny Siswati, Lahir di Jombang, 18 Agustus 1979. Saya pertama kali menempuh Pendidikan Kesehatan di sekolah perawat Kesehatan Tahun 1998, Melanjutkan studi D4 kebidanan di Stikes Husada Jombang, Kemudian melanjutkan Studi Megister Sains Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian di tahun 2021 saya melanjutkan sekolah Bidan Profesi di Stikes Husada jombang. Perjalanan karir saya dimulai dengan bekerja di pelayaran Kesehatan, di mana saya memperoleh pengalaman berharga dalam dunia kesehatan. Setelah itu, saya memutuskan untuk melanjutkan karir di bidang pendidikan, khususnya di bidang kebidanan untuk mejadi Dosen, di Akademi Kebidanan Sukowati. Seiring waktu, pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh membawa saya untuk berkarir sebagai dosen tetap di STIKES Husada Jombang, di mana saya berkesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan mahasiswa dalam dunia pendidikan kebidanan. Selain itu, ia juga aktif mengikuti Organisasi IBI.

PROFIL PENULIS



Fitria Jannatul Laili, S.Keb., Bd., MM., M.Keb. lahir di Jember, 19 Juni 1985. Saat ini penulis tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari Diploma III Kebidanan di Prodi DIII Kebidanan Sutomo Poltekkes Kemenkes Surabaya (lulus 2007), S1 Kebidanan di Prodi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Lulus 2010), Pendidikan Profesi Bidan di Prodi Pendidikan Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Lulus 2011), S2 Magister Manajemen di Prodi Magister Manajemen STIE Indonesia Malang (Lulus 2013), dan S2 Kebidanan di Prodi Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (Lulus 2018). Penulis pernah bekerja di STIKES dr. Soebandi Jember (Universitas dr. Soebandi) sejak 2011 sampai dengan 2019, kemudian mengabdikan sebagai dosen PNS di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sejak 2019 sampai sekarang. Aktivitas penulis saat ini mengajar pada jenjang Diploma III dan Sarjana Terapan Kebidanan di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Fokus pada Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, Asuhan Kebidanan Komprehensif dan Berkelanjutan, Asuhan Kebidanan Kolaborasi pada Patologi dan Komplikasi Kebidanan, Model Pelayanan Kebidanan Profesional, dan Pemberdayaan Keluarga. Penulis saat ini juga sebagai reviewer beberapa Jurnal Nasional Terakreditasi dan Nasional, Tim Kurikulum Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, dan Tim Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Jalin kerja sama dengan penulis via surel fitria.jlaili@gmail.com

Sinopsis

Buku Psikologi dalam Praktik Kebidanan ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan untuk memahami dimensi psikologis yang menyertai proses reproduksi perempuan. Dimulai dari pembahasan psikologi pada masa reproduksi dan peran penting komunikasi ibu dan bayi, buku ini menjelaskan bagaimana dinamika psikososial dan proses adaptasi menjadi orang tua berkontribusi terhadap keberhasilan asuhan kebidanan yang holistik dan empatik.

Setiap bab menyajikan topik-topik penting seperti kesehatan mental perinatal, dukungan pengasuhan, manajemen risiko psikologis, serta pendekatan trauma-informed dalam praktik kebidanan. Buku ini juga membahas tantangan terkini, termasuk pengaruh media sosial, kepercayaan terhadap layanan kesehatan, serta stigma budaya yang menghambat akses ibu terhadap dukungan psikologis. Dengan pendekatan berbasis bukti dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya, buku ini menekankan pentingnya kolaborasi interprofesional dalam menangani masalah kesehatan mental ibu secara menyeluruh.

Buku ini dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman materi, glosarium, dan daftar pustaka pada setiap bab, yang bertujuan memperkuat pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis mahasiswa. Melalui struktur yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam pembelajaran psikologi kebidanan, serta mendukung terbentuknya tenaga bidan yang kompeten, berempati, dan peka terhadap isu-isu psikologis dalam praktik sehari-hari.

Buku Psikologi dalam Praktik Kebidanan ini dirancang sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan untuk memahami dimensi psikologis yang menyertai proses reproduksi perempuan. Dimulai dari pembahasan psikologi pada masa reproduksi dan peran penting komunikasi ibu dan bayi, buku ini menjelaskan bagaimana dinamika psikososial dan proses adaptasi menjadi orang tua berkontribusi terhadap keberhasilan asuhan kebidanan yang holistik dan empatik.

Setiap bab menyajikan topik-topik penting seperti kesehatan mental perinatal, dukungan pengasuhan, manajemen risiko psikologis, serta pendekatan trauma-informed dalam praktik kebidanan. Buku ini juga membahas tantangan terkini, termasuk pengaruh media sosial, kepercayaan terhadap layanan kesehatan, serta stigma budaya yang menghambat akses ibu terhadap dukungan psikologis. Dengan pendekatan berbasis bukti dan sensitif terhadap konteks sosial-budaya, buku ini menekankan pentingnya kolaborasi interprofesional dalam menangani masalah kesehatan mental ibu secara menyeluruh.

Buku ini dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman materi, glosarium, dan daftar pustaka pada setiap bab, yang bertujuan memperkuat pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis mahasiswa. Melalui struktur yang sistematis dan aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam pembelajaran psikologi kebidanan, serta mendukung terbentuknya tenaga bidan yang kompeten, berempati, dan peka terhadap isu-isu psikologis dalam praktik sehari-hari.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-02-9



9

786347

294029